

A. 65일 운영 내외과·산소치료 중심 야간진료 시스템 실행방안

1. 365일 야간진료 운영 모델 사례 (국내외)

365일 연중무휴로 야간진료를 운영한 국내외 사례를 살펴보면 다양한 모델이 존재합니다. 국내에서는 대표적으로 [달빛어린이병원](#) 모델이 있습니다. 달빛어린이병원은 소아청소년과 의원 또는 병원이 평일 밤 11-12시, 휴일은 오후 6-10시까지 365일 진료하는 형태로, 경증 소아 환자를 밤에도 돌볼 수 있게 보건당국이 지원하는 제도입니다 ([365일 야간에도 진료하는 '달빛어린이병원' 아세요? - 경향신문](#)) ([밤늦게 아이가 아프다면, 해매지 말고 '달빛어린이병원'! : 사회 : 경기도 ...](#)). 이를 통해 큰 병이 아닌 소아환자는 응급실 대신 이들 병원을 찾아 빠르고 저렴한 진료를 받을 수 있었고, 현재 전국에 걸쳐 지정 병원이 확대 운영되고 있습니다 ([밤늦게 아이가 아프다면, 해매지 말고 '달빛어린이병원'! : 사회 : 경기도 ...](#)). 성인 야간진료의 경우, 국내에는 일부 개인의원원이 자체적으로 연중무휴 야간진료를 표방하는 예가 있으나 (예: 'OO 365의원' 등), 아직 제도적으로 널리 확산된 모델은 드뭅니다. 다만 2025년부터 정부가 의원급의 야간진료 수가 인상 등 활성화 방안을 발표하여, 향후 지역 의원들의 자발적인 365일 야간진료 참여가 늘어날 것으로 기대됩니다 ([보건복지부, 야간 시간대 외래 진료 활성화 방안 발표...응급실 과밀화 완화 기대](#)) ([보건복지부, 야간 시간대 외래 진료 활성화 방안 발표...응급실 과밀화 완화 기대](#)).

해외사례로는 일본과 M/국의 모델을 참고할 수 있습니다.

일본의 경우 지자체와 의사회의 협력으로 공공 야간진료센터를 운영하는 경우가 많습니다. 예를 들어 도쿄 시부야구 의사회는 회원 의사들이 교대로 참여하는 “시부야 의사회 주민건강센터”를 통해 토요일 저녁 및 일요일·공휴일에 내과·소아과 환자를 위한 야간 응급외래를 제공합니다 ([Night & Holiday Consultation - Shibuya Medical Association](#)) ([Night & Holiday Consultation - Shibuya Medical Association](#)). 이 센터는 혈액검사나 X선 등 정밀검사는 하지 않고 1일분의 약만 처방하는 등 경증 환자 위주 최소한의 진료를 수행하며, 중증일 경우 다음날 주간의료기관이나 대형병원 응급실로 연계합니다 ([Night & Holiday Consultation - Shibuya Medical Association](#)) ([Night & Holiday Consultation - Shibuya Medical Association](#)). 또한 일본 요코하마시는 시내에 야간 구급센터를 여러 곳 운영하여 매일 20시부터 자정까지 내과·소아과 환자를 보고, 자정 이후에는 지정된 지역 병원이 교대로 환자를 받는 시스템을 갖추고 있습니다 ([If you suddenly fall sick at night or on a Sunday national holiday \(夜や日曜日や祝日に急に病気になったとき\) 横浜市](#)) ([If you suddenly fall sick at night or on a Sunday national holiday \(夜や日曜日や祝日に急に病気になったとき\) 横浜市](#)). 이러한 당번제 야간진료모델은 한 기관이 365일을 모두 담당하

지 않고 지역 의료기관들이 요일별로 분담함으로써, 결과적으로 지역 전체로는 365일 야간진료 체계를 유지하는 방식입니다.

한편 **미국에서는** 민간주도의 24/7 긴급진료(Urgent Care)클리닉이 운영되는 사례가 있습니다. Urgent Care는 낮은 응급도이지만 당장 치료가 필요한 환자들에게 응급실 대신 서비스를 제공하는 것으로, 골절, 염좌, 상처 봉합 등 비교적 경증 외상부터 감염 치료까지 폭넓게 다룹니다 ([Urgent Care Centers | Paragon Ventures](#)). 일부 Urgent Care 클리닉은 24시간 연중무휴로 운영되어 일종의 위성 응급실처럼 기능하기도 합니다 ([Urgent Care Centers | Paragon Ventures](#)). 예를 들어 미국의 Urgent Care 24/7 체인은 “365일 24시간 진료”를 표방하며 가정의학/내과 전문의가 상주하고, 환자 대기시간이 거의 없다는 점을 강조하여 운영되고 있습니다 ([Urgent Care 24/7 | Walk In Emergency Clinics | Urgent Care](#)) ([Urgent Care 24/7 | Walk In Emergency Clinics | Urgent Care](#)). 이러한 기관은 주로 보험에 얽매이지 않는 자비 지불 진료로 수익을 내며, 환자에게는 응급실 대비 저렴한 비용으로 접근성을 높이고 있습니다 ([Urgent Care Centers | Paragon Ventures](#)).

다음 표는 주요 야간진료 운영 사례를 정리한 것입니다:

운영 사례 및 지역	주요 특징
달빛어린이병원 (대한민국)	소아과 야간·휴일 외래진료, 정부 및 지자체 지원경증 소아환자 응급실 방문 감소
시부야 야간진료센터 (일본)	의사회 주관 공공심야 클리닉교대 당직 의사들이 내과·소아과 진료 (Night & Hol
요코하마 야간구급센터 (일시 운영 경증 응급환자 야간진료소지역병원과 연계 운영 (If you suddenly fall si	본) (病気になったとき) 横浜市)
UrgentCare 24/7 (미국)	민간 24시간 Urgent Care 체인지비 부담 기반 수익 모델 ([Urgent Care 24/7

이처럼 국내외 사례를 참고하면, 야간전담 외래센터를 독립적으로 설치하거나 지역 의료기관들의 **협력망**을 통해 365일 체계를 구축하는 등 여러 현실적인 운영전략을 수립할 수 있습니다.

2. 필요한 인력 구성 및 근무 교대 방식

365일 야간진료를 안정적으로 운영하기 위해서는 적절한 인력 구성과 교대 근무 체계를 수립하는 것이 핵심입니다. 일반적으로 야간진료시간대에는 환자 규모가 주간보다 적더라도, 응급 상황 대응을 위해 의료진 최소 인력이 확보되어야 합니다.

- **의사:** 최소 1명 이상의 진료의사가 상주해야 합니다. 내과 및 외과 적 처치(경증 외상 처치 등)를 모두 다룰 수 있는 **가정의학**과나 **응급의학과**, 내과전문의가 적합하며, 가능하다면 **외과계열**경력도 갖춘 의사가 배치되는 것이 바람직합니다. 미국의 Urgent Care 센터들도 운영 시간에 **항상 한 명 이상의 의사가 배치되어** 환자를 본다고 보

고되고 있습니다 ([Urgent Care Centers | Paragon Ventures](#)). 의사가 한 명일 경우 내과적 진료와 간단한 외과적 처치를 모두 맡아야 하므로 해당 분야 숙련도가 요구됩니다. 야간진료가 장시간 지속(예: 18시~익일 08시 등)되는 경우 의사 2명이 교대로 근무하거나, 교대 시간이 겹치는 **중교대(crossover)**시간을 두어 업무 인수인계를 원활히 하는 방안도 고려해야 합니다.

- **간호사:** 숙련된 간호사 1~2명이 필수적입니다. 간호사는 ****초기 환자 분류(triage)****를 통해 위중한 환자를 선별하고, 진료 시 의사를 보조하며, 주사·투약 및 산소치료 세팅, 환자 모니터링을 담당합니다. 특히 산소치료나 응급처치(심폐소생술 보조 등)가 필요한 경우 간호사의 역할이 중요합니다. 야간에는 인력 부족으로 간호사가 원내 여러 부서를 겸할 수 있으므로, **다양한 상황 대처능력**이 있는 간호사를 배치해야 합니다. 필요시 교대로 휴식을 취할 수 있도록 2인 근무를 두는 것이 안전하며, 1인만 둘 경우 피로 누적으로 인한 사고를 방지하기 위한 대책(휴게시간 보장 등)이 마련되어야 합니다.
- **응급구조사/방사선사 등 기타 임상인력:** 야간에 단순 처치만 할 경우 필수는 아니지만, 보다 포괄적인 서비스를 위해 추가 인력을 고려할 수 있습니다. 예를 들어 ****응급구조사(EMT)****가 상주하면 응급상황 발생 시 전문 소생술을 보조하고, 간호인력을 보완할 수 있습니다. 또한 X선 촬영 등이 필요한 경우를 대비해 **방사선사**를 당직 대기시키거나, 간호사 중 방사선기기 사용 교육을 받은 인력이 있으면 도움이 됩니다. 규모가 큰 병원의 경우 ****임상병리사(검사실요원)****나 **약사**를 야간당직으로 두어, 필요 시 혈액검사 수행이나 약제 조제를 할 수 있게 할 수도 있습니다. 다만 중소병원에서는 인력 제약이 있으므로 이러한 기능은 최소화하거나, 인근 병원의 협조를 얻는 방식(예: 영상판독은 원격판독 활용 등)으로 대체할 수 있습니다.
- **행정/원무 인력:** 접수와 수납, 보험청구를 처리할 원무과 직원도 야간에 1명 정도는 필요합니다. 환자 초기 접수, 수납 정산, 각종 서류 발급 등을 담당하며, 야간에는 환자나 보호자의 문의 대응, 병원 내 안전 관리 등 행정 업무도 겸하게 됩니다. 규모가 작다면 간호사가 행정 업무 일부를 대신할 수도 있으나, 원무 인력이 있으면 의료진이 진료에 전념할 수 있어 효율적입니다.
- **기타 지원인력:** 안전한 야간 운영을 위해 **보안요원 또는 수위**1명을 두어 만일의 사태(주취자 난동 등)에 대비하고 시설 안전을 관리하게 할 수 있습니다. 또한 야간에는 환경미화 인력이 상주하지 않는 경우가 많으므로, 응급 상황 후 청소나 소독이 필요할 때 대응할 수 있는 대비(간호조무사 겸 환경관리 역할 등)를 고려합니다.

위 인력들을 효율적으로 운용하려면 **근무 교대 방식**을 합리적으로 정해야 합니다. 야간진료 시간대가 매일 18:00~24:00정도로 한정된다면, 주간에 근

무한 의사가 추가 수당을 받고 **연장 근무**하는 방식이나, 전담 야간 아르바이트 의사를 채용하는 방식이 있을 수 있습니다.

반면 ****심야(자정아침)****까지 포함하는 경우에는 근무강도를 고려해 **2교대 야간전담**인력을 두는 것이 바람직합니다. 예를 들어 ****초저녁 근무조(18:00 익일 0:00)****와 ****심야 근무조(0:00~08:00)****로 교대하고, 주말과 주중을 교대로 쉬게 하는 방식입니다. 이렇게 하면 한 명의 의사가 연속 근무로 인한 피로 누적 없이 교대할 수 있습니다. 간호사와 행정직도 비슷하게 교대 일정을 짜며, 인력 규모에 따라 주간-야간 교대를 주기적으로 바꾸는 **순환 교대제** 또는 전담야간전문의 체제로 고정하는 방법이 있습니다. 특히 **의료진 확보가 어려운 지방 병원**의 경우, 낮에는 외래를 보고 밤에는 교대로 야간진료를 서는 형태로 의사들이 추가 근무를 하게 될 수 있는데, 이에 따른 **추가 수당**과 근무여건 개선이 반드시 동반되어야 합니다 (['야간진료 차등수가 예외' 시행...개원가 손익계산 분주 - 의협신문](#)). 실제 개원의사들은 ***“야간에 진료하려면 인건비나 운영비 등의 추가 부담이 큰데, 그에 상응하는 보상이 마련되어야 참여할 수 있다”**고 지적하고 있습니다 (['야간진료 차등수가 예외' 시행...개원가 손익계산 분주 - 의협신문](#)). 따라서 인력 계획 시 **야간 수당, 교통비 지원, 대체 휴무**등을 충분히 보장하고, 함께 일하는 직원들의 동의를 얻어내는 것이 중요합니다 (['야간진료 차등수가 예외' 시행...개원가 손익계산 분주 - 의협신문](#)).

또한 **중증 환자 발생 대비 체계**도 마련해야 합니다. 비록 경증 외래위주 진료라고 해도, 갑자기 상태가 나빠지는 환자가 있을 수 있으므로 야간에 **의사 2인(주치의+대기당직)** 체계를 유지하거나, 최소한 인근 연계병원 응급의와 전화협진이 가능하도록 준비합니다. 해외 사례에서는 PA(Physician Assistant)나 NP(Nurse Practitioner) 등의 **중간진료인력**을 활용해 의사 업무를 분담하기도 하지만 ([Urgent Care Centers | Paragon Ventures](#)), 국내 제도상으로는 의사가 직접 모든 진료를 담당해야 하므로 이를 보조할 간호인력의 역량 강화가 필요합니다.

정리하면, **의사 1명 + 간호사 1~2명 + 행정 1명**을 기본으로 하여 병원의 규모와 환자 수에 따라 추가 인력을 배치하는 구성이 일반적입니다. 인력 운영 시 **교대제 도입, 추가 수당 및 휴식보장, 인근병원 당직체계와 연계**등을 종합적으로 고려해야 하며, 무엇보다도 **숙련된 의료진 확보**가 야간진료 성공의 관건이라고 할 수 있습니다 (['야간진료 차등수가 예외' 시행...개원가 손익계산 분주 - 의협신문](#)).

3. 의료법상 허용 여부 및 관련 제도

의료법 및 관련 제도측면에서 365일 야간진료 운영은 원칙적으로 **법적으로 허용**됩니다. 국내 의료법은 의료기관의 진료시간을 자율적으로 정할 수 있도록 하고 있으며, **“야간진료 금지”와 같은 조항은 없습니다**. 따라서 개별 의원이나 병원이 원한다면 신고된 범위 내에서 **야간 및 휴일에 진료를** 해도 법적으로 문제가 없습니다. 실제로 많은 병의원이 평일 야간(예: 18~21시)이나 토요일 오후 진료를 하고 있으며, 일부는 연중무휴로 운영하기도 합니다. 다만 **응급의료에 관한 법률**에서는 정식 응급실 운영에 필요한 시설·인력

기준을 규정하고 있는데, 야간진료센터는 이것과 별개로 **응급의료기관**이 아닌 **일반 외래형태**로 운영되어야 합니다. 다시 말해, 야간에 경증 환자를 보더라도 스스로를 “응급실”이나 “응급센터”로 광고하면 안 되며, **“야간진료 실시”**라는 문구로 홍보해야 합니다. 응급의료기관이 아니면서 24시간 문을 켜 놓고 ‘응급’ 간판을 달 경우 문제가 될 수 있으므로, 간판 및 표시에도 주의가 필요합니다 ([\[보도자료\]응급실도 없는 병원 간판, 왜 심야에도 불 밝히나요?](#)).

정부는 야간진료 활성화를 위한 제도적 지원을 점차 확대하고 있습니다. 최근 보건복지부는 야간진료관리료 수가 인상 및 적용시간 확대를 골자로 한 개선안을 2025년부터 시행한다고 밝혔습니다 ([보건복지부, 야간 시간대 외래 진료 활성화 방안 발표…응급실 과밀화 완화 기대](#)) ([보건복지부, 야간 시간대 외래 진료 활성화 방안 발표…응급실 과밀화 완화 기대](#)). 현행 건강보험 수가에서는 평일 18시 이후~익일 09시까지 내원한 환자에 대해 일정액의 야간가산 진찰료를 산정할 수 있었는데, 앞으로 이를 18시~22시 사이 외래 진료에 대해 인상하고 초진/재진 구분 없이 동일하게 적용하도록 하였습니다 ([보건복지부, 야간 시간대 외래 진료 활성화 방안 발표…응급실 과밀화 완화 기대](#)). 또한 야간에 볼 수 있는 상병 범위를 넓혀 경증 환자뿐 아니라 일정 수준의 처치가 필요한 환자도 야간진료에서 보험 적용을 받을 수 있게 수가 기준을 완화하였습니다 ([보건복지부, 야간 시간대 외래 진료 활성화 방안 발표…응급실 과밀화 완화 기대](#)). 이러한 조치는 경증 환자가 굳이 야간에 응급실에 가지 않고도 지역 의원에서 진료받을 수 있게 유도하려는 목적이며, 야간 외래 이용이 늘면 결과적으로 응급실 과밀화 완화에 도움이 될 것으로 기대되고 있습니다 ([보건복지부, 야간 시간대 외래 진료 활성화 방안 발표…응급실 과밀화 완화 기대](#)).

야간진료 활성화를 위해 이미 시행중인 다른 제도로는, 앞서 언급된 **달빛어린이병원**사업이 있습니다. 달빛어린이병원은 보건복지부와 지자체가 지정한 의료기관에 대해 **운영비 지원**과 **수가 가산**을 제공하여 소아과 야간진료를 유도하는 제도입니다 ([365일 야간에도 진료하는 '달빛어린이병원' 아세요? - 경향신문](#)) ([밤늦게 아이가 아프다면, 해매지 말고 '달빛어린이병원'! : 사회 : 경기도 ...](#)). 현재 소아청소년과에 한정된 사업이지만, 유사한 개념을 성인 경증환자 대상으로 확대하자는 논의도 있습니다. 또한 응급의료 취약지의 경우 **비대면 진료 예외 허용**등 특별조치도 시행되고 있습니다. 2023년 발표에 따르면 의료 취약 지역에서 **휴일·야간에는 초진이라도 한시적으로 비대면 진료를 허용**하여, 의사가 부족한 지역 주민들이 밤에 아플 때 원격으로 진료를 받을 수 있게 할 계획입니다 ([응급의료취약지-휴일·야간 비대면진료 예외적 허용 확대 - 보건복지부](#)). 이는 야간진료 인력 확보가 어려운 지역에서 기술을 활용한 보완책으로 볼 수 있습니다.

의료법상 **인력 운용**과 관련해서는, 정상적인 면허를 가진 의사와 간호사를 적법하게 고용하면 문제될 것이 없습니다. 다만 유의해야 할 점은 **공중보건 의사 등 특정 신분의 인력**활용인데, 과거 일부 기관에서 야간에 공보의를 추가로 근무시키다 적발된 사례가 있어 정부가 이를 단속하기도 했습니다 ([“공중보건의 야간진료 고용한 의료기관도 처벌” - 중앙일보 헬스미디어](#)). 따라

서 인력은 모두 의료기관 자체 고용으로 편성해야 하며, 인근 병원 의사가 겸직 형태로 야간진료에 참여할 경우에도 해당 의사의 면허범위, 겸직 허가 등을 확인해야 합니다.

정책적으로는 **지역단위 야간진료센터 지정제도** 거론됩니다. 현재 국회에는 ***“소아 야간·휴일 진료기관을 보건복지부장관 또는 시·도지사가 지정”***하도록 하는 법안이 발의된 상태입니다 ([야간·공휴일 소아진료 의료기관 운영 법으로 정한다? - 의협신문](#)). 이는 법적으로 야간진료기관의 지위를 부여하고 지원책을 마련하려는 움직임으로, 향후 성인까지 확대될 가능성이 있습니다. 지자체 차원에서도 서울 성동구 등 일부 지역은 ****‘공공 심야의원’****을 자체 지정하여 예산을 지원하고, 관내 주민들에게 홍보하는 등 노력 중입니다 ([밤에 아이 아파도 '안심'...야간진료 지자체가 직접 지원 / YTN - YouTube](#)) ([야간·휴일 지정 진료기관 운영 - 의약정보 - 보건광장 - 성동구 보건소](#)). 요약하면, **365일 야간진료는 현행 법체계에서 가능하며**, 정부도 이를 장려하기 위한 수가 개선과 지원책을 마련하고 있습니다. 중요한 것은 야간진료 시행 시 ****의료법 준수(표시 및 인력기준)****와 **보험청구 기준 속지**이며, 관련 제도 변화를 지속적으로 모니터링하여 최대한 활용하는 것입니다. 최근의 수가 인상 조치는 야간진료기관에 경제적 혜택을 주어 참여를 독려하려는 것이므로, 이를 적극 활용하면 도움이 될 것입니다 ([보건복지부, 야간 시간대 외래 진료 활성화 방안 발표...응급실 과밀화 완화 기대](#)). 아울러 환자의 안전을 위해 응급의료기관과의 연계체계를 구축하고, 자체 역량 범위를 벗어나는 경우 적시에 이송·의뢰하는 프로토콜을 마련해 두는 것이 바람직합니다.

4. 운영에 따른 수익성 분석 및 비용 구조 예시

365일 야간진료 시스템의 수익성은 운영 형태와 환자 수에 따라 크게 좌우됩니다. 일반적으로 야간진료는 추가 인건비와 운영비가 들지만, 환자 수가 제한적이라 수익성이 낮은 편으로 인식되어 왔습니다 (['야간진료 차등수가 예외' 시행...개원가 손익계산 분주 - 의협신문](#)). 하지만 정부 수가 지원과 지역 수요를 고려하면, 효율적 운영으로 손익분기점을 맞출 수도 있습니다. 여기서는 가상의 중소병원 야간진료부를 예로 들어 **월별 수익·비용 구조**를 간략히 살펴보겠습니다:

- **환자 수 추정:** 예를 들어 하루 평균 **10명의 환자**가 야간에 내원하고, 이 중 절반은 경증 처치(주사·처치 등)까지 동반된다고 가정합니다. 그러면 월 환자 수는 약 300명 수준입니다. 초기에는 이보다 적을 수 있으나, 홍보와 신뢰 구축으로 점차 증가한다고 보면 됩니다.
- **단위 수익 계산:** 건강보험 기준으로 야간가산 진찰료(초진 시)와 기본 처치료를 합치면 1인당 약 **4~5만원**의 수입이 발생한다고 가정해보겠습니다. (예: 야간 기본진찰료 2만원 + 처치/약제 등 2만원 + 본인부담 약간 등) 물론 환자 상태에 따라 더 많은 처치(예: 수액, 봉합 등 시술) 시 수가가 올라가고, 반대로 간단한 상담만 하면 적을 수 있습니다. 평균 5만원으로 잡으면 **월 총수익 약 1,500만원**

(300명 × 5만원)이 됩니다. 여기에 비급여나 본인부담금 수입(예: 시간외 가산 본인부담, 약 처방전 비용 등 소소한 항목)도 몇 십만원 추가될 수 있습니다.

• **운영 비용 산출:**

- **인건비:** 야간전담 의사 1명의 월급 또는 수당. 전일제 의사가 낮과 밤을 모두 하는 게 아니라 별도로 야간전담을 채용했다면, 숙련의사 기준 월 1,200~1,500만원 수준(야간근무 프리미엄 고려)을 책정할 수 있습니다. 간호사 1명의 야간수당 포함 월급은 약 400만원, 행정직 1명 300만원 정도로 추산합니다. 이렇게 주요 인건비 합계 2,000~2,200만원 정도입니다. 이외에 간호조무사나 보조인력이 있으면 추가됩니다.
- **기타 고정비:** 시설 유지비(전기료 등)와 장비 감가상각비, 소모품 비용 등이 있습니다. 산소통 리필이나 산소발생기 전기료, 주사용품·약품비 등 월 100~200만원 정도로 볼 수 있습니다.
- **합계 비용:** 대략 월 2,300~2,400만원 규모로 예상됩니다 (인건비 2,100만 + 기타 200만 등).

손익 계산: 위 가정에서 월 수익 1,500만원 대비 월 비용 2,300만원이면 약 800만원의 적자가 발생합니다. 이는 환자 10명/일 가정 하에서로, 손익 분기점을 맞추려면 환자 수가 늘어나거나 추가 수입원이 필요함을 의미합니다. 예를 들어 하루 20명(월 600명) 내원한다면 수익이 약 3,000만원으로 증가하여 비용을 상쇄하고 수익 실현도 가능해집니다.

정부·지자체 지원: 수익성 부족분은 정부나 지자체 지원으로 보충할 수 있습니다. 실제 달빛어린이병원의 경우 정부가 한 곳당 연 2억원 가량 지원하고 있습니다 ([\[단독\]복지부, 달빛어린이병원 소아 새벽 수가 신설 추진 - 네이트 뉴스](#)). 성인 야간진료에는 아직 직접 지원은 없지만, 앞서 언급한 야간진료 수가 가산 인상으로 일정 부분 보전받을 수 있습니다. 또한 지자체에서 별도 예산을 책정해 참여 의료기관에 인센티브(분기별 운영보조금 등)를 지급하는 방안도 고려할 수 있습니다.

비용 절감 노력: 수익성을 높이기 위해 **비용구조 최적화**가 필요합니다. 예를 들어, 기존 주간진료 인력을 일부 겸용함으로써(주간 근무 의사가 순번을 정해 야간 연장진료) 추가 인건비를 줄일 수 있습니다. 혹은 여러 병원이 컨소시엄을 이뤄 **교대운영**하면 한 병원당 야간운영 일수가 줄어 비용 부담이 경감됩니다. 이때 공용으로 쓸 장비나 공동구매 약품 등을 통해 규모의 경제를 살리는 방법도 있습니다.

민간수익 모델: 만약 보험진료만으로 수익이 나기 어렵다면, **부가 수익 사업**을 연계하는 것도 한 방법입니다. 가령 주간에는 검진센터를 운영한다면, 야간에는 간단한 미용시술이나 예방접종(독감 예방접종 등의 편의 제공, 본인부담) 서비스를 함께 제공해 부수입을 올릴 수 있습니다. 또는 약국과 협약하여 문달은 약국 대신 ****조제약 배달 서비스(유료)****를 제공하는 등 지역 수요에 맞춘 서비스를 부가적으로 시행할 수

도 있습니다.

전반적으로 볼 때, 야간진료 단독으로 큰 흑자를 기대하기는 어려운 구조입니다. 우리나라 건강보험 수가 체계에서 야간가산이 붙어도 진찰료 수준은 한계가 있고, 환자 본인부담을 크게 높일 수도 없습니다. 미국의 경우처럼 환자에게 응급실 대비 10분의 1 비용으로 저렴하게 제공되는 대신 수익도 낮은 편이라(ER 평균 \$2,200 vs Urgent Care \$168 ([Urgent Care Centers | Paragon Ventures](#))) 많은 환자를 처리해야 경영이 가능합니다. 그렇기에 현실에서는 공공재적 성격을 인정받아 정부보조를 받거나, 병원 차원에서는 손실을 감수하고서라도 지역봉사 차원에서 운영하는 경우가 있습니다. 실제 2010년대 초반 정부가 야간진료 활성화를 위해 야간 환자에 대해 본인부담금 경감(차등수가 적용 제외) 조치를 했을 당시에, 일부 개원의들은 “수익에 대한 정확한 예측 없이 진료시간을 늘리는 것이 부담스럽다”고 토로했습니다 (['야간진료 차등수가 예외' 시행...개원가 손익계산 분주 - 의협신문](#)) (['야간진료 차등수가 예외' 시행...개원가 손익계산 분주 - 의협신문](#)). 이는 추가 수입보다 인건비·관리비 등 추가부담액에 대한 우려가 컸기 때문입니다.

결국 수익성을 담보하려면 충분한 환자 확보가 핵심인데, 이는 효과적인 홍보와 지역 내 신뢰 구축에 달려 있습니다(다음 8번 항목에서 상세 논의). 또한 비용 측면에서는 인력 운용을 탄력적으로 하고, 정부지원금을 적극 유치하며, 불필요한 설비투자를 지양하는 등으로 균형을 맞춰야 합니다. 계량 분석을 해보면, 하루 약 15명 이상 꾸준히 환자가 방문하고 정부나 지자체에서 일정 보조를 해준다면, 365일 야간진료 시스템도 경영적으로 유지 가능한 모델이 될 수 있을 것입니다. 반대로 환자 부족 시에는 적자를 감수해야 하므로, 운영 초기에는 보수적인 시나리오로 예산을 편성하고, 6개월~1년 간 시범운영 결과를 모니터링하여 확대 여부를 결정하는 단계적 접근이 권장됩니다.

5. 관련 기술 또는 설비 요건 (고유량 산소장비, 모니터링 시스템 등)

365일 야간진료를 위한 기술·설비 요건은 안전하고 효율적인 진료를 위해 반드시 충족되어야 합니다. 일반 주간외래보다 긴 시간 운영되고 응급상황에 대비해야 하므로, 필요한 장비를 사전에 구비하고 유지관리체계를 갖추는 것이 중요합니다. 아래에 핵심 설비와 기술 요소를 정리합니다:

- 산소치료 장비: 산소치료가 통합된 야간진료를 표방하는 만큼, 의료용 산소 공급체계가 필수입니다. 작은 의원급에서는 이동식 **산소실린더(산소탱크)**나 **산소발생기(O₂ Concentrator)**를 비치할 수 있습니다. 병원급에서는 중앙 산소배관이 연결된 벽부 출력이 있으면 가장 편리하나, 없을 경우 독립형 산소농축기를 준비합니다. 특히 호흡부전 환자에 대비해 고유량 산소요법(HFNC) 장비를 갖추는 것이 권장됩니다. HFNC는 가온·가습된 산소를 분당 최대 60L까지 높은 유량으로 공급하여 중증 호흡곤란 환자에게 효과적으로 산소를 줄 수 있는 장비입니다 ([Oxygen - SouthShore Urgent Care](#)).

최근 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 유행 등을 거치면서 중소병원에도 많이 도입되었고, 건강보험에도 신의료기술로 등재되어 급여 적용을 받고 있습니다 ([\[PDF\] 고유량비강캐놀라요법\(High Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy\)](#)). 그 외에 ****비침습 환기기(NIPPV, CPAP/BIPAP)****도 한 대 있으면 호흡곤란 환자에게 큰 도움이 됩니다. 물론 이러한 고급 장비들은 가격이 비싸므로 예산에 맞춰 단계적으로 갖추고, 우선순위는 기본 산소 공급 및 HFNC 확보로 볼 수 있습니다.

- **모니터링 및 응급장비:** ****환자감시모니터(모니터링 시스템)****는 야간진료실에 최소 1대 이상 필요합니다. 이는 혈압, 맥박, 산소포화도(SpO_2), 호흡수를 지속적으로 측정하여 위급상황을 즉각 인지하는 데 필수입니다. 산소치료 중인 환자는 간호사가 수시로 상태를 살펴야 하나, 모니터에 연결해두면 한눈에 여러 환자의 활력징후를 볼 수 있어 효율적입니다. 또한 ****제세동기(AED)****를 구비하여 급성 심정지에 대비해야 합니다. 의원급이라도 심폐소생술 상황이 생길 수 있으므로, 자동제세동기를 환자 대기실 및 진료구역에 비치하고 직원들이 사용법을 숙지합니다. ****산소포화도 측정기(펄스옥시미터)****는 휴대용으로 여러 대 두어 진료실, 처치실에서 활용하고, 필요 시 **혈당측정기** 등 POCT(Point of Care Testing) 기기도 구비합니다. 호흡곤란 환자 평가를 위해 ****혈액가스분석 장비(ABGA)****나 **전해질 신속검사기(i-Stat)** 등이 있으면 좋지만, 필수는 아닙니다. 대신 인근 응급실로 전원 시 검사용 혈액샘플을 채취해 보내거나 하는 협조체계를 두는 방법도 있습니다.
- **응급처치 및 시술 장비:** 야간진료에서는 경증 외상이나 통증 환자도 오므로, 기본적인 외과 처치 도구를 준비해야 합니다. 예를 들어 **붕합세트(멸균 붕합키트)**, **국소마취제**, 상처 소독물품, **붕대와 드레싱 세트** 등이 있어야 합니다. 단순 골절을 임시 고정할 ****부목(Splint)****과 **석고붕대**, 뺨 데를 지지할 **Elasticon 밴드**등도 마련합니다. 근골격계 통증 환자를 위한 ****주사치료제(진통제, 근이완제)****와 필요시 **국소 주입기구(주사바늘, 주사기)**도 필수적입니다. ****기본 응급카드(응급크래쉬카드)****를 구성하여 그 안에 기관삽관 세트(튜브, 후두경 등), Ambu bag(수동식 인공호흡기), 기관지경(가능하면) 등을 구비해둡니다. 약물로는 응급상황 시 쓸 **아드레날린**, **항히스타민**, **기관지확장제**, **항경련제**, **혈압상승제** 등 필수 응급약물을 비치합니다. 이러한 응급카드는 정기적으로 점검해 유효기간을 관리하고, 직원들이 어디에 무엇이 있는지 숙지토록 교육해야 합니다.
- **진단 보조장비:** 가능하다면 **이동형 X-ray 장비**나 **초음파 기기**를 갖추면 진단에 도움이 됩니다. 야간에 갑자기 복통 환자가 왔을 때 초음파로 담석증을 감별하거나, 흉통 환자에 폐렴 여부를 엑스선으로 확인할 수 있다면 보다 정확한 처치가 가능합니다. 다만 중소병원 여건상 인력 부재 시 활용이 어려울 수 있으므로, **휴일·야간 영상판독 원격지원(텔레레이디올로지)** 서비스를 계약해 두는 것도 방법입니다.

니다. 기본적인 **심전도(EKG)**기기는 꼭 필요합니다. 흉통이나 두근거림을 호소하는 환자 감별을 위해 12유도 심전도를 찍어볼 수 있어야 하며, 판독은 내과 의사가 직접 하거나 원격으로 협진합니다.

- **정보시스템(IT)**: 365일 운영되는 만큼 ****의료정보시스템(EMR)****과 **보험청구 시스템**도 이를 지원해야 합니다. 일부 EMR은 심야 시간대 서버 백업이나 업데이트로 잠시 중단될 수 있는데, 24시간 가동 체계라면 그런 일정도 조정해야 합니다. 또한 **응급의료포털 E-Gen** 연계나 지자체 보고체계 등을 위해 진료시간/휴일 정보를 미리 등록하고 실시간 변동사항(예: 부득이 휴진 등) 발생 시 업데이트할 수 있는 체계를 마련합니다. **인터넷 전화 및 네트워크**도 예비선을 두거나 UPS(무정전 전원공급) 등을 통해 야간에도 장애 없이 의료진이 통신할 수 있게 합니다.
- **시설 및 환경**: 환자 편의를 위해 **대기실**에 충분한 좌석과 온열기/냉방기, TV, 정수기 등을 둡니다. 야간에는 대중교통이 제한적이므로 **주차 공간**을 확보하여 환자들이 차량을 가지고 오기 편하도록 합니다. 조명은 환한 분위기를 유지하되, 늦은 시간에는 조도를 약간 낮춰 환자 안정감을 주는 것도 좋습니다. **보안 카메라**를 설치해 사건 사고 예방 및 녹화를 하도록 하고, 출입문은 통제구역과 일반구역을 분리해 무단출입을 막습니다
- **소모품 비축**: 365일 운영 특성상 공휴일에도 재료가 떨어지면 안 되므로, 주요 **의약품**과 **소모품 재고**를 **상시 충분히 비축**해야 합니다. 산소통은 예비를 여러 개 두고, 약품 중 항생제·수액·진통제 등은 최소 1~2개월분 확보합니다. 주말이나 연휴 전에 미리 점검하여 추가 발주하고, 인근 약국/도매상과 비상연락망을 구축해 급한 약은 조달할 수 있도록 합니다.

요약하면, **안전한 야간진료**를 위한 **인프라로서 산소치료 및 응급대응 장비, 환자 모니터링 시스템, 기본 처치 및 진단기기, IT 및 시설 안전 설비**가 모두 갖춰져야 합니다. 특히 산소치료 중심이라는 컨셉에 부합하려면 **고유량 산소장비와 숙련된 사용법**이 필수이고, 이를 뒷받침할 모니터링·응급장비가 따라와야 합니다. 이러한 설비 요건을 충족시키는 데 초기 비용이 들지만, 이는 **환자 안전과 직결되는 투자**로서 필히 고려해야 합니다. 적절한 장비가 마련되면 야간에도 주간과 유사한 수준의 의료서비스를 제공할 수 있고, 이는 곧 환자 신뢰도 향상과 의료진의 업무효율 개선으로 이어져 운영 안정성에 기여할 것입니다.

6. 지방 중소병원 및 전문병원에서 적용 가능한 현실적 방안

지방의 중소규모 병원이나 단일 전문병원에서 365일 야간진료 시스템을 도입하려면, 대도시 대형병원과는 다른 **현실적 제약과 수요**를 고려해야 합니다. 지방 중소병원의 경우 인력과 자원 한계가 있으므로, 아래와 같은 현실적인 적용 방안을 모색할 수 있습니다:

- **인근 의료기관들과의 협력 (공동 운영):** 한 병원이 단독으로 365일 야간진료를 모두 감당하기 어려운 경우, **지역 의료기관이 요일별로 분담하는 협력 모델**을 고려할 수 있습니다. 예를 들어 A병원은 월·화 야간진료, B의원은 수·목 야간진료, C병원은 금~일 야간진료 식으로 **지역 의료 네트워크**를 구축하는 것입니다. 이렇게 하면 각 기관별 부담은 줄이면서 지역 전체로는 **365일 커버리지**를 확보할 수 있습니다. 일본이나 국내 일부 지자체에서도 유사한 당번병원제를 시행한 사례가 있습니다. 이를 위해서는 지역 의사회나 보건소의 조정 역할이 중요하며, 참여기관 간 환자 의뢰와 기록 공유 등의 협력이 원활히 이뤄져야 합니다. 지자체는 이러한 협력 모델에 인센티브 (운영비 지원 등)를 제공하여 참여를 유도할 수 있습니다.
- **단계적 도입 (시범 운영 후 확대):** 처음부터 무리하게 24시간 365일을 다 운영하기보다, **부분 야간진료**로 시작해보는 전략입니다. 예컨대 **평일 한두 요일만** 야간진료를 시행하거나, **토요일 또는 일요일** 같은 휴일진료부터 시작해볼 수 있습니다. 실제로 일부 지방 병원은 주 1~2회 ***“야간 전문클리닉”***을 운영하여 지역 주민의 호응을 얻은 사례가 있습니다. 이렇게 점진적으로 시행하면서 환자 수요를 파악하고, 내부 운영의 문제점을 보완해나간 뒤, **운영 요일과 시간을 점차 확대**해가는 것입니다. 시범운영 기간에는 홍보 효과도 누릴 수 있고, 의료진도 야간진료 패턴에 적응할 시간을 벌 수 있습니다.
- **전문의료인력 확보 방안:** 지방 중소병원은 야간에 전문의를 확보하기 어려운 현실이 있습니다. 이를 보완하기 위해 **순환 파견**이나 **공동 고용**방안을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 인근 도시의 대학병원과 협약을 맺어, 레지던트나 펠로우급 의사가 일정 근무를 나오게 하거나, 권역 내 병원들이 비용을 분담해 ****야간당직 전문의 풀(pool)****을 만드는 것입니다. 한 전문의가 요일별로 여러 병원을 돌며 야간진료를 서는 형태도 가능하며, 이에 따른 숙박 및 수당을 참여 병원들이 공동 부담합니다. 또는 최근 정부가 추진 중인 지역의 사제 등을 활용하여, 해당 지역 출신으로 일정기간 의무복무하는 의사를 야간진료에 투입하는 아이디어도 고려할 수 있습니다.
- **원격의료 지원 활용:** 앞서 제도 부분에서 언급했듯, **비대면 진료 허용범위**가 확대되고 있으므로 이를 활용하는 방법입니다. 예를 들어 야간에 소수 인력만 있는 병원에서 갑자기 산과나 소아과 환자가 오면 곤란할 수 있는데, 이때 **대학병원 원격협진 시스템**으로 해당과 전문의와 영상 통화하여 자문을 구하는 방식입니다. 혹은 환자에게 직접 **원격 진료**를 제공하는 것은 현행법상 제한적이지만, 응급 상황의 예외조항을 활용하거나 추후 제도가 보완되면 **재택 원격모니터링**등도 검토할 수 있습니다 ([응급의료취약지-휴일·야간 비대면진료 예외적 허용 확대 - 보건복지부](#)). 또한 원격으로 영상 판독이나 검사 판독을 지원받아, 야간에도 전문적인 해석을 즉시 얻는 체계를 구축하면 전문인력 공백을 메울 수 있습니다.

- **특화 진료로 니치 마켓 공략:** 전문병원의 경우 자신의 전문분야를 살린 **특화 야간진료**로 틈새 수요를 공략할 수 있습니다. 예컨대 정형외과 전문병원이라면 ***“야간 골절클리닉”***을 열어 응급실 가기 애매한 경미한 골절이나 타박상 환자를 받아준다든지, 소화기내과 전문의원이면 ***“야간 통증/복통 클리닉”***으로 급성 복통 환자를 진료하는 식입니다. 이런 특화 전략은 해당 분야 환자를 집중적으로 모을 수 있고, 전문성이 높아 만족도가 올라가며, 병원 입장에서도 익숙한 분야라 부담이 적습니다. 다만 내과·외과 종합진료를 내세우는 경우보다 홍보범위가 좁아질 수 있으므로, 해당 지역에 그 분야 수요가 충분한지 사전조사가 필요합니다.
- **지역사회 통합서비스 연계:** 지방에서는 병원 접근성이 떨어질 수 있으므로, **찾아가는 서비스나 이송 서비스**를 연계합니다. 예를 들어 자체 앰불런스나 협약된 119구급대와 연계하여, 경증환자도 야간진료소로 이송해주는 시스템을 만들면 환자 접근성이 높아집니다. 또한 마을별 이장이나 지역 보건진료소와 협력하여, **야간진료 안내 및 예비평가**를 해주는 체계를 둘 수 있습니다. 즉 마을 주민이 밤에 아플 때 마을 이장이 병원에 미리 연락해 증상을 설명하면, 병원에서 준비하고 기다렸다가 보는 방식입니다. 이런 지역 밀착형 서비스는 환자들에게 **심리적 안정감**을 주고 이용률을 높일 수 있습니다.
- **지자체 지원 확보:** 지방 중소병원은 재정 여력이 한계가 있으므로, 관할 지자체의 지원을 적극적으로 요청해야 합니다. 지자체 입장에서도 주민 의료편의 증진을 위해 야간진료를 장려하는 추세이므로, **예산 보조, 시설비 지원, 홍보 지원**등을 이끌어낼 수 있습니다. 실제 경기도의 경우 11개 시·군에서 총 16곳의 달빛어린이병원을 운영할 정도로 야간 소아진료에 힘쓰고 있으며, ***“경증 환자는 응급실보다 비용 저렴한 달빛병원을 이용해달라”***고 홍보하고 있습니다 ([밤늦게 아이가 아프다면, 해매지 말고 '달빛어린이병원'! : 사회 : 경기도 ...](#)) ([밤늦게 아이가 아프다면, 해매지 말고 '달빛어린이병원'! : 사회 : 경기도 ...](#)). 성인에 대해서도 비슷한 명목의 지원사업을 제안할 수 있습니다. 예컨대 ***“야간·휴일 건강지킴이 의원”***이라는 이름으로 지정하면, 지역 주민들도 신뢰하고 이용할 가능성이 높습니다 ([공공 야간·휴일 건강지킴이 진료의원 안내 : 네이버 블로그](#)). 지자체 보건소를 통해 해당 의원에 공중보건 간호사 파견, 진료비 일부 지원(바우처 제공) 등의 방법도 생각해볼 수 있습니다.
- **운영 범위의 현실화:** 중소병원에서는 **자신들이 감당할 수 있는 환자 범위를** 명확히 정하는 것이 중요합니다. 예를 들어 **“우리 병원은 중증 출혈이나 심근경색 등은 처리 어려우므로 그런 경우 바로 119 호출”, “CT가 필요한 경우 이송”**등 프로토콜을 정해 놓고, 직원들에게 교육합니다. 괜히 무리하게 모든 환자를 보려다가 감당 못 할 상황이 생기면 오히려 위험할 수 있으므로, **응급실과의 경계**를 분명히 하고 운영해야 합니다. 이를 환자들에게도 사전에 알리면 (홍보물 등에 **“중증 응급환자는 대응 어렵습니다”** 등 안내) 이해하고 협

조하는 데 도움이 됩니다.

결국 지방 중소병원에서의 365일 야간진료는 ****“협력”****과 **“단계적 도입”**, 그리고 ****“현실적인 범위 설정”****이 성공 키워드입니다. 지역의 의료자원을 연계하고, 작게 시작해서 키워나가며, 자기 병원의 강점을 살리면서 한계를 명확히 할 때 안정적으로 정착할 수 있습니다. 또한 **지역 주민의 수요 파악**이 중요합니다. 맞벌이 부부나 야간 교대근무자 등 낮에 병원 이용이 어려운 주민들이 주요 대상이므로 ([야간·휴일 지정 진료기관 운영 - 의약정보 - 보건광장 - 성동구 보건소](#)), 이들의 요구를 조사(설문 등)하여 운영시간과 서비스 내용을 결정하면 더 현실적일 것입니다. 예컨대 공단 근로자 많은 지역이면 오후 7~10시 진료 위주로, 농촌 지역이면 새벽 응급위주로 다르게 접근하는 식입니다.

마지막으로, **작은 성공사례를 만들어내는 것**이 중요합니다. 인근에 야간진료로 호응을 얻은 병원이 생기면 다른 병원들도 자극을 받아 참여할 가능성이 높습니다. 그러므로 처음 시작할 때 너무 큰 욕심보다는, 작더라도 환자 만족도를 높이는 운영을 하여 ****“밤에도 믿고 갈 병원”****이라는 입소문을 얻도록 힘써야 합니다.

7. 환자 접근성과 홍보 전략

환자들이 야간진료에 쉽게 접근하도록 하고, 적극적으로 이용하게 만드는 **홍보 전략**이 성공적인 운영에 필수입니다. 아무리 훌륭한 시스템을 갖춰도 정작 지역 주민이 몰라서 이용하지 않으면 무용지물이므로, **다각도의 홍보와 접근성 개선노력**이 필요합니다:

- **지역사회 대상 홍보:** 우선 지역 주민들에게 새로운 야간진료 서비스의 존재를 인식시켜야 합니다. 이를 위해 지역신문, 주민센터 게시판, 아파트 단지 방송, 마을 이장 회의 등을 활용해 홍보물을 배포합니다. 예를 들어 ***“밤에도 안심, 우리동네 야간진료 병원 개설”***과 같은 제목의 전단지를 만들어 각 가정에 배포하거나, 지자체 소식지에 게재합니다. **지역 맘카페나 밴드, 카카오톡 채널** 등 SNS도 활용하여 홍보글과 카드뉴스를 올립니다. 특히 어린 자녀를 둔 부모나 만성질환 노인층은 야간진료 정보를 중요하게 여기므로, 대상층 커뮤니티에 맞춤 홍보를 합니다. 정부나 지자체 차원에서도 야간진료 기관 정보를 한눈에 볼 수 있는 **온라인 시스템**을 구축 중이며, 2025년부터 지역별 야간진료 가능 의료기관 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 개선할 계획입니다 ([보건복지부, 야간 시간대 외래 진료 활성화 방안 발표...응급실 과밀화 완화 기대](#)). 이러한 공식 경로(응급의료정보센터 e-gen 웹사이트, 119안내 등)에 빠짐없이 우리 병원의 정보를 등록해두고 최신으로 유지해야 합니다.
- **의료기관 내부 홍보:** 주간에 내원하는 환자들에게 **야간에도 진료 가능함**을 안내합니다. 접수 창구와 병원 입구에 **“365일 야간진료 실시”** 팻말이나 현수막을 잘 보이게 설치합니다. 또한 진료실에서 의사

가 환자에게 필요한 경우 “혹시 밤에 증상 심해지면 우리 병원이 밤에도 열려 있으니 연락주세요”라고 직접 안내하는 것도 효과적입니다. 약국에도 협조를 구해 야간진료 안내문을 비치하면 환자들이 약 타러 갔다가 정보를 얻을 수 있습니다. **응급실로 향하는 환자 안내**도 중요한데, 근처 종합병원 응급실에 협조를 구해 경증 환자는 우리 야간진료소로 안내해달라고 할 수 있습니다. 예컨대 응급실 트리아지 간호사가 판단하여 경증이면 “인근 OO의원에서 진료 가능합니다”라고 안내하면 환자 분산에 도움이 됩니다. 이러한 응급실-야간진료소 연계는 상호 이익이 될 수 있어, 사전에 종합병원과 MOU를 맺어두면 좋습니다.

- **온라인 접근성 개선:** 구글 지도나 네이버 지도 등에 병원 정보를 업데이트하여 “야간진료” 키워드로 검색 시 상단에 노출되도록 합니다. 실제로 환자들은 갑자기 아플 때 스마트폰으로 “야간 진료 병원”을 검색하는데, 이때 우리 병원이 리스트에 나오고 운영시간이 정확히 표시되어 있어야 합니다. 블로그나 SNS에 **후기 포스팅**을 유도하는 것도 온라인 노출에 도움이 됩니다. 예를 들어 지역 파워블로거를 초청하여 야간진료 체험후기를 쓰게 하거나, 만족한 환자에게 소정의 사은품과 함께 리뷰 작성을 부탁할 수 있습니다. 검색 엔진 광고에 투자하여 “밤에도 진료하는 OO병원”이라는 광고를 노출시키는 것도 고려해볼 만합니다.
- **홍보 메시지 전략:** 환자에게 어필할 수 있는 **키 메시지**를 정하고 일관되게 홍보합니다. 예를 들면 “*한밤중에도 문 여는 병원*”, “*24시간 당신 곁을 지키는 OO병원*”, “*응급실보다 빠르고 저렴하게*”같은 문구로 야간진료의 강점을 강조합니다 ([Urgent Care 24/7 | Walk In Emergency Clinics | Urgent Care](#)) ([Urgent Care Centers | Paragon Ventures](#)). 응급실 대비 **대기시간이 짧고비용 부담이 적다**는 점 ([Urgent Care Centers | Paragon Ventures](#)), 그리고 **믿을 수 있는 전문의가 진료**한다는 점을 부각하면 환자들의 관심을 끌 수 있습니다. 또한 “365일”이라는 숫자를 내세워 *브랜드화*하는 것도 좋습니다 (예: OO병원 365클리닉). 시각적으로 눈에 띄게 병원 간판이나 배너에 365와 “야간진료”를 넣어두면 길 가는 사람들이 인지하게 됩니다.
- **환자 편의 증진:** 접근성을 높이기 위한 **실질적 편의 개선**도 중요합니다. 환자 입장에서 야간에 병원 가는 일이 번거롭지 않도록, **주차장 개방**이나 **야간 진료 예약제** 도입을 고려합니다. 미리 전화나 앱으로 예약을 받으면 환자는 시간 맞춰 와서 바로 볼 수 있어 편리하고 대기밀집을 줄여 방역 측면으로도 좋습니다. 또 야간에 오는 환자들은 급히 나오느라 현금을 못 들고 오는 경우가 있으므로 **카드 결제**는 물론 **간편결제(삼성페이, NFC)**등의 수단도 지원합니다. 경우에 따라 **심야 약국 정보**도 함께 제공하여, 환자가 진료 후 약국을 찾아 헤매지 않게 돕습니다. 우리 병원에서 조제까지 직접 할 수 있다면 더 좋겠지만, 의료법상 어렵다면 대신 인근 24시 약국에 처방

전 팩스전송 서비스 등을 해줄 수 있습니다.

- **커뮤니티 연계 홍보:** 지역 내 단체들과 협력하여 홍보합니다. 예를 들어 어린이집, 유치원, 학교 등에 홍보물을 배포하면 아이가 밤에 아플 때 부모들이 기억하고 이용할 수 있습니다. 경로당이나 노인회 관에도 안내하여 독거노인 등이 밤에 아플 때 119 대신 찾아올 수 있게 합니다. 지역 소방서나 119구급대에도 우리 병원의 야간진료 개시를 알려, 경증 환자 이송 시 응급실 외 옵션으로 고려하도록 합니다. 실제 일본 가가와현 의사회는 신문, 공공잡지, 웹사이트 등을 통해 휴일 당직의료기관 정보를 적극 홍보하여 주민들이 쉽게 인지하도록 했습니다 ([A Scale of Parental Anxiety about Pediatric Emergency Medical Care Services of Japan: Development, Reliability, Validity, Generalizability and Usefulness](#)). 이러한 다채널 홍보는 반복 노출을 통해 결국 지역 주민들의 인식 속에 자리잡게 만들 것입니다.
- **환자 만족도 관리:** 초기에 야간진료를 이용한 환자들의 만족도를 높이는 것 자체가 곧 홍보입니다. 한 명의 만족한 환자는 주변에 입소문을 내주지만, 불만족한 환자 역시 악평을 퍼뜨릴 수 있습니다. 따라서 친절な 응대와 충분한 설명, 그리고 환자 상태에 대한 적절한 대처로 신뢰를 얻어야 합니다. 특히 야간에는 “이 시간에도 봐줘서 고맙다”는 마음으로 오는 환자들이 많으므로, 작은 서비스 (교통편이 없을 때 택시 불러주기 등)에도 감동을 받을 수 있습니다. 이런 착한 후기들이 쌓이면 그것이 곧 최고의 홍보물이라 할 수 있습니다.
- **홍보물 및 표시 개선:** 병원 입구에 LED 간판등을 설치해 밤에도 한하게 “야간진료”표시가 보이도록 합니다. 에너지 절약도 중요하지만, 찾아오는 환자가 헛갈리지 않게 **운영시간 동안은 간판 불을 켜두는 것이 좋습니다.** (일부 병원은 문 닫았는데도 24시간 불을 켜놔 혼란을 주는 경우가 있는데 ([\[보도자료\]응급실도 없는 병원 간판, 왜 심야에도 불 밝히나요?](#)), 우리는 실제로 열려 있으니 잘 보이게 켜둬야 합니다.) 또 전화 안내멘트에도 “본원은 야간진료를 시행하고 있습니다”라는 내용을 추가합니다. 병원 웹사이트를 운영 중이라면 첫 화면에 365일 야간진료 배너를 게재하고, 자주 묻는 질문에 야간진료 시간과 절차 등을 안내합니다.
- **정부 플랫폼 활용:** 보건복지부와 중앙응급의료센터가 운영하는 **응급의료정보 포털(E-Gen)**과 모바일 앱에 우리 병원의 정보를 정확히 올립니다. 이 플랫폼에서는 사용자가 위치 기반으로 주변의 야간·휴일 진료기관을 검색할 수 있습니다 ([야간·휴일 진료가능 병의원 및 동네 문어는 병의원 현황 - 분야별정보](#)). 또한 129보건상담콜센터, 119구급상황실 등에 야간진료기관으로 등록해두면, 시민들이 전화로 문의할 때 상담원들이 안내해 줄 수 있습니다. 특히 명절 연휴 등에는 ‘당번병원’ 검색 수요가 많으므로, 평소에 정보가 정확

히 올라가 있어야 연휴 때도 빠짐없이 안내됩니다.

환자 접근성은 물리적·심리적 측면 모두 고려해야 합니다. 물리적으로는 앞서 언급한 주차, 교통, 예약 등으로 편의를 높이고, **심리적으로는 신뢰와 인지도를** 높여야 합니다. *“우리 동네에 24시간 문 여는 병원이 있다”*는 인식이 퍼지면, 주민들은 응급실로 갈까 말까 고민할 때 더 쉽게 결정하여 야간진료소를 찾게 됩니다. 이는 곧 이용률 증가로 이어져 선순환을 만들 것입니다.

끝으로, **홍보 전략의 성과를 모니터링**해야 합니다. 어떤 경로로 환자가 왔는지 물어보고 데이터를 축적하여, 효과적인 홍보 수단에 집중 투자합니다. 예를 들어 “현수막 보고 왔다”는 환자가 많으면 현수막을 더 설치하고, “인터넷 보고 찾았다”면 온라인 광고를 강화하는 식입니다. 피드백을 바탕으로 유연하게 전략을 조정하며, 장기적으로 **지역사회에서 야간진료소가 필수적인 의료 인프라로 인식될** 때까지 지속적으로 노력하는 것이 중요합니다.

以上の 계획을 종합하면, **365일 내외과·산소치료 중심 야간진료 시스템**을 구축·운영하기 위해서는 철저한 사례 연구와 준비, 단계적 도입, 법·제도 활용, 수익성 검토, 기술 장비 확보, 현실적 운영전략, 그리고 환자 중심의 접근성·홍보 전략이 모두 어우러져야 합니다. 각 항목별 고려사항을 충족하면, 지역 의료공백을 메우고 응급의료 체계의 부담을 덜며 동시에 병원에도 새로운 역할을 부여하는 **성공적인 야간진료 모델**을 실현할 수 있을 것입니다. 앞으로 이러한 계획을 토대로 세부 실행일정을 수립하고, 관련 인허가와 예산 확보를 진행하여 사업을 구체화하면 됩니다. **“365일 환자 곁을 지키는 야간 진료센터”**가 지역사회에 정착하길 기대합니다.

B.

B. 365일 야간진료 시스템 실행 전략 연구

개요: 365일 동안 내과, 외과, 산부인과, 소아과 등 주요 진료과목의 야간진료를 운영하는 것은 지역사회 의료공백을 메우고 응급실 과밀화를 완화하는데 중요한 전략이다. 본 연구에서는 국내외에서 실제 시행 중인 사례를 분석하고, 운영시간 모델, 인력 교대체계, 제도적 준거, 과별 진료 특성과 항목, 수익·비용 구조, 필요한 설비·기술, 지역사회 홍보, 인력관리 방안을 심층적으로 검토한다. 각 항목별로 요점을 정리하고 표를 통해 실제 병원 운영에 바로 적용 가능한 실행전략을 제시한다.

1. 국내외 365일 야간진료 운영 사례 분석

365일 야간진료는 국내에서는 주로 정부 지정 센터나 일부 전문병원을 통해 이루어지고 있으며, 해외에서도 긴급진료(Urgent Care) 또는 야간초진센터 형태로 운영되는 사례가 있다. 아래 표는 국내외 대표 사례들을 정리한 것이다.

(우리 지역에 공공심야 어린이병원이 문을 열었어요!) (우리 지역에 공공심야 어린이병원이 문을 열었어요!) 군산시 공공심야 어린이병원(달빛어린이병원 지정 기관) 접수처 모습. 군산시와 병원이 협약을 맺어 평일 밤 11시까지, 주말·공휴일에는 낮 시간 진료를 제공한다 (우리 지역에 공공심야 어린이병원이 문을 열었어요!).

위 사례들을 보면, 국내에서는 정부 지원을 통한 지정 병원(예: 달빛어린이병원)과 민간 전문병원(예: 수 여성병원) 형태로 365일 야간진료가 운영되고 있다. 달빛어린이병원의 경우 **평일 늦은 밤(22~23시)**까지 소아환자를 보고 주말에도 낮 시간 진료하여, 밤중에 아픈 아이들을 상급병원 응급실 대신 편히 진료 (우리 지역에 공공심야 어린이병원이 문을 열었어요!)할 수 있도록 한 제도적 노력이다. 수 여성병원은 산부인과를 중심으로 내과·외과·소아과까지 포괄하여 **완전 24시간 진료체계**를 갖춘 예로, 민간에서도 충분한 수요와 수익성만 담보된다면 365일 진료가 가능함을 보여준다 (秀여성 산부인과에 오신것을 환영합니다.).

해외의 경우 24시간 운영되는 **긴급진료센터(Urgent Care Center)**나 **가정의 야간당직 서비스**등이 유사한 역할을 한다. 미국의 긴급진료 클리닉은 늦은 밤까지 소아과나 일반의 진료를 하여 경증환자를 수용하고, 영국 NHS의 경우 야간·휴일에 일반의를 교대로 당직배치하여 전화상담이나 방문진료를 수행한다. 이처럼 국내외 사례 모두 **응급실과 일반외래의 중간 영역**을 메워주는 야간진료 모델을 통해 **환자 편의 증진과 의료자원 효율화**라는 목표를 달성하고 있다.

2. 진료 시간대별 운영 모델 비교 (평일/주말 야간 및 심야)

운영 시간대는 병원의 규모, 지역 수요, 인력 여건에 따라 다양하게 설계될 수 있다. 크게 (A) 연장 야간진료형과 (B) 24시간 심야포함형 두 가지 모델로 구분할 수 있다.

- **연장 야간진료형:** 통상 진료시간 이후 저녁 시간대까지 외래를 연장 운영하고 심야에는 휴식. 예를 들어 평일은 18시23시까지, 토요일은 16시24시까지, 일요일/공휴일은 주간에만 운영하는 형태이다 ([야간·휴일 진료 의료기관 안내 | 응급의료 | 식품·건강·의료 | 분야별 정보 | 경기도청](#)). 이러한 모델은 **달빛어린이병원** 등에서 채택하고 있으며, 야간 2차진료 수요(예: 밤늦은 열감기, 간단한 외상 등)를 커버하고, **심야(자정~새벽)**의 극소수 환자는 인근 응급의료기관으로 이송하는 전략이다.
- **24시간 심야포함형:** 말 그대로 24시간 끊임없이 외래진료가 가능한 모델이다. 중소병원급 이상에서 입원환자 관리와 연계하여 운영할 수 있으며, 예를 들어 수 여성병원은 평일 18시부터 다음날 9시까지 야간외래를 열고, 토요일 16시부터 월요일 9시까지 주말 내내 계속 진료를 본다 ([秀여성 산부인과에 오신것을 환영합니다.](#)). 이 모델은 **심야 시간대(0~6시)**에도 의사와 필수인력을 유지해야 하므로 부담이 높지만, 응급실이 아닌 별도 야간외래로서 환자를 24시간 받겠다는 적극적 운영 형태이다.

둘 사이의 선택은 병원의 환자군과 수요 예측에 따라 달라진다. 소아과의 경우 심야(자정 이후)에는 외래수요가 급격히 낮아지고 대신 응급실 수요로 전환되므로, 현실적으로 많은 달빛어린이병원은 23시까지만 운영하고 있다. 반면 산부인과나 외과의 경우 심야에도 응급 분만이나 급성질환(맹장염 등)이 발생할 수 있어 24시간 대기가 필요하다. 따라서 **혼합형** 전략도 고려된다. 예를 들어 내과·소아과는 **연장형(야간 ~자정까지만)**으로 두고, 산부인과·외과는 **심야포함 24시간 대기체계**를 갖추는 식으로 과별 특성에 맞춰 운영시간을 차별화할 수 있다.

또한 요일에 따라서도 모델을 조정할 수 있다. 평일에는 직장인 환자를 위해 야간 2~3시간 연장진료(19~21시 등)를 시행하고, 금요일 밤이나 주말에는 비교적 긴 심야당직을 편성하는 방법이다. 실제 경기도 지침에 따르면 “**평일 중 1일 이상 19시 이후까지, 토요일 16시 이후까지, 일요일 또는 공휴일 진료**”중 하나 이상 충족하면 야간/휴일진료기관으로 분류된다 ([야간·휴일 진료 의료기관 안내 | 응급의료 | 식품·건강·의료 | 분야별 정보 | 경기도청](#)). 이를 고려하여 평일 최소 1~2회 늦은 야간 클리닉 + 주말 주간진료를 조합하면, 의료법상 큰 제약 없이 야간진료기관으로 기능할 수 있다.

운영 시간 모델 비교 표:

위 모델들을 검토한 후 병원은 **자신들의 환자군 통계**(야간 내원 환자 수, 질환 패턴)를 분석하여 최적의 운영시간을 결정해야 한다. 시작은 (A)모델로 하되 수요 증가 시 (B)로 전환하거나, 반대로 심야 운영 인력 확보가 어려우면 (혼합형으로 일부 축소)하는 **탄력적 운영**도 고려할 수 있다. 핵심은 *해당 지역사회가 언제 의료공백을 느끼는지* 파악하여, ****“필요한 시간에 필요한 과를 열어두는 것”****이다.

3. 중소병원/전문병원 인력 구성 및 교대 모델

365일 야간진료를 위해서는 인력운영계획이 가장 중요하다. 특히 중소병원이나 전문병원에서는 제한된 인력으로 24시간을 커버해야 하므로 효율적인 ****교대제(shift)****와 **전담인력**배치가 필요하다. 주요 인력군별 고려사항은 다음과 같다.

- **의사**:내과, 외과, 산부인과, 소아과 각각 전문의를 확보하는 것이 이상적이다. 그러나 야간 시간대에 모든 전문의를 동시에 상주시킬 수 없다면, **당직의사 시스템**을 활용할 수 있다. 예를 들어 평소 주간에는 각 과 전문의를 충분히 두되, 야간에는 **2~3명의 의사가 교대로 모든 과를 커버**하도록 한다. 한 명은 **내과/소아과 계열**(내과 전문의가 소아 경증도 진료 가능토록)로, 다른 한 명은 **외과/산부인과 계열**(외과 당직의가 간단한 산과조치 가능토록)로 편성하는 방식이다. 응급 상황 시 해당 과 전문의를 ****콜(call)****로 부르는 체계를 갖추고, 평소에는 교차 진료를 허용하여 최소 인력으로 운영한다. 실제 지방 중소병원에서는 **2인 당직 체계**로 내과계·외과계 당직의를 두는 경우가 많다.
- **간호사**:간호인력은 3교대 근무가 일반적이지만, 야간진료 전담을 위해 **야간전담 간호사제**도를 활용할 수 있다. 최근 한 조사에 따르면 국내 167개 병원 중 103곳이 야간전담제, 79곳이 고정근무제 등을 시행 중으로, 3교대의 대안으로 **야간전담 및 유연근무제가 확산**되고 있다 (**'3교대' 대안으로 떠오른 '야간전담' 지속 가능한가**). 야간전담 간호사는 밤 시간대만 근무하고 주간에는 휴식을 취함으로써 **숙련된 야간전문 간호인력**을 확보할 수 있다. 또한 2교대(주간 12시간, 야간 12시간)로 운영하여 밤 근무 간호사에게 다음날 충분한 휴식을 주거나, **교대주기를 줄여** 한 번에 연속 3~5일 야간 근무 후 긴 휴무를 주는 **탄력 스케줄**을 적용하는 등 소진을 막는 전략이 필요하다.
- **행정/지원 인력**:접수/수납 업무 및 원무과 인력도 최소 야간에 1명은 필요하다. 낮보다 환자 수가 적으므로 **멀티태스킹 인력**을 두는 것이 효율적이다. 예컨대 야간 접수 직원이 병동 간호조무사의 역할도 일부 겸하거나, 진료보조 인력이 격일제로 행정업무를 맡도록 할 수 있다. 또한 기술지원 인력(임상병리, 방사선 등)은 상주가 어렵다면 **콜 대응체계**를 구축한다. 야간에 영상촬영이나 검사 수요가 발생하면 미리 지정된 당직 기술자가 30분 내 병원에 출근하도록 대기

시키는 방식이다.

교대 근무 모델:인력 규모에 따라 전일제 교대와 야간전담제를 혼합할 수 있다. 아래는 예시 교대표이다.

위 표는 하나의 예시이며, 실제로는 병원별로 근무일정표를 세밀히 조정해야 한다. 포인트는 **“적정 인원이 교대로 충분한 휴식과 보상을 받으며 근무”**하도록 하는 것이다. 특히 야간전담인력에게는 인센티브와 권한을 부여하여 낮에 일하는 직원과 동등한 존중을 받아야만 장기근속이 가능하다.

인력 확보 전략:야간진료를 안정적으로 운영하려면 추가 인력 확보가 필요할 수 있다. 이를 위해 ▲전공의나 임상강사를 야간 당직로테이션에 참여시키거나, ▲인근 병원이나 의료원과 협진 계약을 맺어 야간에 전문의를 파견 받는 방법도 고려된다. 예컨대 외과위가 부족한 중소병원은 지역 권역응급센터와 협약해 해당 센터 외과당직의가 필요 시 원격 자문 또는 현장 출장을 해주는 식이다. 다만 이러한 협력은 법적 테두리 내에서 이루어져야 하며, 사전에 충분한 업무 프로토콜을 마련해야 한다.

4. 야간진료 운영에 관한 제도적 허용 범위 및 조건 (의료법/복지부 기준)

법적·제도적 측면에서 365일 야간진료를 운영할 때 알아두어야 할 사항은 크게 세 가지로 정리된다: 의료기관 개설/운영에 대한 법규, 건강보험 수가 및 행정지원 제도, 노동법 및 근무기준이다.

- **의료법 상 운영 시간 제한:**현행 의료법은 병원이나 의원의 진료시간을 별도로 제한하지 않는다. 따라서 법적으로 야간이나 공휴일에도 의료기관을 운영하는 것은 허용된다. 다만, 응급환자를 전문적으로 보는 "응급의료기관"으로 지정받으려면 별도 기준을 충족해야 한다. 이번에 추진되는 법안에 따르면, 보건복지부 장관 또는 시도지사가 *야간 또는 휴일에 소아환자를 진료하는 의료기관*을 지정하고 행정·재정지원을 할 수 있도록 응급의료법 개정이 논의 중이다 ([야간·공휴일 소아진료 의료기관 운영 법으로 정한다? - 의협신문](#)) ([야간·공휴일 소아진료 의료기관 운영 법으로 정한다? - 의협신문](#)). 이는 즉, 앞으로는 일정 기준(진료과목, 운영시간 등)을 충족하는 병원을 공식 야간·휴일 진료센터로 지정하여 지원하겠다는 것이다. 현 시점에서 중소병원이 자체적으로 야간진료를 하는 데 법적 제약은 없으나, 향후 이러한 지정 제도가 도입되면 지정 요건을 충족하면 지원을 받을 수 있으므로 제도 변화에 맞춰가는 것이 좋다.
- **보건복지부 지침 및 지원:**복지부는 야간진료 활성화를 위해 여러 정책을 마련해왔다. 예를 들어 달빛어린이병원지정을 통해 야간 소아과 진료병원에 운영비 일부를 지원하고 있으며, 2023년 말에는 야간진료를 하는 의원·병원에 대해 건강보험 수가상 **야간진료관리료**를 신설하였다 ([보험인정기준 < 보험인정기준 < 제도·정책 <](#)

[건강보험심사평가원](#)). 이 관리료는 주당 야간진료 운영시간에 따라 등급(주 20시간 미만 ~ 50시간 이상)별로 산정되며, 이는 야간에 의료기관 문을 여는 데 따른 추가 비용을 보전하려는 취지이다. 또한 각 지자체도 조례를 통해 야간진료 참여 의료기관에 인센티브를 지급하거나 홍보지원을 하는 경우가 있다 ([야간·공휴일 소아진료 의료기관 운영 법으로 정한다? - 의협신문](#)). 다만 현재까지는 지역별 편차가 크므로, 병원은 관할 보건소 및 시도청과 협의하여 이용 가능한 지원책(예: 간호사 야간근무수당 보조, 시설비 지원 등)을 파악해야 한다.

- **응급의료 관련 조건:** 365일 야간진료체계를 구축하면 경증 응급환자를 많이 다루게 된다. 이 경우 법적으로 응급의료기관이 아니더라도 응급의료에 관한 법률의 일부 조항이 적용될 수 있다. 예컨대 *응급환자에 대한 우선적인 진료 의무나 다른 응급의료기관과의 연계체계 구축등*이 그것이다. 병원이 공식 응급실을 갖추지 않더라도, 지역 119구급대나 응급의료정보센터(e-gen)에 자신의 야간진료 운영시간과 연락처를 등록하여 응급환자 의뢰가 원활히 이루어지도록 하는 것이 중요하다.
- **노동법(근로기준법) 준수:** 야간에 근무하는 직원에 대해서는 노동법상 야간근로수당을 지급해야 한다. 근로기준법 제56조에 따르면 22시~익일 06시 사이 근로에는 통상임금의 50% 이상을 추가 지급해야 한다 ([Night Work and Its Health Effects: Focusing on the Relevant Laws and Regulations of the Republic of Korea](#)). 또한 18세 미만자나 임산부의 야간근로는 원칙적으로 제한된다 ([Night Work and Its Health Effects: Focusing on the Relevant Laws and Regulations of the Republic of Korea](#)). 병원이 3교대 근무를 운용할 경우 주 52시간제 등 근로시간 제한을 준수해야 하며, 최근 간호사 야간근무 가이드라인에 따라 야간근무 간호사에게 추가 특별수당지급 및 월 15회 이상 연속 야간근무 금지등의 기준이 권고되고 있다 (['3교대' 대안으로 떠오른 '야간전담' 지속 가능한가](#)) ([상급종합병원도 '간호사 야간근무 운영기관' 포함](#)). 이는 필수의료 인력의 이탈을 막기 위한 조치로, 병원은 이러한 지침을 인력운영에 반영해 법적 분쟁 없이 지속가능한 근무환경을 조성해야 한다.

정리하면, 365일 야간진료 자체는 제도적으로 허용되어 있고 오히려 정부도 권장하는 추세지만, 공식 지원을 받기 위해서는 일정 요건 충족 및 지정절차가 필요할 수 있다. 또한 추가 수가와 보조금등의 혜택을 최대한 활용하고, 노동법상의 의무를 준수하여 직원들에게 적절한 처우를 제공하는 것이 중요하다. 병원 경영진은 관련 법·제도 변화를 주시하면서 필요한 신고나 승인을 제때 받고, 지원사업이 있으면 적극 참여하여 재정적 뒷받침과 제도적 안전망을 확보해야 한다.

5. 야간진료 통합운영 시 과별 진료 특성 및 주요 진료 항목

야간에는 주간과 다른 질환 양상이 나타나거나, **과별로 특화된 응급/경증 환자군**이 존재한다. 따라서 내과, 외과, 산부인과, 소아과를 통합 운영할 때 각 과별로 어떠한 케이스가 주로 발생하고 어떻게 대비할지 알고 있어야 한다. 주요 진료 특성과 항목을 정리하면 다음과 같다.

- **내과(성인 내과 질환):**야간에는 급성 증상 악화로 내원하는 경우가 많다. 예를 들어 **고열, 급성 위장염으로 인한 탈수, 천식발작, 고혈압 응급증상, 당뇨병자의 고혈당/저혈당**등이 흔한 야간 내과 케이스이다. 또한 **흉통**이나 **호흡곤란**으로 오는 환자는 관상동맥질환이나 폐색전증 등 응급감별이 필요하므로 초기 안정화 조치와 신속한 응급의료기관 이송기준을 마련해야 한다. 내과 야간진료의 핵심은 **중증과 경증 판별**이다. 대부분은 감기, 장염 등 경증으로 외래처치 후 귀가하지만, **중증 환자를 놓치지 않도록**야간에도 혈액검사(예: 심장 효소), 산소포화도 모니터링, 흉부 X선 등의 **기본 diagnostic 툴**을 사용해야 한다. 주요 처치로는 수액 공급, 해열 및 진통제 투여, 산소치료 등이 있으며, 중환 의심 시는 지체 없이 상급병원 ER로 전원한다.
- **외과(일반외과 및 경미한 외상):**야간에는 크고 작은 **외상 환자**가 내원할 수 있다. ****열상(찢어진 상처)****이나 **찰과상**으로 인한 출혈 환자는 외과 야간진료의 단골 사례로, 지혈 및 봉합술을 시행해야 한다. 또한 **골절 의심 환자**(낙상이나 운동부상 등)도 오는데, X-ray 촬영 후 간단한 골절은 응급 부목 고정하고 큰 골절은 전문 정형외과 연계를 한다. **복부통증**으로 새벽에 오는 환자들도 있다. 예를 들어 **우하복부 통증**은 급성 충수염(맹장염)을 의심해야 하는데, 야간 진료에서 일정 시간 관찰하며 백혈구 검사나 초음파 결과를 보고 필요시 새벽에 응급수술을 할 수도 있고, 어렵다면 응급외과 있는 병원으로 보낸다. **담석증 산통**이나 **췌장염**등도 야간 복통 원인으로 오므로, 진통제 투여 등 초기조치를 하고 입원이나 전원을 결정한다. 외과 영역에서는 **응급수술이 필요한지를 가르는 판단력**이 중요하다. 대장천공이나 급성충수염처럼 수술 요하는 경우, **밤에 수술 가능한 시스템**이 없다면 즉시 전원해야 한다. 따라서 외과 야간진료 시 **항상 수술실 대기 여부**와 **전문의 소통체계**를 확보해 두어야 한다.
- **산부인과(산과 및 부인과 응급):**산부인과는 **24시간 대응**이 필수적인 과이다. **분만**은 언제든지 시작될 수 있으므로, 분만 시설이 있는 병원이라면 야간에 산과담당 의사와 간호사가 대비해야 한다. 특히 임신 말기의 산모는 **진통 발현**이나 **양막 파수**로 심야에 내원할 수 있는데, 이를 수용할 수 있어야 한다. 분만실 준비와 함께 **신생아실**인력도 대기해야 안전한 24시간 분만체계가 유지된다. 한편 **부인과 응급**으로는 **자궁출혈**이나 **임신 초기 유산 위험**등이 있다. 예를 들어 임신초기 여성의 질출혈은 절박유산 또는 자궁외임신(난관임신) 가능성이 있으므로, 야간에도 **질 초음파 검사**를 통해 확인해야 한다. 자궁외임신으로 의심되면 응급 개복수술이 필요할 수 있으므로 외

과와 협진하거나 바로 수술 가능해야 한다. 그 외에 **난소낭종 염전** (ovarian torsion)이나 **자궁근종 변성** 등 갑작스런 골반 통증을 호소하는 부인과 환자도 올 수 있다. 산부인과 야간진료 포인트는 ****“산모와 태아 둘의 생명”****을 함께 고려해야 하는 점이다. 따라서 산모의 활력징후 체크뿐만 아니라 **태아 심박동 모니터**등도 야간에 활용할 수 있게 준비해야 한다.

- **소아과(소아청소년과 야간진료):** 소아 환자는 밤에 상태가 급격히 나빠지거나 부모의 불안으로 야간에 병원을 찾는 일이 잦다. 가장 흔한 것은 **발열**이다. 영유아의 고열은 단순감염일 때가 많지만, **열성 경련**을 보이거나 **호흡곤란**을 동반하면 부모가 크게 당황하므로 신속한 조치가 필요하다. 야간 소아과에서는 해열제 투여 및 경련 시 **디아제팜** **직장투여**등의 응급처치를 한다. **크룹 증후군**(급성 후두개염 등으로 새벽에 개짖는 기침을 하는 질환)도 대표적인 야간 소아 환자로, 증상 발생 시 산소공급과 네블라이저 치료를 시행한다. 이외에 **구토와 설사로 탈수**된 영유아, **중이염**으로 새벽에 심한 통증을 호소하는 아동, **천식 발작**으로 쉼쉼거리는 소아 환자 등이 흔한 야간 케이스다. 소아과 야간진료는 아이들의 협조도가 낮고 증상이 급변할 수 있으므로 **숙련된 소아과 전문인력**과 **소아용 의료장비**를 갖추는 것이 중요하다. 부모에 대한 안심 설명도 치료의 일부이다. 달빛어린이병원 등의 경험에 따르면, ***“늦은 밤에도 전문 소아진료를 받을 수 있고, 응급실의 중환자들 사이에서 아이가 위축되지 않으니 안심된다”***는 부모들의 평가가 있었다 ([우리 지역에 공공심야 어린이병원이 문을 열었어요!](#)). 이는 곧 소아과 야간진료의 큰 장점으로, 친근하고 안정적인 환경을 조성하여 **소아 환자와 보호자의 불안 감소**에 주력해야 한다는 점을 시사한다.

위에서 살펴본 사례를 **과별 주요 진료항목/증상**으로 요약하면 다음과 같다. 이처럼 **과별 특성에 맞게 시설과 인력을** 준비해야 한다. 특히 ****공통적으로 중요한 것은 “이 환자를 우리 병원에서 끝까지 볼 수 있는가, 아니면 일정 처치 후 이송해야 하는가”****에 대한 결정이다. 야간에는 상급병원 인력도 제한적이므로, 경증환자는 최대한 자체 해결하고 **진짜 응급 중증환자만 적시에 이송**하는 것이 지역의료체계에 도움을 준다. 이를 위해 각 과별로 **야간에 수행할 수 있는 처치의 범위와 한계**를 미리 정해두고 프로토콜화하는 것이 좋다. 예를 들어 “산과 대출혈로 수혈 필요 시 ○○병원으로 이송” 또는 “소아 경련 10분 이상 지속 시 ○○대학병원 NICU 이송” 등 구체적 기준을 세워 두면, 야간에 최소 인원으로도 안전한 진료가 가능하다.

또한, **진료 후 귀가한 환자**에 대한 **사후관리**도 중요하다. 야간에 온 환자는 다음날 주간 외래 follow-up이 필요할 수 있다. 각 과 주치의에게 밤에 본 환자 정보를 인계하여 **연속 진료**가 이뤄지도록 하고, 필요한 경우 환자에게 **야간진료 확인서**나 **요약 차트**를 제공하여 본인 주치의에게 전달하게 하면 의료의 연속성과 환자 안심에 도움이 된다.

6. 운영 수익 구조 및 비용 모델, 수익성 개선 전략

365일 야간진료 시스템은 추가적인 인력과 설비 가동을 필요로 하기 때문에 비용 부담이 증가하지만, 반대로 야간 환자시장을 선점함으로써 새로운 수익을 창출할 기회도 있다. 운영의 수익구조와 비용요인을 분석하고, 수익성을 높이기 위한 전략은 다음과 같다.

(1) 수익 구조 요소:

- **진료 수입 (건강보험 및 본인부담금):** 야간에 내원한 환자에게도 통상적인 진찰료, 검사료, 처치료 등이 발생한다. 여기에 야간 가산이 붙는다. 한국의 건강보험제도에서는 평일 18시 이후(토요일 13시 이후) 진료에 대해 진찰료 30% 가산이 적용된다 (진찰료·조제료 야간가산료 적용시간대 변경 < 보도자료 > 알림 : 힘이 되는 평생친구, 보건복지부). 즉 환자가 야간에 진료를 받으면 주간보다 약간 높은 본인부담금을 내게 되고, 이는 병원의 수입 증가로 이어진다. 또한 2023년 11월부터는 야간진료관리료가 신설되어 일정 기준(예: 주 40시간 이상 야간운영)에 해당하면 별도의 관리료를 청구할 수 있게 되었다 (보험인정기준 < 보험인정기준 < 제도·정책 < 건강보험심사평가원). 예를 들어 주당 야간진료 50시간 이상 운영기관은 AC011 코드를, 20시간 미만은 AC015 코드를 산정하는 식으로 운영시간에 따른 추가 수가를 얻는다. 이 관리료 수입은 야간 운영의 상시적 보상이므로, 가급적 최고 구간 요건(주 50시간 이상 야간진료 등)을 충족해 최대한의 수가 혜택을 받는 것이 유리하다.
- **처치 및 수술 수입:** 야간에도 투여한 주사나 시행한 처치, 응급 수술 등이 있으면 수입이 발생한다. 특히 응급수술의 경우 건강보험 수가에 응급 가산이 적용되어 평시보다 50~100% 높은 수가를 청구할 수 있다 (응급진료 보상 강화...야간·휴일 응급수술 최대 175 가산 - 메디포뉴스). 예를 들어 평일 야간에 응급수술을 하면 주간보다 1.5배 수가가 책정된다. 병원이 직접 응급수술을 집도할 수 있으면 이러한 수익도 얻겠지만, 중소병원 현실상 큰 응급수술은 어렵다면 해당 부분은 포기해야 한다. 대신 간단한 응급처치(봉합, 정복술 등)나 응급분만등은 직접 시행하여 수입을 확보한다.
- **약국 및 처방 연계:** 야간진료 후 환자가 처방전을 받으면, 약국이 문을 닫았을 시간대일 수 있다. 이때 원내조제가 가능하면 약품비 수입으로 연결된다. 병원급 의료기관은 원내조제가 가능하므로, 야간에도 필수 약물을 비치해두고 조제하면 환자 편의와 수입 증가 두 마리 토끼를 잡는다. 의원급일 경우 원내조제가 불가하므로, 당번약국과 연계하여 환자가 약을 받도록 해야 한다. 당번약국 정보는 응급의료정보센터 등을 통해 공유되므로 (메디포뉴스), 병원에서 해당 정보를 제공해주면 환자가 약을 구하는데 불편을 줄일 수 있다. 약국과 협력하여 야간 조제료 가산에 따른 약국 수입 일부를 병원에 커미션으로 지급하는 비즈니스 모델도 고려할 수 있으나, 이는 현행 약사법상 어려울 수 있어 신중해야 한다.

- **기타 수익:** 24시간 운영을 활용한 부가서비스를 개발할 수 있다. 예를 들어, 간단한 **야간 건강검진 패키지**(늦은 시간에 와서 피검사 등 기본검사를 받고 아침에 결과 상담)는 근로자들이 선호할 수 있다. 또 미리 예약을 받아 **야간 소수정예 건강강좌**(임산부 교실 등)를 운영하면 참가비 수입과 함께 병원 홍보 효과도 얻는다. 이러한 부가서비스는 직접적인 수익보다는 **야간 운영 활용도 제고와 부수적 수입** 차원에서 검토된다.

(2) 비용 구조 요소:

- **인건비:** 단연 가장 큰 비중을 차지한다. 의사, 간호사, 기사 등 **야간 근무 수당**까지 포함된 인건비는 주간 대비 1.5배 이상으로 계산해야 한다 ([Night Work and Its Health Effects: Focusing on the Relevant Laws and Regulations of the Republic of Korea](#)). 예를 들어 간호사 1인의 야간근무시간(22~익일6시)에 대해 기본급의 50% 추가수당이 법정 지급되므로, 동일 인력을 24시간 운용하면 인건비가 크게 상승한다. 따라서 **야간전담 인력**에는 별도 수당 책정이 필요하며, 이는 비용측면 부담이다. 아울러 심야에 호출 대기하는 인력(예: 영상기사 대기수당) 등도 발생할 수 있다. 이 인건비를 상쇄하려면 앞서 언급한 야간수가 수입들이 필수적이다. 정부의 **야간간호수당 지원사업**등을 활용해 일부 보전받을 수도 있다.
- **설비 유지비:** 24시간 조명, 공조, 의료장비 가동으로 **전기료 등 공과금**이 증가한다. 특히 MRI, CT같이 대형 장비를 보유한 경우 대기전력 소모도 있으므로, 심야에 사용하지 않을 때는 절전모드로 두는 등 관리가 필요하다. 또한 의료소모품(거즈, 봉합세트 등) 사용량이 늘고 예비재고를 더 확보해야 하므로 재료비 지출도 약간 증가할 것이다.
- **보안/안전 비용:** 야간에는 병원 문을 열어놓으면 보안 이슈가 있다. 따라서 **야간 보안인력(경비)**을 두거나, 최소한 CCTV 모니터링 시스템을 강화해야 한다. 만일의 폭력사고 등에 대비해 숙련된 남성 직원 배치나 경찰과의 비상연락망 구축도 필요하다. 이러한 안전대책에도 비용이 소요된다.
- **기회비용:** 직원 피로도 증가로 인한 생산성 저하, 야간운영으로 주간에 일부 외래를 축소해야 하는 경우 등의 **간접 비용**도 고려된다. 예컨대 의사가 밤 근무 후 낮에 휴무를 가지면 그 시간의 외래수입이 감소하는 식이다. 이는 직접비용은 아니지만 병원 전체 수익률에는 영향을 줄 수 있다.

(3) 수익성 개선 전략:

- **수가 체계 최대 활용:** 앞서 언급한 **야간가산진찰료, 야간진료관리료, 응급처치 수가**등을 빠짐없이 청구해야 한다. 건강보험 청구 인력(청

구팀)이 야간진료 관련 산정지침을 숙지하도록 교육하고, 혹시 새로 신설된 수가(예: 관리료 등)가 누락되지 않게 전산 점검한다. 특히 달빛어린이병원 등으로 지정된 경우 야간 가산 외 추가 보조금이 있을 수 있으므로, 이를 정산받는 절차를 챙긴다.

- **환자 회전을 제고:**야간에 온 경증 환자를 가능한 한 병원 내에서 모두 해결하고 귀가시키면 수익으로 바로 연결된다. 반대로 경증임에도 괜히 상급병원으로 보냈다면 해당 환자에 대한 진료비는 고스란히 놓치는 셈이다. 따라서 **처치 프로토콜**을 숙달하여 웬만한 환자는 입원이나 이송 없이 외래처치 후 돌려보내 수익화한다. 필요한 경우 **단기관찰실(Observation room)**을 운영하여 몇 시간 수액치료를 하고 새벽에 상태 호전되면 귀가시키는 방식도 좋다. 이는 입원처리보다는 낮은 수가이지만, 병상 없이 외래 영역에서 추가 수입을 얻는 방법이다.
- **연계 입원 및 추가진료 유도:**물론 입원이 필요한 환자는 입원시키는 것이 병원에도 이득이다. 야간에 입원한 환자는 다음날 추가 검사나 수술 등의 수입을 발생시킬 수 있다. 또한 야간진료를 받은 환자에게 **다음날 본원 외래 재방문**을 안내함으로써 지속적인 의료 이용을 유도한다. 예를 들어 “오늘 밤에는 임시로 조치했으니, 내일 소화기 내과 외래에서 꼭 진료 이어서 보세요”라고 하면 환자는 신뢰를 갖고 다시 찾아오며, 이는 **고객 충성도**와 수익 증대로 이어진다.
- **비보험 진료 및 부가서비스:**야간에는 급하지만 보험 안 되는 진료수요도 발생한다. 예를 들어 심야에 치과가 안 열었을 때 간단한 치과 응급(치아 완전 탈구 등)을 처리해주고 비보험 진료비를 받을 수도 있다. 혹은 **심리상담/정신과 진료**를 야간에 희망하는 경우 별도 예약을 받아 유료상담을 하는 등 새로운 서비스를 창출한다. 단, 이러한 비보험 서비스는 주력은 아니므로, **환자 요청이 있을 때 놓치지 않고 제공**하는 수준으로 운영해 추가수익을 올린다.
- **원가 절감 노력:**수익 증대와 함께 비용 절감도 수익성 개선에 중요하다. 야간 시간의 **낭비요소 최소화**가 관건인데, 예를 들어 불필요하게 모든 공간의 불을 켜둘 필요는 없다. 진료구역 위주로만 조명을 유지하고 일부층은 소등하면 전기료를 아낄 수 있다. 또 야간에는 환자 수가 적으므로 **물품도 소량만** 오픈하여 사용하고, 사용하지 않은 멸균세트 등은 다시 낮에 활용하도록 관리한다. **인력운영의 다기능화**(한 사람이 여러 업무 겸임)로 최소인력으로 돌리는 것도 원가 절감에 효과적이다.
- **정부/지자체 지원사업 참여:**수익성이 낮더라도 공공의료 측면에서 가치가 크다면, 정부나 지자체의 **보조금을 확보**하는 전략도 필수다. 예를 들어 소아과 야간진료를 지속하면 지방자치단체에서 연간 운영보조금을 지원하는 사례가 있다 ([야간·공휴일 소아진료 의료기관 운영 법으로 정한다? - 의협신문](#)). 또 **지역 응급의료기금**을 통해 장비비나 인건비 지원을 받을 수 있는지 알아본다. 이러한 외부 자원

은 병원의 순이익에는 잡히지 않지만 실질적으로 수익 개선에 큰 도움이 된다.

요약하면, 365일 야간진료는 초기에는 비용이 많이 드나한 번軌道에 올라 환자수가 증가하면 규모의 경제가 작용하여 수익성이 좋아질 수 있다. 관건은 **“초기 적자를 견딜 수 있는가”**인데, 이를 위해서는 위의 다양한 전략으로 **수익분기점을 앞당기는 노력**이 요구된다. 특히 정부의 지원과 보험수가 체계를 최대한 활용하고, 지역사회 환자들을 끌어모아 **충분한 환자량 확보**를 이뤄낸다면 장기적으로 수익 창출은 충분히 가능하다.

7. 관련 설비 및 기술 인프라 요건

365일 야간진료를 뒷받침하려면, 하드웨어와 소프트웨어 측면에서 추가적인 인프라가 필요하다. 주간진료와는 다른 환경이므로, 환자안전과 업무효율을 위해 다음과 같은 설비와 기술 시스템을 준비해야 한다.

- **응급처치 장비:**야간에는 상태가 급변하는 환자가 있을 수 있으므로, **응급장비**를 완비해야 한다. 산소 치료가 필요할 경우를 대비하여 중앙산소공급라인 및 산소통, 산소마스크(성인/소아용)를 준비한다. **제세동기(AED)**는 필수이며, 응급카트에는 기관삽관 세트, 앰부배기, 흡인기, 응급약물(아드레날린, 응급해열제 등)이 항상 채워져 있어야 한다. 또한 **분만세트나 소아소생세트**처럼 과별 특화 응급키트를 마련해두면 상황 발생 시 신속히 대처할 수 있다.
- **진단 검사 인프라:**야간에 기본적인 검사와 영상촬영을 할 수 있어야 한다. 최소한 **X-ray실과 초음파기**는 24시간 사용 가능 상태로 유지한다. 혈액검사의 경우 응급 CBC, 생화학, 전해질 정도를 측정할 수 있는 **POCT 장비(현장검사기)**가 있으면 유용하다. 예컨대 5분 내 결과가 나오는 혈액가스분석기나 심근효소 측정키트 등을 두면 중증환자 감별에 도움이 된다. 만약 CT나 MRI 등 고급영상 장비가 있다면 야간에도 필요시 가동할 수 있도록 하고, 인력이 없으면 원격판독을 활용한다. 기술적으로 **원격판독 시스템**을 구축하여 야간 촬영 영상을 전문의가 집에서 판독해주는 체계를 마련할 수 있다.
- **전산(차트) 시스템:**병원정보시스템(HIS)은 24시간 가동되어야 한다. 야간진료 전용으로 별도 차트를 쓰는 경우는 거의 없고, 주간과 동일한 EMR을 사용하되 **야간 모드**로 운영한다. 다만 전산 담당자는 야간에 시스템 장애 발생 시 원격으로라도 대응할 수 있어야 한다. **백업 전산망**(예: 이중화 서버 또는 수기 백업체계)도 준비하여 만일 서버다운 시에도 수기 처방전 등으로 환자를 볼 수 있게 플랜B를 만들어둔다.
- **통신 및 응대 시스템:**야간에는 전화문의가 많을 수 있다. “지금 열었나요?” “어떤 과 의사가 계신가요?” 등 확인전화가 오므로, **24시간 대표전화 응대**가 필요하다. 이를 위해 교환실을 밤에도 두거나,

최소한 당직원이 전화를 받을 수 있게 **무선 전화기**를 소지하도록 한다. 또한 **야간전용 안내 ARS**를 만들어 자주 묻는 사항은 자동안내 되게 할 수 있다. (예: 운영시간, 오는 방법 등) 응급 상황 연락을 위한 **핫라인**도 구축한다. 병원 내부적으로는 야간 근무자 간에 **무전기**나 **호출기**를 지급해 위급상황 시 빠르게 서로 연락할 수 있게 한다.

- **보안 및 출입통제**: 앞서 언급했듯이 야간 보안은 중요하다. **출입문을 통제**하여 한 곳으로만 환자가 출입하게 유도하고, 그 지점에 CCTV와 비상벨을 설치한다. 간호 스테이션 등에도 비상벨을 두어 진료 중 위급 상황(보호자 폭력 등) 발생 시 경비가 즉각 출동하도록 연계한다. 건물 외부 조명도 충분히 밝혀서 환자와 직원 모두 심야에도 안정감을 느끼게 한다.
- **대기공간 환경**: 야간에 찾는 환자들은 대개 불안한 상태이므로, 대기실 환경을 쾌적하게 유지하는 것이 생각보다 중요하다. 최소 인원 근무 시에도 환자가 혼자 방치되지 않도록 **대기실 CCTV를 원무 데스크에서 모니터**하고, 필요하면 스피커로 안내방송을 할 수 있게 한다. 아이 환자가 올 것을 대비해 **소아 대기공간에 간이침대나 장난감**을 두면 보호자 안심에 도움이 된다.
- **전력 및 설비 유지**: 24시간 운영에는 **예비전원** 확보가 필수다. 정전시 비상발전기가 자동 가동되도록 점검하고, 중요 부위(수술실, 분만실 등)는 무정전 전원공급장치(UPS)를 설치해둔다. 심야에 냉난방이 중단되지 않도록 HVAC 시스템도 24h 모드로 설정하거나 타임스케줄을 조정한다.
- **약품 및 물품 관리**: 야간을 대비해 **응급상황 대비 물품**은 항상 유효기간 내 충분히 비축한다. 특히 수혈용 혈액은 소량이라도 구비하거나, 없으면 근처 혈액원에서 긴급공급 받을 루트를 확보한다. 독극물중독 해독제 등 평소 잘 쓰지 않지만 야간 응급에 필요한 약품목록을 정해 소량씩 갖춰놓는다.
- **기술 인프라 (정보연계)**: 야간진료를 하려면 **응급의료정보망지역병원 네트워크**와의 연결이 중요하다. 병원은 보건복지부 응급의료포털(e-gen)에 **자신의 의료기관 정보를 최신 상태로 등록**해두어야 한다. 그래야 환자나 119에서도 우리 병원이 열려 있는지를 알고 환자를 보낼 수 있다. 또한 인근 응급실이나 타병원과 **환자 의뢰를 위한 온라인 시스템**(예: 영상 전송, 문서 교환)을 구축하면 전원 시 시간 단축에 도움이 된다.

요약하면, **365일 야간진료**를 위한 인프라는 기본적으로 **주간병원의 설비를 연장 활용**하는 것이지만, **끊임없는 서비스**를 위해서는 전기/전산 등의 **기술적 백업**과 **응급 대응 장치**들을 강화해야 한다. 초기 구축비용이 부담될 수 있으나, 안정적인 야간진료가 병원의 신뢰도를 좌우하기 때문에 **인프라 투자**

는 필수불가결한 부분이다. 병원은 정부의 의료기관 시설 현대화 지원사업 등이 있다면 활용하여 재정부담을 줄이고, 자체적으로도 정기적인 설비 점검과 모의훈련(야간 정전대응 훈련 등)을 통해 만반의 준비를 해야 할 것이다.

8. 지역 주민 접근성 강화 및 홍보 전략

365일 야간진료 시스템의 성공은 지역 주민들이 이를 잘 알고 쉽게 이용하는 데 달려있다. 아무리 훌륭한 야간진료 체계를 갖춰도 정작 주민이 몰라서 이용하지 않으면 유지되기 어렵다. 따라서 접근성을 높이고 효과적으로 홍보하는 전략이 필요하다.

- **지역 공공기관 연계:** 지역 보건소, 소방서(119구급대), 경찰서 등 공공기관과의 공조가 중요하다. 보건소를 통해 해당 병원이 야간진료를 실시한다는 것을 지역주민에게 홍보할 수 있고, 119구급대에는 우리 병원의 야간진료과목과 가능 처치에 대한 정보를 공유하여 **경증 환자는 우리 병원으로 이송**하도록 협력한다. 실제로 응급구조대는 환자를 응급실로 이송할지, 야간진료 가능 병원으로 갈지 판단해야 하는데 이때 정확한 정보를 제공하면 우리 병원으로 오는 환자수를 늘릴 수 있다. 또한 지역의 학교, 어린이집, 산모교실 등과 연계하여 **홍보 리플렛**을 배포하면 효과적이다 (예: “아이가 밤에 아플 땐 달빛어린이병원 OO의원을 찾아주세요” 같은 안내).
- **온라인 및 모바일 홍보:** 현대인들은 대부분 정보를 스마트폰으로 얻는다. **병원 홈페이지** 및 SNS 계정을 통해 365일 야간진료 시스템을 대대적으로 홍보해야 한다. 홈페이지 첫 화면에 **야간진료 시간과 대상과목**을 보기 쉽게 표시하고, 네이버 지도나 카카오맵 등에 병원 정보를 업데이트하여 “24시 진료” 등의 키워드로 검색될 수 있게 최적화한다. 특히 응급의료포털 E-Gen이나 보건복지부의 달빛어린이병원 안내사이트 등에 **우리 병원의 진료시간과 연락처가 정확히 등록**되어야 한다 ([우리 지역에 공공심야 어린이병원이 문을 열었어요!](#)). 많은 환자들이 네이버에 “야간진료 병원 ○○시” 등으로 검색하므로, 블로그나 카페 등에 홍보글을 작성하여 병원이 검색결과 상위에 노출되도록 하는 것도 필요하다. SNS를 통해서서는 실제 야간진료 사례(환자 후기, 만족도 높았던 이야기 등)를 소개하여 **입소문 효과**를 노린다.
- **커뮤니티 접근성:** 병원이 위치한 지역의 **교통 접근성**을 높이는 것도 고려된다. 야간에는 대중교통이 끊기기 쉬우므로, 병원 자체 셔틀버스를 밤 시간대 운행하거나, 가까운 거리에 있는 주민을 위해 **심야왕진 서비스**를 제한적으로 제공하는 방안도 있다. 예를 들어 “밤 10시 이후 거동 불편 환자 전화 시 간호사 동행 방문진료” 같은 서비스를 하면 독거노인 등이 많이 이용할 수 있다. 물론 범위를 무제한으로 넓히긴 어렵지만, 타깃층을 정해 접근성을 높이면 병원에 대한 신뢰와 호감이 올라간다.

- **편의시설 및 환경 개선:**주민들이 야간에도 병원을 거리낌없이 찾으려면 **심리적 접근성**도 중요하다. 야간진료 대기실에 **편의시설**을 마련하면 환자 유인에 도움이 된다. 예컨대 24시간 편의점이나 자판기를 병원 내 설치하여, 보호자들이 밤에 요기를 할 수 있게 하거나, 무료 Wi-Fi와 휴대폰 충전스테이션을 제공하여 대기시간 부담을 줄인다. 또한 주차장을 야간에는 무료로 개방하거나, **발렛 서비스**를 두어 어두운 밤길에 주차 스트레스를 덜어주면 특히 여성환자나 노약자의 접근성이 올라간다.
- **지역 밀착 홍보 캠페인:**병원 인근 지역에 **현수막**이나 **옥외 간판**을 설치해 “365일 야간진료”를 알리는 것은 기본이다. 더 나아가 지역 축제나 장날 등에 부스를 열어 무료 혈압측정, 응급처치 교육 등을 하면서 자연스럽게 **우리 병원의 24시간 운영**을 알릴 수 있다. 주민 센터 게시판이나 아파트 단지 게시판에도 홍보문을 붙이고, 지역신문이나 소식지에 기고문을 내 **야간에도 문 여는 병원**으로서 이름을 알린다. 홍보 문구는 “OO지역민 여러분, 이제 야간에도 걱정마세요. 저희 병원이 항상 켜져 있습니다.”등의 친근하고 안심을 주는 톤으로 한다.
- **온라인 예약 및 상담 시스템:**환자 입장에서 밤에 병원에 갔는데 대기시간이 길면 불편할 수 있다. **온라인 예약 시스템**을 도입하면 환자가 오기 전에 대략적인 시간을 조율할 수 있다. 예를 들어 모바일 앱이나 웹으로 “지금 진료가능/대기 2명” 등의 정보를 보여주고 간단한 증상을 미리 입력받으면, 의료진도 대비하고 환자도 헛걸음하지 않을 수 있다. 또한 간단한 증상은 **온라인 상담**으로 해결해줄 수도 있다. 이것은 수익에는 직접 연결되지 않을 수 있으나, 오히려 친절한 상담으로 신뢰를 주면 다음번에 실제로 내원하는 계기가 될 수 있다.
- **만족도 조사와 피드백:**초기에 야간진료를 시작하면 이를 이용한 주민들을 대상으로 **만족도 설문**을 받아본다. 어떤 경로로 알게 되었는지, 불편했던 점은 무엇인지 피드백을 수집하여 홍보 전략과 운영 개선에 반영한다. 예를 들어 “병원 입구가 어두워 찾기 힘들었다”는 의견이 많으면 입구 조명을 늘이고 안내표지판을 설치한다. “대기실이 추웠다/더웠다”면 환경을 조절한다. 이런 **지속적인 개선 노력** 자체도 다시 홍보 포인트가 되어, 지역사회에 병원이 소통하고 있음을 보여줄 수 있다.

결국 **접근성 강화와 홍보**의 핵심은, 지역 주민들에게 ******“믿을 수 있는 우리 동네 24시 병원”******이라는 이미지를 심어주는 것이다. 이를 위해 공공채널, 온라인채널, 오프라인채널을 모두 활용한 **다각도 홍보**가 필요하다. 또한 일회성 홍보에 그치지 않고, **지속적인 정보 업데이트와 관계 구축**이 중요하다. 예컨대 계절별로 유행 질환에 맞춰 (“독감 유행시 야간진료 안내”, “여름 휴가철 응급상황 대비 24시간 진료” 등) 홍보테마를 바꾸어 꾸준히 노출시킨다. 이렇게 하면 주민들도 서서히 인지도가 높아져, **응급실 갈까 망설이다가**

도 이왕이면 가까운 우리 병원을 찾게 되는 효과를 기대할 수 있다.

9. 지속 가능한 근무 환경을 위한 인센티브 및 탄력 근무제 등 인력관리 방안

365일 야간진료 체제의 유지를 위해서는 무엇보다 거기에 투입되는 인력의 사기와 건강을 관리해야 한다. 밤낮없이 돌아가는 병원을 만들었지만 정작 의사와 간호사가 지쳐 떠나버리면 시스템은 유지될 수 없다. 따라서 **인센티브 부여, 근무형태 개선, 소진 방지 대책** 등 인적자원관리 전략이 필수적이다.

- **야간근무 인센티브 (금전적 보상):** 법정 야간수당(통상임금의 50% 가산)뿐만 아니라, 병원 자체적으로 **추가 수당**이나 상여금을 지급해 야간근무의 가치를 인정해야 한다. 최근 정부도 야간간호인력에 대해 별도의 **야간간호특별수당** 지급을 의무화하는 방향으로 가고 있다 ([상급종합병원도 '간호사 야간근무 운영기관' 포함](#)). 병원은 야간근무자에게 기본 시급의 예를 들어 **1.5배 + α** 의 수당을 책정하거나, **야간근무 횟수별 보너스**를 줄 수 있다. 예를 들어 한 달에 야간교대 8회 이상 하면 추가 보상금 X만원, 12회 이상이면 Y만원 이런 식으로 단계별 인센티브를 설정한다. 특히 의사의 경우 야간진료로 인한 추가 수익이 발생하므로, 이를 **성과급**형태로 일부 공유하는 것도 고려된다. (예: 야간에 실시한 처치/수술 수가 총액의 몇 %를 담당 의사에게 지급).
- **탄력 근무제 도입:** 고정된 3교대보다는 **유연근무제**를 도입하면 직원들의 삶의 질을 높일 수 있다. 일부 병원에서는 2교대나 야간전담제를 이미 도입했으며, ***“야간전담 및 유연근무 간호사 제도”***가 확대되는 추세이다 ([‘3교대’ 대안으로 떠오른 ‘야간전담’ 지속 가능한가](#)) ([‘3교대’ 대안으로 떠오른 ‘야간전담’ 지속 가능한가](#)). 탄력근무의 예로, **선택적 근로시간제**를 적용해 직원이 한 달 단위로 자신의 근무 일정을 부분 조정하도록 할 수 있다. (물론 필수 야간 slot은 메워야 하지만, 원하는 날을 휴무로 선택하게 하는 등 자율권 부여) 또한 **야간-휴일 묶음 근무연속 휴식 보장**방식이 효과적이다. 예를 들어 5일 연속 야간근무 후 5일 연속 휴무를 주는 식으로, 근로자는 휴가처럼 쉴 수 있어 호응이 좋다. 이런 탄력 스케줄은 교대편성은 조금 어렵게 만들지만, **장기적으로 인력 이탈을 막고 숙련된 인력이 남는 효과**가 있다.
- **직원 건강 및 편의 지원:** 야간교대자는 수면장애, 소화기 문제 등에 시달리기 쉽다 ([‘3교대’ 대안으로 떠오른 ‘야간전담’ 지속 가능한가](#)). 병원은 야간근무자들의 건강을 챙기기 위한 프로그램을 운영할 필요가 있다. 예컨대 **정기건강검진**항목에 수면클리닉 상담을 추가해주거나, **영양제 지원**(야간 근무자에게 월 1회 비타민 수액 무료 등) 혜택을 줄 수 있다. 또한 근무 중 휴게시간에 **수면실**에서 제대로 쉴 수 있게 수면실 환경(편한 침대, 커튼, 귀마개 등)을 개선한다. 야식

이나 간식을 병원에서 무료 제공하여, 밤중에 허기지지 않도록 배려하는 것도 사소하지만 인기있는 복지이다. 어떤 병원은 야간교대 간호사들에게 전문 마사지사 월 1회 불러 피로회복을 돕는다고도 한다. 이런 세심한 건강지원은 직원들의 심리적 보상감을 높여준다.

- **경력 개발 및 인정:**야간에 일하는 직원들이 낮 근무자 대비 소외감을 느끼지 않도록 해야 한다. 종종 병원에서는 주간직원 위주로 회의나 교육이 이뤄져 야간전담들이 참여 못하고 정보에서 소외되는 경우가 있는데, 이를 경계해야 한다. **주요 공지사항은 교대 간 인수인계를 통해 확실히 공유하고, 필요하면 별도로 야간직원 대상 추가 브리핑 시간**을 갖는다. 또한 야간전담 간호사 등에게 **수당 외에 별도 포상**(예: 6개월 이상 지속 근무 시 표창과 포상휴가)을 실시하여 그들의 노고를 인정한다. 인사고과에서도 야간근무 가산점을 부여해 승진 등에 불이익이 없도록 하고, **교육 기회**(학회나 연수 참여 등)도 동등하게 부여한다. 요컨대 "**야간에 일해도 커리어에 전혀 손해가 없다**"는 인식을 심어주는 것이 중요하다.
- **인력 풀(pool) 확보:**야간인력에 갑작스런 결원이 생길 경우 대비책도 필요하다. 이를 위해 **파트타임 인력풀**을 만들어 두는 것이 좋다. 예를 들어 대학병원 전공의 출신 초빙의사들을 몇 명 리스트업해두고, 해당과 야간 당직의 공석 시 단기 알바 형태로 와줄 수 있게 한다. 간호사도 마찬가지로 프리랜서 간호사나 휴직 중인 인력을 임시 고용할 수 있도록 인력풀을 운영한다. 평소에는 쓰지 않더라도 **비상시 대체인력 투입계획**이 있으면 상시인력들의 부담이 줄어든다. "아프면 쉬어도 내가 빠진 자리에 올 사람이 있다"는 안도감이 중요한 것이다.
- **직원 의견 수렴:**지속가능한 근무환경은 일방적으로 경영진이 만드는데 아니라 **현장의 목소리**를 반영해야 한다. 주기적으로 야간근무자를 대상으로 **설문조사**나 간담회를 열어 애로사항을 듣고 개선점을 찾는다. 예를 들어 "야간에 이럴 때 힘들었다"는 경험을 모으면, 거기서 아이디어가 나온다. 어떤 병원에서는 야간에 위험한 상황이 많다는 간호사 의견을 듣고 **보안요원 순찰 횟수**를 늘렸더니 모두 안심하고 일하게 된 사례도 있다. 이러한 **Bottom-up 피드백 체계**를 통해 근무환경을 지속적으로 업데이트해나가면 직원들의 만족도가 올라가고, 결과적으로 야간진료 서비스의 질도 유지된다.
- **정서적 지원 및 팀 문화:**주간에 비해 야간근무는 고립감을 느낄 수 있다. 소수 인력만 있으므로 **팀워크와 사기 진작**이 중요하다. 그래서 야간조 직원들만의 **작은 행사**를 마련하는 것도 방법이다. 예컨대 "**야간근무자 달래기 피자데이**"를 한 달에 한 번 열어 병원장이 직접 밤 10시에 피자를 돌린다든지, **가족 초청**(밤에 일하는 모습을 가족이 이해할 수 있게 초청하는 이벤트) 등을 통해 **직원들이 자부심**을 느끼게한다. 또 야간조 간 서로 친밀감을 쌓도록 ****팀 단합 활동**(번개모임)**도 지원할 수 있다. 간호부서 내에 "나이트 간호사 회식

비”를 예산으로 책정해준다거나 하는 식이다. 이렇듯 직원들의 마음을 챙기는 문화를 조성하면, 힘든 순간에도 서로 돕고 버티며 근무하는 데 큰 힘이 된다.

종합하면, 인력관리의 궁극적인 목표는 야간근무가 고통이나 희생이 아닌 하나의 전문분야로 인정받도록 만드는 것이다. 야간전담 간호사가 하나의 커리어 패스가 되고, 야간진료 의사가 존중받는 분위기가 형성되면 인력 운용은 안정된다 ('3교대' 대안으로 떠오른 '야간전담' 지속 가능한가). 병원은 이를 위해 물질적 보상 + 안정된 근무제도 + 심리적 보람이 세가지를 모두 제공해야 한다. 초기에는 추가 비용과 노력이 들지만, 장기적으로 경험 많고 헌신적인 야간 전문인력의 확보는 병원의 큰 자산이 된다. 결과적으로 이러한 인력이 환자에게 양질의 야간진료를 제공하게 되고, 시스템은 지속 가능해지는 선순환이 이루어진다.

以上の 분석과 전략을 통해 365일 야간진료 시스템을 구축·운영하면, 지역사회 의료서비스의 공백 시간을 메우고 주민들의 의료접근성을 획기적으로 개선할 수 있을 것이다. 중요한 것은 각 항목별로 제시한 실행전략을 병원 현실에 맞게 커스터마이징하고, 단계적으로 시행하면서 경험을 축적하는 것이다. 처음부터 완벽할 수는 없지만, **“환자를 위해 불을 밝히겠다”**는 일관된 목표 아래 지속적으로 보완하고 노력한다면, 야간진료 시스템은 분명 지역사회에 자리잡고 병원에도 성과를 가져다줄 것이다.

365일 내과·외과·산부인과·소아과 야간진료 실행전략에 대한 리서치 내용을 계층형 목차 구조(1단계, 2단계, 필요 시 3단계 포함)로 요약해드리겠습니다. 요약이 완료되면 곧바로 공유드리겠습니다.

1. 국내외 365일 야간진료 운영 사례 분석

- 1.1 국내 운영 사례:정부 또는 지자체 주도로 연중무휴 24시간 진료기관을 지정·운영한 사례가 있음. 예를 들어, 달빛어린이병원등은 야간·휴일 소아과 진료 공백을 메우기 위해 365일 야간진료를 제공하며, 일부 대형병원에서도 야간 외래진료센터를 시범 운영한 바 있음. 이러한 국내 사례들은 응급실 혼잡 완화에 기여하지만, 운영적자발생 등 지속성에 어려움을 겪고 있음.
- 1.2 해외 운영 사례:영국에서는 지역 **가정의(Local GP)**들이 교대로 야간진료를 담당하는 야간 당직(primary care out-of-hours)서비스가 정착되어 있고, 미국의 경우 민간 Urgent Care 센터중 일부가 24시간 운영되며 경증 응급환자를 처리함. 일본등 다른 나라에서도 지역의료센터나 병원급 의료기관이 교대제로 24시간 외래진료를 제공하는 사례가 있음. 해외 사례들은 정부 지원이나 의료기관 협동을 통해 야간진료를 구현하고 있으며, 지역 주민의 의료 접근성 향상과 응급실 부담 경감에 효과를 보임.

C. 진료 시간대별 운영 모델 비교 (연장형, 24시간형, 혼합형)

- **2.1 연장형 모델:** 기존 주간진료 시간을 야간까지 연장하여 밤 늦게까지 운영하는 모델. 예를 들어 평일/주말에 자정까지 진료 하고 심야 시간대(자정 이후)는 휴식. 추가 근무 인력이 필요 하지만 24시간 대비 인력 부담은 적으며, 심야 심층 응급상황 은 인근 응급실로 연계. 운영이 비교적 경제적이고 시행이 쉬 우나, 심야(새벽)시간대 환자 대응은 제한적임.
- **2.2 24시간형 모델:** 하루 24시간 내내 중단 없이 진료를 제공하는 완전 교대제 운영 모델. 3교대 등으로 의사·간호사가 상주하 며 언제든지 내원 환자 진료 가능. 응급실 수준으로 모든 시간대 대응이 가능하여 환자 편의성 최고지만, 인건비와 운영비 부담 이 크고 충분한 환자 수요 확보가 필수. 직원 교대 피로 누적 등 의 문제가 발생할 수 있어, 엄격한 인력 관리가 요구됨.
- **2.3 혼합형 모델:** 필요에 따라 연장형과 24시간형을 병행하는 탄력적 운영 모델. 예를 들어 주중에는 연장 운영하고 주말이 나 공휴일에는 24시간 운영하거나, 과별로 운영시간을 차별화 (일부 필수 과는 24시간, 기타는 일정 시간 운영)하는 방식. 지역 수요 패턴에 따라 유연하게 대응하여 효율성을 높이지만, 운영 일정이 복잡해질 수 있고 이용자가 운영시간을 혼동하지 않도록 안내가 중요함.

인력 구성 및 교대 모델 (의사, 간호사, 행정직 등)

- **3.1 전문의(의사) 인력 구성:** 내과, 외과, 산부인과, 소아과 전문의를 충분히 확보하여 야간당직에 배치해야 함. 24시간형의 경우 각 과마다 최소 1명 이상의 의사가 야간에 상주하거나 대기 (on-call)하도록 편성. 연장형의 경우 야간 전담 의사를 두거나 주간 의사가 교대로 연장 진료를 수행. 과목별 진료 수요를 고려해 교차 커버가능성을 검토(예: 내과 의사가 경미한 외상 처치 수행 등)하며, 전문의와 레지던트 혹은 PA 등을 조합하여 인력을 운영하기도 함.
- **3.2 간호사 및 지원인력 구성:** 야간 진료를 보조하기 위해 충분한 간호사인력을 확보, 주간 대비 축소된 팀으로 운영하되 필수 간호 업무공백이 없도록 함. 또한 접수/수납 등 행정직원을 최소 1명 이상 야간에 배치하여 원활한 환자 응대와 행정 처리를 지원. 필요시 검사실 임상병리사나 방사선사 등 필수 진단 인력을 당직으로 두거나 협진 병원과 연계 체계를 마련. 소 규모 인력으로 운영되는 만큼 멀티태스킹역량을 갖춘 인력을 선호하며, 비상시 추가 인력 호출시스템을 준비.

- **3.3 교대제 운영 방식:**인력 피로도를 감안하여 교대 근무표를 체계적으로 수립. 24시간형의 경우 3교대(8시간)또는 2교대(12시간)근무제를 적용하고, 연장형은 추가 야간근무 조 편성으로 보완. 순환근무를 통해 동일 직원이 연속 야간근무를 하지 않도록 조정하고, 법정 근로시간을 준수하며 휴식시간을 보장. 야간근무자에게는 야간 수당지급 등 동기부여 장치를 마련하고, 교대 주기를 일정하게 운영하여 직원들의 생활 리듬 혼란을 최소화함.

의료법 및 제도적 허용 범위 (복지부 지침, 수가체계, 노동법 포함)

- **4.1 의료법 관련 준수 사항:**24시간 의료기관 운영 시 의료법상의 인력·시설 기준을 충족해야 함. 예를 들어, 일정 시간 이상 운영하는 의원은 야간응급실 신고또는 별도 인허가가 필요할 수 있고, 진료과목별 필요한 시설·장비 기준을 갖춰야 함. 또한 응급상황 발생 시 응급의료에 관한 법률에 따른 적정 조치(응급환자 수용 의무 등)를 이행해야 하므로 관련 법규를 숙지하고 준수해야 함.
- **4.2 보건복지부 지침 및 수가체계:**정부의 야간진료 장려 정책이나 가이드라인을 따라 운영 모델을 설계해야 함. 현재 일부 야간·공휴일 진료 수가 가산제도가 있으며, 소아과의 경우 달빛어린이병원처럼 정부가 운영비 지원및 수가 보전을 해주는 사례가 있음. 보험 수가체계 내에서 야간 가산료등을 통해 추가 수입이 가능하도록 하고, 필요시 비급여 서비스를 병행하여 수익성을 보완. 복지부 지침에 따라 보고 및 평가를 실시하고, 지원 대상 요건을 갖춰 재정 지원을 받을 수 있도록 함.
- **4.3 노동법 및 근로기준:**야간진료 운영 시 근로기준법상의 야간근무 규정을 철저히 준수해야 함. 근로자에게 야간근로수당 지급, 연속 근무시간 제한(일일·주간 최대 근로시간 준수) 및 주휴일 보장등을 지켜야 함. 교대제 직원의 건강관리 의무(정기 검진 등)와 산업안전 규정을 따르고, 특별히 의료인력의 당직근무에 관한 예외 규정이나 지침(전공의 특별법 등)이 있다면 이를 고려한 스케줄 편성이 필요함. 노동법 위반이 없도록 근무표 관리 및 임금 체계를 투명하게 운영.

과별 진료 특성과 야간 주요 진료 항목 (내과, 외과, 산부인과, 소아과)

- **5.1 내과 야간진료 특성:**야간에는 급성 내과적 증상으로 내원하는 환자가 많음. 예를 들어 **고열, 급성 복통, 호흡기 질환 악화(천식 발작)**나 만성질환의 악화(고혈압 위기 등) 등이 주요 진료 범위. 이에 대비해 기본 검사진단(혈액/소변 검사, 흉부 X선 등)과 응급처치(산소 공급, 수액 치료)가 가능해야

함. 중증 응급환자 발생 시 신속히 **상급병원 이송**을 고려하되, 경증~중등도 환자를 안정시키는 **1차 진료**에 중점.

- **5.2 외과 야간진료 특성:**경미한 외상이나 **외과적 응급상황**환자가 주로 방문. 예를 들어 **찰과상, 열상**에 대한 **봉합처치, 경증 화상처치**, 단순 골절에 대한 **응급처치/부목 고정** 등이 해당됨. 또한 **수술 후 환자**의 갑작스런 증상(상처부위 통증, 출혈)으로 내원하기도 하므로 기본 처치와 경과 관찰이 필요. 야간에는 대수술은 어렵지만, **응급수술 필요** 시 신속히 응급의료기관으로 **전원**하는 체계를 갖추고 초기 처치를 수행. 기본 외과 장비(봉합 세트 등)와 **방사선 촬영**등의 설비를 준비해야 함.
- **5.3 산부인과 야간진료 특성:**산부인과적 **응급**으로 임산부나 여성 환자가 야간에 종종 내원. 예를 들어 **임신 초기에 출혈**이나 복통 (유산 위험), **임신 말기 진통** 개시징후, **자간전증 의심 증상**또는 **급성 산부인과 질환**(난소낭종 염전, 자궁외임신 등 통증) 등이 발생 가능. 기본 **산과 장비**(태아 심박동 모니터 등)를 갖추고 산모 상태를 안정시켜야 하며, 필요한 경우 분만 가능한 병원으로 **신속 이송**. 또한 **산모 및 여성 환자**의 야간 **불안**을 해소하기 위해 전문의가 신속히 판단하고 조치하는 것이 중요. 더불어 **산부인과 수술 후**환자의 합병증 의심 증상(출혈, 통증)도 대응.
- **5.4 소아과 야간진료 특성:**소아환자는 야간에 고열, 탈수, 경련 등 **응급 증상**으로 자주 내원. 특히 **호흡기 질환**(크룹, 모세기관지염)이나 **소화기 증상**(구토, 설사)으로 인한 **탈수**가 흔하며, 부모의 불안이 큰 편. **소아용 의약품**과 장비(소아과용 산소마스크, 소아과용 주사바늘 등)를 구비하고, **소아 전문 간호술기**에 숙달된 인력이 필요. 야간 소아환자는 **증상 변화가 빠를 수 있으므로**면밀한 관찰이 중요하며, 필요 시 소아전문 응급센터로의 **후송체계**를 갖춰야 함. 또한 **부모 교육**및 안심시켜 줌이 조치하는 것도 소아과 야간진료의 한 부분.

수익 및 비용 구조, 수익성 개선 전략

- **6.1 비용 구조 및 지출 요소:**365일 야간진료 운영에는 인건비 비중이 가장 큼. 의사, 간호사 등의 **야간수당 포함 급여**, 교대 인력 총원 비용이 주요 지출이다. 이외에도 **시설 유지비**(야간 조명·전기료, 설비 가동 비용), **장비 감가상각**및 소모품 비용, 야간 운영을 위한 **보안/경비 인력비용** 등이 발생. 환자 수가 적은 **심야 시간대**의 **저효율**로 인한 비용 부담이 크며, 전체 운영비 대비 **야간 가동률**이 낮으면 경제성이 악화됨.
- **6.2 수익 구조 및 현재 수익성:**수익은 주로 **진료비 수입**(건강보험 적용 진료수가 + 환자 본인부담금)에서 나오며, 야간에는

수가 가산이 일부 적용되어 단가가 높음. 또한 **약국 부재 시 조제 수익**(병원직영 약국이나 조제료)이나, 경증 응급처치에 대한 **처치료**등이 부가 수입이 될 수 있음. 그러나 야간 환자 수가 제한적이라 **수익률**이 낮고, 인건비를 상쇄하기 어려워 **만성적 적자**우려가 있음. 현재 국내 야간진료 기관의 경우 정부 보조금이나 주간 진료수익으로 **교차보전**하는 경우가 많음.

- **6.3 수익성 개선 방안:**환자 수요를 늘리고 단가를 향상시키는 복합 전략 필요. 지역주민 대상 **홍보**로 이용률을 높이고, **야간 진료 범위 확대**(예: 경증 응급시술까지 처리)로 **1인당 수익**을 증대. 정부와 협의하여 **야간 가산수가 인상**또는 **운영보조금**지원을 확보하여 재정을 개선. 또한 **운영 효율화**를 통해 비용 절감: 예를 들어 심야에 환자가 매우 적은 시간대에는 **온콜(on-call)**대기 체제로 전환하여 불필요한 인력 상주 최소화, **다기능 인력**활용으로 최소 인력으로도 진료 가능하도록 함. 인근 의료기관과 **자원 공유**(검사실 공동 이용 등)로 비용을 분담하고, **Telemedicine(원격의료)**등을 도입하여 야간 전문의 인력 부족을 보완하면서 추가 수익(원격상담 수가 등)을 창출하는 것도 고려할 수 있음.

관련 설비 및 기술 인프라 요건

- **7.1 필수 의료시설 및 장비:**24시간 운영을 위해 **진료공간**을 야간에도 안전하고 편안하게 이용할 수 있도록 구축. **진료실, 처치실, 관찰병상**등을 확보하여 응급처치와 단기 경과관찰이 가능해야 함. 영상진단을 위한 **X선 장비**, 산부인과용 **초음파**기기, 소아과용 **응급기구**등 각 과별 필수장비를 갖추. **산소 공급 시스템, 제세동기(심장충격기)**등 응급장비와 **약품 비축**(응급약, 수액 등)을 철저히 준비. 대기 환자와 보호자를 위한 **대기실**을 편안하게 조성하고, 야간엔 잠거야 할 구역과 열려 있을 구역을 분리하여 **보안**과 **동선 관리**를 고려.
- **7.2 기술 인프라 및 IT 시스템:**원활한 야간진료를 지원하기 위해 **전자 의료기록(EMR)**시스템을 24시간 가동하고, **실시간 모니터링**체계를 구축. 예를 들어, 야간에도 검사결과를 바로 확인할 수 있는 **POCT(현장검사장비)**연계, 환자 상태 악화 시 즉각 대응을 위한 **모니터 설비**를 갖추. **통신 시스템**도 중요하여, 상급병원 응급실이나 전문의 온콜에 **즉시 연락**할 수 있는 핫라인을 마련. 필요한 경우 **원격협진**이나 **화상진료기술**을 활용해 야간에 부족한 전문과목 자문을 얻음. 또한 **환자 안내 시스템**(홈페이지나 앱을 통해 야간진료 가능 시간과 과목 안내)을 갖추고, 내부적으로는 **스태프 호출 시스템**이나 자동 알람 시스템으로 긴급상황에 신속 대응. **전원 공급**의 이중화 등 비상시 대비 인프라도 필수적임(예: 예비 발전기 설치).

지역 주민 접근성 강화 및 홍보 전략

- **8.1 접근성 강화 전략:**지역 주민들이 쉽게 찾아올 수 있도록 입지 선정과 교통 편의를 고려. 대중교통이 끊긴 심야를 대비해 충분한 주차 공간을 확보하거나 심야 셔틀/이송 서비스를 연계. 거동이 불편한 환자를 위해 장애인 편의시설과 진료 동선 최적화를 시행. 인근 응급의료기관 및 119구급대와 협력체계를 구축하여 비응급 환자를 야간진료센터로 안내받도록 함. 지역 보건소, 인근 병원과 연계하여 야간진료 정보를 공유하고 상호 의뢰체계를 마련, 지역 의료망 내에서 역할을 분담.
- **8.2 홍보 및 인지도 제고:**지역사회에 365일 야간진료 서비스의 존재와 필요성을 적극 알림. 온·오프라인 홍보를 병행하여, 주민센터 게시판, 지역 언론, 맘카페 등 커뮤니티에 운영 시간, 진료 과목등을 안내. 특히 소아 환자 부모나 만성질환 노인 등 주요 대상층을 겨냥한 맞춤 홍보 실시. 응급실 대비 장점(대기시간 단축, 비용 절감 등)을 강조하여 주민들의 이용을 독려하고, 만족도 조사 및 후기 공유를 통해 신뢰도를 높임. 정기적으로 지역 건강강좌나 이벤트를 열어 주민과 소통하고, 이들을 홍보대사로 활용하여 입소문을 유도. 또한 긴급시 24시간 문의 가능한 콜센터번호를 홍보하여 야간 의료상담 및 안내를 제공함.

인력관리 및 지속 가능한 근무환경 조성 방안

- **9.1 인력 확보 및 유지 전략:**야간진료에 투입될 의사·간호사 등의 충원과 유지가 최우선 과제. 이를 위해 야간 근무 수당 인상이나 특별 보상(예: 추가 휴가, 숙소 제공)으로 동기 부여를 강화. 신규 인력 채용 시 야간교대 근무가 가능한 인원을 우선 선발하고, 기존 직원들에게는 순환보직등을 통해 경력 발전 경로를 제시하여 장기 근속을 유도. 또한 주변 의료기관과 **인력 풀(pool)**을 공유하거나, 파트타임/초빙의를 활용하여 인력 공백 시 긴급 대체 인력을 확보. 정기적인 의견 수렴과 소통 창구마련으로 현장의 애로사항을 파악하고, 우수 인력에 대한 포상으로 사기를 진작시킴.
- **9.2 지속 가능한 근무환경 조성:**직원들의 피로 누적과 번아웃 방지를 위해 쾌적한 근무환경과 복지를 제공. 야간 교대 직원들을 위한 휴게공간(수면실, 휴식 라운지)과 심야 식사 제공등을 마련하고, 교대 근무 간 충분한 휴식시간을 보장함. 주기적인 건강검진과 상담 프로그램(직무 스트레스 관리, 정신건강 지원)을 통해 직원들의 신체·정신 건강을 챙김. 근무 스케줄은 예측 가능하게 미리 공지하여 생활 리듬을 유지할 수 있도록 하고, 개인별 희망 근무시간대를 부분 반영하여 워크라이프 밸런스를 존중. 위험 상황에 대비한 보안 인력비상벨등을 갖춰

야간 근무자의 안전을 확보하고, 팀별 교대인계 시스템을 구축하여 근무자들 간 업무 연속성과 협력을 강화. 이러한 노력들을 통해 직원 만족도를 높이고 야간진료 운영의 지속가능성을 확보함.

D. 메디피아산부인과병원 야간/휴일 진료 확대 실행방안 보고서

1. 현재 운영체계의 강점 및 한계 분석

강점:

메디피아산부인과병원은 이미 환자 접근성이 뛰어난 운영시간을 갖추고 있다. 평일에는 저녁 6시부터 9시까지 야간진료를 시행하고, 토요일도 밤 9시까지 진료하며, 일요일에도 오전 9시부터 오후 6시까지 외래를 운영한다. 대부분의 병의원이 주말이나 늦은 저녁에는 문을 닫는 현실에서, 해당 병원은 365일 24시간 전문의 당직 체계를 통해 입원, 수술, 검사까지 처리하여 응급상황에 대응할 수 있다는 점이 지역 환자들에게 큰 신뢰를 주고 있다. 이는 지역 내 산모나 여성 환자들이 심야 응급상황 시 곧바로 전문진료를 받을 수 있는 거의 유일한 민간 의료기관이라는 강점으로 이어진다.

한계:

현재의 야간/휴일 진료는 외래 진료 시간이 제한되어 있어 완전한 24시간 접근성에는 미치지 못하는 실정이다. 예를 들어 평일/토요일 밤 9시 이후나 일요일 저녁 6시 이후에는 공식 외래진료가 중단되며, 이 시간대에는 당직 전문의가 병원에 상주하지만 응급 환자 위주로 제한적 대응을 하고 있다. 따라서 심야에 발생한 산부인과 경증 환자들이 외래 수준의 진료를 받기보다는 응급실을 찾아야 하는 불편이 남아 있다. 또한 현재 의료인력 및 지원인력의 피로도 증가도 우려된다. 야간과 주말에 걸친 연장 운영으로 인해 의료진의 근무 강도가 높아지고, 교대 인력이 충분하지 않을 경우 **장기적으로 인력 소진(burn-out)**이나 서비스 품질 저하 위험이 존재한다. 다른 전문분야 인력 부재도 한계인데, 산부인과 단일과 중심 병원으로서 심야에 내과적 응급상황 등이 발생하면 즉각 대응에 한계가 있고, 필요 시 인근 종합병원으로의 전원이 불가피하다. 시설 측면에서도 현재는 기존 시설로 연장 운영을 하고 있으나, 심야 안전관리나 추가 환자 대비 시설 보강 등이 미흡할 수 있다. 요약하면, 현재 운영체계는 지역 평균 이상으로 광범위한 진료 시간을 제공하는 강점이 있으나, 완전한 24시간 외래체계 부재, 인력 피로도 및 타과 지원 부족 등의 한계를 지닌다.

2. 국내외 선도 사례와의 비교 분석

국내 사례:

국내에서는 소아과 분야에서 달빛어린이병원제도를 통해 야간·휴일 진료를 활성화한 선례가 있다. 경기도 평택의 성세병원은 1995년부터 20년 가까이 평일 자정까지 소아청소년과 야간진료를 지속해온 대표 사례로, 개원 당시에는 소아과 의사 2명이 격일로 교대 당직을 서며 간호사, 원무, 경비, 급식

인력까지 한마음으로 야간진료를 이어갔다 ([늦은밤 아프면 참아야?…밤에도 문 여는 병원 ‘있다’ - 국민이 말하는 정책 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑](#)). 이러한 노력으로 현재 성세병원은 야간전담 의사 9명으로 확대되어 하루 평균 150명의 야간환자를 볼 정도로 성장했으며, 수익성 확보까지는 5~10년이 걸렸지만 결국 지역사회에 “언제든 찾아가면 진료받을 수 있는 병원”이라는 이미지를 구축했다 ([늦은밤 아프면 참아야?…밤에도 문 여는 병원 ‘있다’ - 국민이 말하는 정책 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑](#)) ([늦은밤 아프면 참아야?…밤에도 문 여는 병원 ‘있다’ - 국민이 말하는 정책 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑](#)). 성세병원의 사례는 장기적 관점의 투자와 의료진 헌신이 뒷받침된다면 야간진료도 충분히 활성화될 수 있음을 보여준다. 정부도 이 사례를 기반으로 2014년부터 전국 6개 시도에 8개 소아과 병원을 달빛어린이병원 시범기관으로 지정하여 운영비를 지원(월 평균 1,500만원 보조)하는 등 제도화에 나섰다 ([늦은밤 아프면 참아야?…밤에도 문 여는 병원 ‘있다’ - 국민이 말하는 정책 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑](#)). 이 제도는 심야나 휴일에 경증 소아 환자가 응급실 대신 전문의에게 외래 진료를 받도록 유도하여, 실제로 *“응급실에서 진료받을 때보다 1/3 정도의 비용 부담”*으로 진료가 가능하게 함으로써 학부모들에게 호응을 얻었다 ([늦은밤 아프면 참아야?…밤에도 문 여는 병원 ‘있다’ - 국민이 말하는 정책 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑](#)). 소아 환자 야간진료 모델의 성공은 산부인과 등 다른 진료과목에도 적용 가능성을 시사하며, 정부 지원과 지역민 신뢰 형성이 중요함을 보여준다.

해외 사례:

해외에서도 24시간 전문진료 체계를 갖춰 지역의 의료허브 역할을 수행한 사례들이 있다. 예를 들어 미국 AdventHealth Shawnee Mission 병원은 산모를 위한 별도 *산과 응급실(OB Emergency Department)*을 운영하면서, 숙련된 산부인과 전문의와 조산사, 간호사를 24시간 상주시켜 임산부들이 언제든지 즉각적인 진료를 받을 수 있도록 체계화했다 ([Obstetrical Emergency Care | AdventHealth Shawnee Mission](#)). 이러한 산과전담 응급 시스템을 통해 임산부 응급 상황에 특화된 신속 대응과 환자 안전을 확보하고, 일반 응급실 대비 진료 효율을 높인 사례로 평가된다. 영국 NHS의 한 연구에 따르면 1차 의료기관에서 평일 저녁 및 주말에 추가 진료시간을 제공했을 때 환자들이 사소한 증상으로 응급실에 스스로 내원하는 비율이 26.4%나 감소한 것으로 나타났다 ([Extending primary care hours is linked to fewer emergency department visits | ScienceDaily](#)). 이는 진료시간 연장이 경증 환자의 불필요한 응급실 이용을 줄이고 지역 의료자원의 효율적 활용에 기여함을 시사한다. 미국의 한 가족의학 클리닉은 평일 야간과 주말 진료를 도입한 후 4년간 평균 28%의 이익률을 달성하여 시설 개선에 재투자할 수 있었던 사례도 보고되었다 ([Creating a Successful After-Hours Clinic | AAFP](#)). 이 경우 환자와 의사 모두 높은 만족도를 보였고, 지역사회에서도 큰 호응을 얻어 *“가장 성공적인 일차의료 혁신”*으로 불릴 정도였다 ([Creating a Successful After-Hours Clinic | AAFP](#)). 이러한 국내외 선도사례와 비교해볼 때, 메디피아산부인과병원은 이미 야간·휴일 진료 기반을 갖추고 있다는 점에서 유리한 출발점이 있지만, 완전한

24시간 체계로 나아가기 위해서는 선례들이 보여준 몇 가지 요소—예컨대 전담인력 확충, 정부/지역 지원, 전문화된 응급프로토콜—를 반영할 필요가 있다. 특히 성세병원의 경우처럼 초기에는 최소 인력으로 시작해서 수요 증가에 따라 규모를 확장한 전략이나, AdventHealth 병원처럼 특정 분야(산과 응급)에 집중한 24시간 시스템 구축등이 벤치마킹 포인트가 될 수 있다. 요약하면, 선도 사례들은 ****“항상 문을 여는 의료기관”****으로 자리매김하기까지 시간과 자원이 들지만 **지역 의료허브로서의 위상 강화, 환자 만족도 증가, 장기적 수익성 확보**라는 성과를 거둘 수 있음을 보여주므로, 우리 병원의 전략 수립에 중요한 참고가 된다.

3. 확대 운영의 비전 및 구체적 목표 수립

비전(Vision):

메디피아산부인과병원을 ****“365일 24시간 신뢰받는 지역 여성의료 허브”****로 거듭나게 한다. 언제든지 필요한 때에 최적의 산부인과 의료서비스를 제공하여 지역사회 여성과 산모들이 안심하고 찾을 수 있는 병원, 나아가 **지역 내 산모·여성 건강의 중추기관**이 되는 것을 지향한다. 이를 통해 환자들에게는 접근성 향상과 안전한 의료 이용을, 병원에는 지속가능한 성장과 수익성을 동시에 달성하는 것을 비전으로 설정한다.

구체적 목표:

이 비전을 실현하기 위해 다음과 같은 정량적·정성적 목표를 수립한다.

- **환자 접근성 향상:**

향후 1년 내 주중 및 주말 외래진료 시간을 자정까지 확대하고, 3년 내에는 주야 구분 없는 24시간 외래진료 체계를 완성한다. 이를 통해 야간/휴일 시간대 외래 환자 수를 현재 대비 50% 이상 증가시키고, ***“필요할 때 언제나 진료받을 수 있다”***는 환자 만족도 지표(설문조사에서 접근성 만족도)를 90% 이상으로 끌어올린다 ([늦은밤 아프면 참아야?…밤에도 문 여는 병원 ‘있다’ - 국민이 말하는 정책 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑](#)). 응급 분만이나 급성 산부인과 질환으로 타병원 응급실로 이송되는 환자 비율을 2년 내 절반으로 감소시키는 것이 목표이다.

- **지역 의료허브로의 기능 확대:**

고위험 임신부 지원센터 및 24시간 분만실운영을 강화하여, 지역 산모 응급의료의 1차 접수기관이 된다. 예를 들어 향후 3년 내 지역 산모의 분만 건수 중 70% 이상을 우리 병원에서 담당하고, 주산기 합병증 발생 시 인근 상급종합병원과 신속 연계하는 네트워크를 구축한다. 또한 필요 시 소아청소년과 야간진료를 부가하여 지역 아이들의 경증 질환까지 돌볼 수 있는 **여성·어린이 통합 달빛병원**으로서 위상을 확보하는

방안을 검토한다. 병원의 이러한 허브화로 인근 산부인과 개원의들과의 **협력체계(야간환자 의뢰 시스템)**를 구축하고, **지역응급의료체계**에서 산부인과 트라우마/응급 거점으로 공식 편입되는 것을 목표로 한다.

- **수익성 강화:**

단계적 운영 확대에도 불구하고 병원의 재무 건전성을 유지 및 제고한다. 단기적으로 추가 진료로 인한 수입이 증가된 인건비 대비 1.2배 이상 창출되도록 하고, 3년 내 전체 외래 환자 수 30% 증가, 연매출 20% 이상 증대를 목표로 한다. 야간·공휴 가산 수가 및 비급여 서비스 매출을 적극 활용하여 신규 투자의 손익분기점을 2년 내 달성한다. 장기적으로는 **영업이익률을 현재 대비 5%p 이상 높이고, 야간진료 부문의 수익률을 플러스(+)**로 전환시키는 것이 목표이다 ([Creating a Successful After-Hours Clinic | AAFP](#)). 이와 함께 정부 지원금, 지자체 보조금 등을 매년 최대치로 확보하여 시설·인력 확충에 재투자함으로써 선순환 구조를 만든다.

以上の 목표들은 **“환자 접근성→병원 신뢰도 향상→환자 증가→수익성 개선”**의 선순환을 이루도록 상호보완적으로 설정되었다. 특히 단순히 운영시간을 늘리는 것을 넘어, 병원의 기능과 역할을 지역사회에서 확대하고 이를 통해 재무적으로도 성장하는 균형 전략을 취하는 것이 중요하다. 목표 달성 진행상황은 정기적으로 병원 경영진이 모니터링하고, 필요 시 전략을 조정하여 유연하게 대응할 것이다.

4. 과별 외래진료 24시간 확대 가능성 및 시간대별 진료전략

24시간 외래 확대 가능성 검토:

산부인과 특성상 분만이나 급성 산과 질환은 예측이 어려워 24시간 진료 수요가 존재한다. 현재도 심야 시간대에 응급 분만이나 응급수술이 빈번하며, 산모들은 응급상황이 아니어도 야간에 출혈, 통증 등의 증상에 불안해하는 경우가 많다. 이러한 수요를 수용하기 위해 **외래진료의 24시간 확대**는 충분한 당위성이 있다. 다만, 시간대별 환자 수요 편차와 인력/자원 투입 대비 수익성을 함께 고려해야 한다. 즉, 심야(자정~새벽) 시간대에 실제 내원 환자수가 얼마나 될지를 예측하여, 전면 24시간 운영과 단계적 확대 중 어느 방식을 택할지 결정해야 한다. 국내 유사 사례인 달빛어린이병원의 운영 기준을 보면 *“평일 밤 11시, 주말 오후 6시까지 최소 운영”*을 권고하면서 병원 여건에 따라 자정까지 확대하도록 하고 있는데 ([늦은밤 아프면 참아야?...밤에도 문 여는 병원 ‘있다’ - 국민이 말하는 정책 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑](#)), 이를 참고하여 1단계로 현행 21시 종료를 자정(24시)까지 늘리고, 향후 수요와 운영 안정화에 따라 새벽 시간대로 확대하는 단계적 24시간화전략이 현실적이다.

과별 진료 확대 방안:

메디피아산부인과병원은 주로 **산과(분만)**와 **부인과**로 진료영역이 구분된다. 두 분야 모두 야간 응급수요가 있지만 특성이 다르므로, **과별로 맞춤형 24시간 전략**을 수립한다:

- **산과(Obstetrics):**

산과는 **진료 24시간화의 우선 대상**이다. 분만 대기 산모나 임신 합병증 환자는 심야에도 발생할 수 있으므로, **분만실과 산과 전문의 진료는 항상 가동**되어야 한다. 현재도 24시간 당직 전문의가 분만을 관리하고 있으므로, 이를 **외래진료와 연계된 산과 응급클리닉**형태로 공식화한다. 즉, ****임신부 응급 외래(Triage)****를 별도로 마련하여 야간에도 **진통, 출혈, 고혈압 등 산과 응급 증상 발생 시 바로 평가 및 처치**하도록 한다. 산과 야간외래에서는 기본적인 진찰과 태아 모니터링, 응급 초음파 검사가 가능하도록 준비하고, 필요 시 즉시 분만실이나 수술실로 연계한다. 이로써 **임신부들이 밤중에도 응급실 대신 전문 산과진료를 받도록 유도**하여, 높은 의료의 연속성을 보장한다 ([Obstetrical Emergency Care | AdventHealth Shawnee Mission](#)). 또한 주간에는 예약위주의 산전진찰이 많지만, 야간에는 **직장인 임신부를 위한 예약 진찰 슬롯**을 운영하여 낮에 진료 받기 어려운 산모들의 접근성을 높인다 (예: “야간 프리네이탈 클리닉” 운영).

- **부인과(Gynecology):**

부인과 영역의 급성 질환(난소염전, 자궁외임신 쇼크 등)은 많지 않지만, **급성 하복부 통증, 급성 출혈, 외상** 등으로 심야에 내원하는 경우를 대비해야 한다. 따라서 부인과도 **당직 산부인과 전문의가 1차 대응**하되, 필요 시 **심야 수술이 가능하도록 수술팀 대기체계**를 갖춘다. 부인과 환자를 위한 **야간/휴일 경증 클리닉**도 고려할 수 있다. 예를 들어 **야간 산부인과 경증클리닉**을 열어 생리통, 방광염 등으로 고통 받는 여성들이 밤늦게라도 진료와 처방을 받을 수 있게 한다. 다만 이러한 경증환자는 심야에 많지 않을 수 있으므로, **초기에는 산과 야간클리닉과 통합**하여 한 명의 당직의사가 산과·부인과 환자를 모두 커버하면서, 환자 증가 추이에 따라 부인과 전담 야간진료의를 추가 배치한다. **주말/휴일 진료**의 경우, 현재 일요일 18시까지만 외래를 운영하지만 **향후 토요일 심야와 일요일 밤에도 당직 전문의를 통한 외래진료**를 검토한다. 특히 ****일요일 밤 시간대(18시 이후)****는 인근에 문 여는 산부인과가 전무할 가능성이 크므로, 이 시간을 공략하여 **주말 응급 산부인과 클리닉**을 열면 지역 환자 유입을 늘릴 수 있다.

시간대별 진료전략:연중무휴 24시간 체계를 효율적으로 운영하기 위해 **시간대별로 진료 기능과 인력을 차등 배치**한다.

- **주간(08~18시):**산부인과 외래의 **정규 진료시간**으로서, 전문의 다수를 배치하여 예약환자 진료, 각종 검사(초음파, 검사실 검사), 계획수술 등을 집중 수행한다. 이 시간대는 환자 수요가 가장 많으므로

산과, 부인과, 불임클리닉 등 세부 전문분야 외래를 모두 가동하고, 원스톱 진료가 가능하도록 영상의학과 등 지원부서도 정상 운영한다. 주간 수술/입원환자 관리를 통해 병원의 주 수익이 창출되는 시간대이며, 야간 운영을 뒷받침하기 위한 **수익 중심 시간**으로 활용한다.

- **저녁(18~24시):연장 외래진료 시간대**로서, 직장인 산모나 긴급하지는 않지만 당일 진료가 필요한 환자를 위한 **야간 연장 클리닉**을 운영한다. 이때 ~~**전문의 12명과 최소한의 필수 인력(간호사, 접수/원무, 검사기사)**~~을 배치한다. 예를 들어 1822시는 산과 전문의 1명, 부인과 전문의 1명을 배치하여 평소 예약을 못했던 환자 진료와 야간 경증 응급을 커버하고, 22~24시는 환자 상황에 따라 전문의 1명이 응급 위주로 당직진료를 보는 형태로 유연하게 운용한다. 이 시간대에는 **응급 수술이나 분만 발생 시 외래 환자를 잠시 대기시킬 수 있는 이중 대응 체계**를 고려한다. (예: 당직 전문의 2인 교대제 등을 통해 한 명은 수술, 다른 한 명은 외래 지속).
- **심야/새벽(00~08시):응급 대응 중심 시간대**로 규정한다. 이 시간에는 실제 외래 방문 환자가 많지 않을 것으로 예상되므로 **온콜(On-call) 시스템**과 **당직 전문의 상주**를 병행한다. 즉, 산부인과 당직 전문의 1명과 필수 간호인력은 병원에 상주하여 즉각 처치가 가능한 태세를 갖추고, 추가로 2차 당직(대기) 전문의를 두어 예기치 못한 복수의 응급상황이나 수술 시 지원하도록 한다. 새벽에 내원하는 환자는 대부분 응급성 환자일 것이므로, ****‘산부인과 야간응급센터’****의 개념으로 진료를 시행한다. 접수와 수납 등 행정은 당직 간호사가 대행하는 등 최소인력으로 운영하되, 필요한 검사는 심야에도 수행될 수 있게 **POCT(Point-of-Care Testing) 장비나 응급 영상검사 체계**를 마련한다. 심야 시간에는 방문 환자에 대해 **선별 전화상담/간호사 TRIAGE**를 도입하는 것도 고려한다. 예컨대 환자가 방문 전에 전화로 증상을 설명하면 간호사가 긴급도를 판단하여 즉시 내원 또는 아침까지 대기 등의 조치를 안내함으로써, **의료진이 필요한 경우에 집중할 수 있게 한다** ([Creating a Successful After-Hours Clinic | AAFP](#)) ([Creating a Successful After-Hours Clinic | AAFP](#)). 또한 새벽시간 외래진료를 시작하면 지역 119구급대나 응급의료센터와 **연계 프로토콜**을 수립하여, 산부인과적 응급환자는 우리병원으로 우선 이송되도록 협력한다.

이러한 시간대별 전략을 통해 **인력과 자원의 효율적 활용**이 가능해지고, 각 시간대의 환자 요구에 맞춘 서비스를 제공함으로써 **환자 만족도와 신뢰도**를 높일 수 있다. 특히 응급산모가 많은 심야시간에는 응급대응에 집중하고, 저녁 시간대에는 비교적 여유 있게 경증 환자를 진료함으로써 **진료 공백 없이 24시간을 커버**하게 된다. 나아가 이러한 체계가 정착되면 지역 내 산부인과 응급환자의 **응급실 방문률이 감소**하고, 경증 환자들도 응급실 대비 낮은 비용으로 야간진료를 받을 수 있어 지역 의료 전체의 효율성이 높아질 것으로 기대된다 ([Extending primary care hours is linked to fewer emergency](#)

[department visits | ScienceDaily](#)).

5. 인력 운영 전략 (야간전담 인력, 교대조직, 당직 강화 등)

야간전담 전문인력 확보:

24시간 확대 운영의 성패는 전담 의료인력 확보에 달려 있다. 먼저 산부인과 전문의 인력에 대해, 현재 당직 전문의 체계를 야간전담 전문의 팀으로 개편한다. 이상적인 것은 야간전담 전문의 채용으로 주간 진료와 분리된 전담팀을 꾸리는 것이나, 국내 의료 현실상 전문의 추가 총원에 어려움이 있을 수 있다. 따라서 기존 전문의들의 교대근무제 도입을 병행 검토한다. 예를 들어 전문의들을 A, B조로 나누어 일정 기간 야간근무 후 오프(휴식)를 부여하는 방식(일주일 단위 순환 등)을 시행한다. 성세병원 초창기 사례에서도 2명의 의사가 격일 야간진료를 시작하여 점차 인력을 늘렸듯이 ([늦은밤 아프면 참아야?…밤에도 문 여는 병원 ‘있다’ - 국민이 말하는 정책 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑](#)), 우리 병원도 초기에는 소수 정예로 시작하여 수요 증가에 맞춰 전문의를 순차 총원한다. 이를 위해 경력 있는 산부인과 의사의 영입은 물론, 전공의 수료 예정자나 펠로우(Fellow) 과정 인력등을 적극 채용하여 야간전담팀을 구성한다. 채용 조건으로는 야간전담의 경우 주간 대비 높은 급여 및 인센티브를 책정하고, 근무표상 휴무일 확대, 학회 지원 등 보상/복지를 강화한다. 이는 최근 젊은 의사들이 워크라이프 밸런스를 중시하여 야간근무 기피 경향이 있다는 점을 고려한 조치다 ([늦은밤 아프면 참아야?…밤에도 문 여는 병원 ‘있다’ - 국민이 말하는 정책 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑](#)). 의사의 사명감에만 기대기보다 제도적 보상을 통해 야간진료 참여를 유도해야 함을 명심한다 ([늦은밤 아프면 참아야?…밤에도 문 여는 병원 ‘있다’ - 국민이 말하는 정책 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑](#)).

교대 조직 및 지원인력 운영:

간호인력과 의료기사, 원무행정 인력 등도 교대근무제로 전환하거나 증원한다. 구체적으로, 간호사는 3교대제(주간-야간-심야) 운영을 정착시켜 24시간 균등 배치하고, 분만실 및 병동 간호 인력을 야간에도 일정 수준 이상 유지한다. 원무행정 직원도 최소 2교대(주간/야간)로 편성하여, 늦은 시간대의 접수·수납 및 보험처리가 원활히 이뤄지도록 한다. 만일 인력 총원이 어려우면 야간 시간대에는 간호사가 원무 업무를 대행하거나, 자정 이후에는 간호사/전문의가 직접 간단한 수납을 처리하는 등 역할을 겸하도록 내부 교육한다. 검사실 인력은 심야에는 상주가 힘드므로 필요 시 호출(on-call)체계를 둔다 (예: 중요한 검사나 혈액은행 업무를 위해 임상병리사 대기조 운영). 영상의학과 방사선사도 야간 대기조를 편성하거나, 최소한 휴일 야간에는 교대로 근무하게 한다. 또한 마취과 전문의·신생아 소생술 담당 소아과 의사 등 타과 당직도 확보해야 한다. 응급 제왕절개 등 수술 상황을 대비해 마취과 의사는 24시간 상주 또는 콜 대기체계를 병행하며, 신생아 응급을 위한 소아청소년과 의사의 협진 체계(인근 협력병원 소아과 당직과 연계 등)를 만든다.

당직 체계 강화:

현행 1인 당직전문의 체계를 보완하여 다중 당직 및 예비인력 대기체계를 구축한다. 즉, 주요 시간대에 2인 이상의 전문의가 대기하도록 스케줄을 조정한다. 예를 들어 분만이 겹치거나 분만 중 출혈과 동시에 다른 응급환자가 올 경우를 대비하여, 한 명은 분만/수술 대응, 다른 한 명은 응급 외래 대응을 할 수 있게 한다. 이는 필수적인 상황에만 두 명이 동시에 근무하는 형태로, 평상시에는 1인 근무하되 두 번째 전문의는 자택 대기하면서 호출 시 30분 내 도착하는 식으로 운영할 수도 있다. 또한 당직 전문의에게 의료소모품 사용 권한, 입원 결정 권한등을 위임하여 야간에 신속한 의사결정이 이뤄지도록 한다. 야간 전담 간호사도 경험 많은 간호사 위주로 편성하여 응급 상황 대처능력이 담보되게 한다. 필요시 산과전문 간호사 혹은 조산사인력을 총원하여 야간 분만을 보조하고 산모 관리를 전담하게 하는 것도 고려한다.

인력 교육 및 지원: 24시간 체제로 전환되면 모든 직원에게 추가 교육과 훈련이 필요하다. 야간/심야 근무자가 알아야 할 응급 프로토콜, 안전 매뉴얼을 마련하여 주기적으로 시뮬레이션 훈련을 실시한다. 예를 들어 심야에 산모 대량 출혈 발생 시 대처훈련, 신생아 긴급 상황 시 대응훈련 등을 통해 야간팀의 역량을 주간과 동등한 수준으로 유지한다. 또한 야간근무자에 대한 병원 차원의 복지를 강화한다. 심야 식사 제공(간식 또는 식비 지원), 교통비 지원(심야 택시비 등), 충분한 휴게공간 제공, 건강검진 주기 단축 등 야간 근무로 인한 피로와 스트레스 관리 프로그램을 운영한다. 이를 통해 직원들의 사기와 만족도를 높여 야간전담 인력의 장기근속을 유도한다.

소통 및 조정:

주간과 야간 근무조 간의 정보 교류와 인계체계를 철저히 한다. 교대 시 환자 상태, 대기 검사 결과, 특이사항 등을 전달하는 인계 카르테시스템을 마련하고, 필요시 전자 의료기록(EMR)에 인계사항을 표시하여 누락을 방지한다. 경영진은 정기적으로 야간 근무자들의 건의사항을 청취하고 애로사항을 파악하여 근무환경 개선에 반영한다.

요컨대, 인력 운영 전략의 핵심은 **“적정 인력의 확보와 효율 배치, 그리고 야간근무에 대한 보상과 지원”**이다. 이를 통해 직원들의 피로도를 관리하고 서비스 품질을 유지함과 동시에, 지속가능한 인력 운용으로 24시간 의료체계를 안정화시킬 수 있다.

6. 시설·기술 인프라 확장 및 안전성 강화 방안

외래/응급 공간 확충:

24시간 운영에 대비하여 병원의 공간 인프라를 재정비한다. 먼저 현 외래진료구역 외에 야간 응급진료 전용 공간을 마련하거나 보완한다. 예를 들어 1층에 **“야간진료센터”**를 설치하여 별도 접수창구와 대기실, 응급처치실을 둔다. 이 공간은 심야시간 주 출입구와 가까운 곳에 배치하여, 야간에 방문하는 산모들이 병원 깊숙이 들어오지 않고도 바로 진료를 받을 수 있도록 한다. 해당 구역에 **응급산모용 침상(산과 응급실 침대)**과 기본 모니터링 장비(태아심박동 모니터, 산소포화도계 등)를 구비하고, 응급수술 혹은 응급 분만 발생 시 신속히 분만실/수술실로 이송할 수 있게 동선을 최적화한다.

분만실과 수술실 인프라도 24시간 가동 전제로 유지보수한다. 무정전 전원 공급(UPS) 체계를 점검해 **심야 응급수술 시 정전 등의 사태에 대비**하고, 소생술 카트, 수혈 세트 등 응급물품을 상시 비치한다. 환자 증가에 대비하여 **병상 수 확충**또는 **관찰병상(observation bed)**운영도 검토한다. 예컨대 야간에 일시 관찰이 필요한 산모나 경증 환자를 위해 **관찰용 간이침대**몇 개를 준비해두고, 필요 시 입원전 관찰 공간으로 활용한다.

의료장비 및 기술 업그레이드:

24시간 진료에서는 **검사 및 진단 장비의 신뢰성과 가용성**이 중요하다. 따라서 영상진단 장비(초음파, X선 등)를 점검하여 **야간에도 즉시 가동 가능**하도록 유지하고, 추가로 **이동형 초음파**기기를 구비해 응급 상황 시 신속히 사용할 수 있게 한다. 검사실에는 ****간이 진단장비(POCT)****를 확충하여, 심야에 혈액검사, 소변검사, 간단한 혈액가스 분석 등이 가능하도록 한다. 예를 들어, 임산부 응급 평가를 위해 필요한 CBC, 혈액형, 응급산전검사 등을 15분 내 결과 확인할 수 있는 장비를 도입한다. **원내 약국**도 심야에 문을 닫는 경우가 많으므로, 야간 응급환자에게 필요한 필수약품 목록을 선정하여 **야간 당직실 등에 비치**한다(예: 자궁수축 억제제, 지혈제, 항생제 등). 만일 약사 인력이 부재한 시간에는 의사가 직접 해당 상비약을 조제·투여하고, 사후에 약사가 검수하도록 절차를 만든다.

또한 **디지털 기술**을 활용하여 진료 효율을 높인다. ****병원 정보시스템(HIS/EMR)****을 클라우드 기반 최신 버전으로 업그레이드하거나 원격 접속 기능을 강화하여, 야간에도 의료진이 **모바일 기기로 환자 정보 열람 및 입력**을 할 수 있게 지원한다. 이를 통해 당직 의사가 병동 회진 중에도 신규 외래 환자 정보를 확인하거나 처방을 내릴 수 있다. **원격협진/화상회의 시스템**도 구축하여, 야간에 어려운 증례 발생 시 **다른 병원 전문의와 원격으로 상의**하거나, 필요하면 상급병원과 화상으로 연결해 환자 이송 여부를 판단한다. 예를 들어 고위험 산모 상태를 대학병원 모니터와 공유하여 공동 판단하도록 하는 등 **텔레메디신(telemedicine)**기술을 안전장치로 활용한다.

안전성 강화:

24시간 운영 시 **직원 및 환자 안전**이 최우선이다. 심야에는 병원 출입을 통제하여 **주 출입구를 단일화**하고 보안인력을 배치한다. **CCTV 모니터링**을 통해 야간 시간대 병원 내 외부인 동향을 파악하고, 위험 상황 시 신속 대응할 수 있도록 **비상벨/비상연락 체계**를 구축한다. 예를 들어 야간 진료구역과 경비실이 연결된 비상 호출버튼을 설치하여, 의료진이 위급 상황(폭언·폭행 등)에 즉시 도움을 요청할 수 있게 한다. 또한 **응급상황 대응 매뉴얼**(화재, 정전, 재해 등)을 정비하고 야간 근무자 대상 **모의훈련**을 시행한다. 화재 대비 피난로 표시, 소화기/소화전 점검 등을 통해 **심야 화재 대비태세**를 갖춘다. **의료폐기물 처리나 멸균 관리**등도 24시간 체제에 맞춰 재점검하여, 밤시간대에도 감염관리나 위생에 소홀함이 없도록 한다.

환자 편의 시설:

야간에도 내원하는 환자와 보호자를 위해 **편의시설**을 보강한다. 24시간 개방되는 화장실, 수유실, 정수기 등을 깨끗이 유지하고, 심야 대기 환자를 위한 담요, 온음료 제공 등을 준비한다. 병원 인근 주차장이용이 제한될 경우를 대비해 **심야 주차 안내**를 마련하고, 대중교통이 끊긴 심야에 귀가가 어려운 환자에게는 **협약된 콜택시 연락처** 제공이나 필요시 **귀가 지원 서비스**를 검토한다.

시설 투자 및 단계적 개선:

시설·장비 확충에는 상당한 비용이 소요되므로 **단계별 투자계획**을 세운다. 1단계로 필수 장비(이동형 초음파, POCT 등)와 보안장치 등을 우선 도입하고, 2단계로 공간 리모델링 및 추가 장비, 3단계로 대규모 시설 확장(예: 별도의 여성응급센터 건립) 등의 계획을 수립한다. 투자 우선순위는 **환자 안전과 진료 연속성에 직접적으로 관련된 항목**에 둔다. 예산은 병원 자체자금과 정부 지원금을 조합하여 충당하며, 설비 도입 시 **정부의 시설보조금이나 의료기관 인증평가 가산**등을 활용할 수 있는지 확인한다.

시설·인프라를 강화함으로써, 메디피아산부인과병원은 **야간진료를 뒷받침하는 물리적 기반**을 확보하고 **환자에게 24시간 안심 환경**을 제공할 수 있다. 이는 **의료진이 최상의 진료를 제공할 수 있는 작업환경**을 마련하는 것이기도 하다. 안정적인 인프라 없이는 인력과 시스템이 제 역할을 할 수 없으므로, 선제적 투자와 지속적인 안전관리로 24시간 운영체계를 탄탄히 뒷받침해야 한다.

7. 수익성 분석 및 건강보험 수가/비급여 수입/정부지원 활용 전략

운영 확대에 따른 수익-비용 구조 분석:24시간 진료 확대는 **추가 수익 창출**의 기회인 동시에 **비용 증가** 요인이다. 먼저 예상되는 **비용 증가**요인을 살펴보면, ▲전문의 추가 근무수당 및 야간근무 인센티브, ▲간호사 등 교대인력 인건비 상승, ▲야간 조명·공조 등 시설 유지비 증가, ▲심야 진료시 소모품 비용, ▲시설/장비 투자에 따른 감가상각비 등이 있다. 반면 **수익 증가**측면에서는, ▲진료시간 확대로 인한 환자 외래진료 건수 증가, ▲야간 응급수술/분만 증가에 따른 수술수입 및 입원수입 증가, ▲기존에 타 병원으로 이탈되던 환자 유치로 인한 시장점유율 상승, ▲휴일/야간 가산 수가 적용으로 인한 진료료 증대, ▲비급여 항목 매출 증대(야간 초음파 등), ▲병원 브랜드 가치 상승에 따른 간접효과(환자 증가) 등을 들 수 있다.

건강보험 수가 활용 전략:

현재 건강보험에서는 야간·공휴 외래진료에 대해 가산수가를 일부 인정하고 있다. 예를 들어 평일 야간(18시 이후)이나 공휴일 진료 시 진찰료 등에 **30% 내외의 가산**을 부여하는 규정이 있으며, 이는 달빛어린이병원 등 시범사업에서는 추가 인센티브로 확대 적용되기도 했다 ([달빛어린이병원 운영비 45억 지원...소아과 대란 숨통 트일까](#)). 우리 병원은 모든 야간/휴일 진료 건

에 해당 가산 수가를 빠짐없이 청구하여 수익을 높인다. 또한 응급의료관리료 등 응급환자 진료 관련 수가를 최대한 적용한다. 비록 공식적으로 응급실이 아니더라도, 심야에 응급처치를 한 경우 해당 처치료나 가산 항목을 청구할 수 있는지 건강보험 청구 기준을 검토하여 누락되는 수가가 없도록한다.

산부인과의 특성상 **분만에 대한 수가(자연분만, 제왕절개 등)**가 큰 부분을 차지하므로, 24시간 체제로 분만 건수가 증가하면 이에 따른 보험 수입이 증가하게 된다. 특히 **고위험 분만 수가, 응급수술 수가** 등은 상대 가치점 수가 높기 때문에, 야간 발생한 응급 제왕절개 등의 건수를 늘림으로써 수익성을 보전할 수 있다. 추가로, 최근 정부가 논의 중인 **심야 소아진료 진찰료 2배 인상**등과 유사한 **야간 진찰료 인상 정책**이 산부인과에도 적용될 가능성에 대비하여 정책동향을 주시하고, 시행 시 발빠르게 참여한다 ([달빛어린이병원 운영비 45억 지원...소아과 대란 숨통 트일까](#)).

비급여 수입 극대화:

산부인과는 비급여 항목도 상당한 비중을 차지한다. **초음파 검사**의 경우 산과 초음파는 보험적용 확대로 대부분 급여화되었지만, **부인과 초음파나 추가 요구되는 정밀초음파** 등은 여전히 비급여인 경우가 있다. 야간진료 시 산모들이 추가 초음파를 원하거나 안심을 위해 **비급여 태아검사**(예: 태아상태 심화검사 등)를 선택할 수 있으므로, 이러한 서비스를 마련해둔다. 또한 **무통분만(경막외 마취)**, **가족분만실 이용**, **산후통증 관리 주사**등 출산 관련 비급여 서비스도 적극 안내하여 이용률을 높인다. **병실 차액**(1인실 사용료)이나 **산후조리원 연계 서비스**등도 부대수입으로 고려할 수 있다. 만약 병원 부설 산후조리원을 갖추고 있다면, **24시간 의료진 대기**가 가능한 **안전한 조리원**이라는 점을 강조하여 산모들을 유치하고 조리원 운영 수익도 연계 상승시킨다. **미용/성형 관련 부인과 시술**(산후 체형 관리, 여성 성형수술 등)도 환자 요청 시 제공하여 추가 수입을 얻는다. 단, 비급여 서비스 증대 시 **환자에게 명확한 비용 안내와 동의**를 구하여 신뢰를 유지해야 한다.

정부 지원금 및 재정지원:

국내 달빛어린이병원 사례에서 보듯이, 정부와 지자체는 **야간·휴일 진료기관**에 대해 **운영비 보조금**을 지급하고 있다. 2024년의 경우 정부는 달빛어린이병원 한 곳당 **연간 3천만원에서 최대 4억3천2백만원**까지, 운영 시간에 비례하여 지원할 계획이다 ([달빛어린이병원 운영비 45억 지원...소아과 대란 숨통 트일까](#)). 비록 이는 소아과 대상이지만, 산부인과 병원이라도 지역 여건에 따라 유사한 지원을 신청할 수 있다. 예를 들어 관할 보건소나 지자체에 **“달빛 산부인과 클리닉”** 지원을 제안하여 시범사업 형태로 일부 지원을 받을 수 있는지 모색한다. 혹은 달빛어린이병원 지정은 소아청소년과 기준이나, 병원이 **소아청소년과 전문의를 채용하여 소아진료도 병행**할 경우 달빛어린이병원으로 지정받아 해당 지원금을 수령할 가능성도 있다. 이러한 **제도적 지원 루트**를 다각도로 검토하여, 될 수 있으면 정부보조금을 확보함으로써 운영적자 가능성을 줄인다 ([늦은밤 아프면 참아야?...밤에도 문 여는 병원 '있다' - 국민이 말하는 정책 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑](#)) ([달빛어린이병](#)

[원 운영비 45억 지원...소아과 대란 숨통 트일까](#)). 아울러 **응급의료기금**이나 **지역의료 강화 예산** 등에서 지원받을 수 있는 항목(예: 응급장비 구입비, 분만산부인과 인건비 보전 등)을 적극 탐색한다. 산부인과는 현재 인력 부족으로 분만취약지 지원 등이 이뤄지는 분야이므로, 비록 우리 병원이 속한 지역이 취약지로 지정되지 않더라도 ****“지역 산부인과 응급센터”**로서 역할을 강조하면 **특별교부금**이나 **공공의료 사업비**를 지원받을 여지가 있다.

수익성 모니터링 및 개선:

야간진료 시행 후에는 **별도의 손익계산**을 통해 수익성을 주기적으로 평가한다. 야간 시간대의 진료수입과 인건비·소모품비 등을 따로 집계하여 **시간대별 손익분기점 환자 수**를 산출하고, 이를 경영지표로 삼는다. 예를 들어 “22시~익일 6시 사이 평균 외래 환자 X명 이상일 때 흑자”라는 수치를 산출하여, 실제 환자 유입이 이에 못 미칠 경우 **마케팅 강화** 또는 **운영인력 조정** 등 대책을 세운다. 반대로 환자가 예상보다 많아져 대기 시간이 길어지거나 서비스 질이 저하되면, 추가 인력 투입 등을 통해 **환자당 적정 서비스 시간**을 확보하여 만족도를 유지하면서도 **회전율을 높여 수익 증가**를 도모한다.

장기 수익 전략:

단기적으로는 야간진료로 인한 직접 수입 증대를 중점 관리하되, 장기적으로는 **병원 평판 향상으로 인한 환자증가 효과**까지 포함한 포괄적 수익성을 추구한다. 24시간 운영으로 **지역 내 산부인과 시장점유율**을 확대하면 주간 매출도 자연스럽게 증가할 수 있다. 또한 경쟁 의료기관 대비 우위에 서게 되어 ****분만 환자나 고위험 임신 환자의 리퍼럴(referral)****이 늘어나고, 이것이 입원 수익 증가로 연결된다. 미국 사례처럼 야간클리닉이 ****“환자와 보험사 모두가 선호하는 모델”**이 되어 주변 대형병원 응급실보다 선택받음으로써 장기적으로 수익성이 크게 개선된 예도 있다 ([Creating a Successful After-Hours Clinic | AAFP](#)).

우리 병원도 지역 내 필수의료로 담당함으로써 **우호적인 보험 청구 환경**을 조성(보험사 협상력 강화)할 수 있고, **추후 병원 확장 시 투자 유치**에도 긍정적 이미지를 심어 재정적으로 유리해질 수 있다.

결론적으로, 수익성 강화를 위해서는 ****다각도의 수입원 확보(보험수가, 비급여, 보조금)****와 **철저한 비용관리**가 병행되어야 한다. 실행 초기에는 일정 수준의 적자 감수 혹은 낮은 이익률이 예상되지만, 정부 지원과 환자 증가세를 고려한 중장기 계획을 통해 5년 내 안정적인 흑자 기반을 구축하도록 한다. 현실적으로 성세병원도 야간진료 수익이 안정되기까지 5~10년이 걸렸다는 점을 유념하여 ([늦은밤 아프면 참아야?...밤에도 문 여는 병원 ‘있다’ - 국민이 말하는 정책 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑](#)), 단기적인 손익보다 **전략적인 관점에서 투자**한다면 결과적으로 병원의 지속가능한 성장 동력이 될 것이다.

8. 지역사회 연계 강화 및 대외홍보 전략

지역 의료기관과의 연계:

메디피아산부인과병원이 24시간 진료를 확대하면, 인근 개원의 및 타 의료기관과의 협력이 중요하다. 낮에는 동네 산부인과 의원들이 환자를 진료하지만, 야간에는 문을 닫기 때문에 이들 의원의 환자를 밤에 우리 병원이 이어받는 협조체계를 구축한다. 이를 위해 지역 개원의들과 간담회를 열어 야간·휴일에 발생한 산부인과 응급환자나 문의 환자를 우리 병원으로 의뢰하도록 협력관계를 맺는다. 예컨대 지역 산부인과 외래환자들에게 “우리 병원과 연계된 달빛산부인과 진료 안내문”을 배포하여, 야간에 증상 발생 시 바로 메디피아산부인과병원으로 연락/내원하도록 홍보한다. 이렇게 하면 개원의들은 야간 대응 부담을 줄이고 환자도 안전하게 연속 진료를 받을 수 있어 윈윈이 된다. 또한 분만을 하지 않는 산부인과 의원의 임산부들도 분만 시 우리 병원으로 소개될 수 있도록 하여 분만 리퍼럴 네트워크를 강화한다. 지역 **응급의료기관(응급실)**과도 협력해, 일반 종합병원 응급실에 산부인과 환자가 오면 우리 병원으로 후송하거나 전문의 상담을 요청하는 체계를 만든다. 특히 119구급대에는 우리 병원의 24시간 운영 정보를 공유하여, 산과 응급시 1차 이송병원으로 고려되도록 한다.

커뮤니티 참여와 공헌:

지역사회와 친밀도를 높이기 위해 공공보건 행사나 프로그램에 적극 참여한다. 예를 들어 산모 교실, 임신/출산 건강강좌등을 정기적으로 개최하여 예비 산모들에게 유용한 정보를 제공하고 병원의 시설과 의료진을 소개한다. 이러한 행사를 주간뿐 아니라 야간 시간대에도 운영하여, 직장인 부부가 퇴근 후 참석할 수 있게 하면 호응을 얻을 수 있다. 지역 보건소, 산후조리원, 어린이집등과 연계해 산모 응급대응 교육을 실시하거나, 모유수유 클리닉같은 봉사프로그램을 운영하여 공공의료 역할을 강화한다. 이러한 활동들은 병원의 이미지를 개선하고 지역민에게 친숙한 병원이 되는 데 기여한다. 필요 시 지역언론과 협력하여 건강칼럼 기고나 의사 인터뷰를 진행, “24시간 산모지킴이 병원”이라는 컨셉을 알린다.

대외 홍보 전략:

종합적인 마케팅 캠페인을 전개하여 병원의 24시간 운영과 우수성을 알린다. 주요 메시지는 “밤에도 문 여는 믿을 수 있는 산부인과”, “응급실 가지 마세요 - 메디피아가 24시간 함께합니다”등으로 정하고, 다양한 채널로 홍보한다:

- 온라인 홍보:

병원 홈페이지를 개편하여 야간·휴일 진료안내 페이지를 눈에 띄게 게시하고, 검색엔진 최적화(SEO)를 통해 관련 키워드(예: “남양주 산부인과 야간진료”) 검색 시 상단에 노출되도록 한다. **SNS(소셜미디어)**에서도 페이스북, 인스타그램 등에 산모 대상 콘텐츠를 제작하여 공유한다. 예를 들어 심야 진료 사례 후기나 의료진 인터뷰 영상을 올려 신

뢰감을 주고, 카카오톡 채널을 활용해 24시간 상담 챗봇이나 간단 문의 응답 서비스를 제공한다.

- 오프라인 홍보:

지역 맘카페, 산모교실 모임 등에 리플릿과 쿠폰을 배포한다. 리플릿에는 24시간 진료 내용과 긴급상황시 대처법 등을 담고, 첫 야간진료 시기 기념품 제공 쿠폰 등을 포함해 병원 방문을 유도한다. 또한 현수막이나 옥외광고를 통해 지역 거점에 “24시 산부인과 진료”를 홍보한다. 지역 버스정류장, 지하철역 등에 포스터를 부착하고, 버스 내부 광고 등도 검토한다.

- 언론 및 PR:

지역신문, 지역케이블TV 뉴스 등에 보도자료를 배포한다. “남양주 최초 24시간 산부인과 외래 운영 개시” 등의 제목으로 병원의 새 시도를 뉴스화하여 대외 인지도를 높인다. 특히 **응급상황에서 병원이 활약한 사연**(예: “새벽 2시에 대출혈 산모, 메디피아병원서 무사 분만”) 등을 언론에 소개하면 병원의 **의료공헌 이미지**를 제고할 수 있다. 이러한 스토리텔링 홍보는 일반 대중의 관심을 끌어 **병원의 신뢰도를 상승**시키는 효과가 있다.

환자경험 홍보:

실제 야간진료를 받은 ****환자들의 긍정적 경험담(후기)****을 확보하여 홍보에 활용한다. 예를 들어 “늦은 밤 진료를 받아 안심됐다”는 산모 인터뷰나, “응급 상황에 병원 덕분에 아이를 지켰다”는 보호자 편지 등을 **웹사이트나 브로셔에 게재**한다. 이러한 ****사회적 증명(소셜 프루프)****은 잠재 환자들에게 큰 신뢰를 준다. 더불어 **만족도 설문조사**를 실시하여, 야간진료 환자의 만족도를 수치로 표시하고 이를 홍보자료에 포함시킨다 (예: “야간진료 만족도 95%, 매우 만족 80%” 등).

지역밀착 홍보:

지역 주민행사에 병원이 참여하여 **직접 홍보**한다. 예를 들어 지역 축제나 마라톤 대회 등에 부스를 열고 간단한 건강상담, 임산부 응급처치 교육 등을 제공하면서 병원의 24시간 운영을 알린다. 또한 지자체와 협력하여 산모에게 지원되는 **출산장려금 안내서** 등에도 병원 안내를 포함시킨다.

이러한 다각적인 홍보노력의 궁극적인 목표는 ****“메디피아산부인과=24시간 믿을 수 있는 병원”**이라는 인식을 지역사회에 심는 것이다 ([늦은밤 아프면 참아야?…밤에도 문 여는 병원 ‘있다’ - 국민이 말하는 정책 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑](#)). 시간이 지날수록 성세병원이 그랬듯이 **지역민들에게 진료를 공기처럼 누릴 수 있는 곳**으로 인식되면 ([늦은밤 아프면 참아야?…밤에도 문 여는 병원 ‘있다’ - 국민이 말하는 정책 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑](#)),

응급시 뿐만 아니라 일반 진료에서도 최우선으로 선택받는 지역 의료허브로 자리매김하게 된다. 홍보전략은 일회성이 아니라 지속적인 커뮤니케이션 활동으로 전개하여, 병원의 메시지가 잊혀지지 않고 꾸준히 지역사회에 스며들도록 한다.

9. 공공지정병원 또는 달빛병원 지정 검토 및 제도적 이점 확보 방안

“공공의료 협력병원” 지정 검토:

메디피아산부인과병원이 수행하려는 24시간 진료는 지역사회 필수의료 제공 측면에서 공공적 성격이 강하다. 따라서 이를 제도적으로 인정받아 공공지정 병원에 준하는 지위를 확보하면 각종 지원과 혜택을 받을 수 있다. 우선 검토할 수 있는 것은 보건복지부 또는 지자체의 공공보건의료 협력체계 참여이다. 예를 들어 시·군단위로 운영되는 지역보건의료계획에 우리 병원을 지역 산모·신생아 응급의료 협력병원으로 포함시켜, 공공보건의료 수행기관으로 인정받는 방안을 찾는다. 이것이 공식화되면, 공공의료 관련 예산 배정이나 세제 혜택(의료설비 지원, 재산세 감면 등)을 신청할 때 우선 고려될 수 있다. 또한 응급의료기관으로의 지정도 검토해본다. 응급의료에 관한 법률상 일정기준을 충족하면 지역응급의료기관으로 지정될 수 있는데, 산부인과 단일과목 병원의 경우 이를 충족시키기 어려울 수 있지만, 만약 현실적으로 힘들다면 분야별 응급센터형태(예: “분만응급센터”지정 등)의 정책 건의를 통해서라도 제도권 진입을 모색한다. 정부는 분만 취약지 해소 등을 위해 민간 병원 지원을 확대하는 추세이므로, 이러한 맥락에서 우리 병원을 시범적 분만센터로 지정하여 지원할 여지를 찾아본다.

달빛병원 지정 및 참여:

앞서 언급한 달빛어린이병원제도는 소아과 야간진료에 집중된 것이지만, 우리 병원도 간접적 또는 직접적으로 참여를 고려할 수 있다. 간접적 참여방안은, 병원 내에 소아청소년과 진료를 일정 수준 운영하여 달빛어린이병원 지정을 받는 것이다. 예컨대 소아청소년과 전문의를 영입하여 평택 성세병원처럼 소아 환자도 24시까지 진료한다면 ([늦은밤 아프면 참아야?...밤에도 문 여는 병원 ‘있다’ - 국민이 말하는 정책 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑](#)) ([늦은밤 아프면 참아야?...밤에도 문 여는 병원 ‘있다’ - 국민이 말하는 정책 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑](#)), 달빛어린이병원으로 선정되어 정부의 운영비 보조금(월 1500만원 이상)과 심야 추가 보조금([늦은밤 아프면 참아야?...밤에도 문 여는 병원 ‘있다’ - 국민이 말하는 정책 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑](#))을 받을 수 있고, 지역 주민들에게는 18세 미만 자녀까지 함께 보는 병원으로 어필하게 되어 환자층이 넓어진다. 특히 산부인과 병원이 소아과 진료까지 커버하면 산모와 아이를 한곳에서 관리하는 장점이 있기에, **“달빛 산모-어린이 통합병원”**이라는 차별화가 가능하다. 물론 이는 추가 전문의 확보가 전제되어야 하므로, 단기보다는 중기 계획으로 검토하되, 실현 가능성을 타진하기 위해 미리 소아청소년과 협진체계를 구축해둘 수 있다.

산부인과 대상 야간진료 지정 제도 건의:

현재는 소아과 외에 성인과목에 대한 달빛병원 제도는 없지만, **저출산 및 분만인프라 감소** 문제로 산부인과 야간진료 필요성이 대두되고 있다. 병원 측에서 **보건당국에 정책건의**를 통해 “산부인과 달빛병원” 지정 제도를 제안할 수 있다. 이를 위해 우리 병원의 야간진료 데이터를 꾸준히 축적하고, ****야간진료의 지역보건 기여도(응급실 경감 효과, 산모 안전도 향상 등)****를 분석하여 보건복지부나 지자체에 보고한다. 또한 유사한 뜻을 가진 타 지역 산부인과 병원들과 연대하여 **협의체**를 만들고, **시범사업**을 건의하면 정책으로 채택될 가능성을 높일 수 있다. 만약 이러한 제도가 도입된다면, 우리 병원은 **선도적으로 지정되어 재정 지원, 인력 지원, 홍보지원** 등 여러 혜택을 받을 수 있을 것이다. 현재 달빛어린이병원에 참여하지 않은 의료기관도 야간·휴일 진료 시 운영비를 지원한다는 정부 발표가 있으므로 ([달빛어린이병원 운영비 45억 지원...소아과 대란 숨통 트일까](#)), 해당 조항을 산부인과 분야에도 적용받을 수 있도록 협상하거나, 지자체 차원에서라도 **별도 예산 지원**을 요청한다.

제도 참여에 따른 혜택:

공공 또는 달빛 지정 시 기대할 수 있는 **이점**은 크게 세 가지다. 첫째, **재정 지원**이다. 앞서 언급한 월 보조금 이외에도, 달빛병원 지정 시 건강보험에서 **야간 가산수가를 응급의료 수준으로 상향**하는 등의 혜택이 있을 수 있다. 실제로 의료계에서는 달빛어린이병원의 수가를 응급실 수준으로 올려줘야 한다는 주장이 있고 ([달빛어린이병원 운영비 45억 지원...소아과 대란 숨통 트일까](#)), 정책당국도 관련 수가 인상을 검토 중이다 ([달빛어린이병원 운영비 45억 지원...소아과 대란 숨통 트일까](#)). 만약 산부인과 야간진료도 제도화된다면 이와 유사한 **수가 인상 혜택**을 볼 수 있다. 둘째, **시설/장비 투자 지원**이다. 공공협력병원으로 지정되면 응급장비나 인프라 확충 시 국고보조를 받기 용이하며, 인력 교육훈련 프로그램도 지원받을 수 있다. 예를 들어 응급의학과 관련 연수기회 제공, 분만응급 대응 훈련을 위한 시뮬레이터 지원 등을 기대할 수 있다. 셋째, **대외 신인도 상승**이다. 정부 지정병원 타이틀은 환자들에게 **신뢰감**을 주고 **홍보 효과**를 높인다. 예를 들어 달빛어린이병원 지정 기관들은 정부 응급의료포털에 안내되며, 부모들이 우선적으로 찾는 효과를 누리고 있다 ([달빛어린이병원 - MOONLIGHT - 응급의료포털](#)). 마찬가지로 우리 병원이 공공달빛병원으로 알려지면 **지역 내 브랜드 파워**가 크게 향상될 것이다. 이는 곧 환자 증가와 수익성 향상으로도 이어지는 간접 이익이다.

제도적 리스크 관리:

한편, 공공의료 참여로 인한 부담도 고려해야 한다. 지정 조건으로 **보고 의무**나 **추가 행정업무**가 늘어날 수 있고, ****지원금에 상응하는 책임(필수 운영시간 준수 등)****이 요구된다 ([달빛어린이병원 운영비 45억 지원...소아과 대란 숨통 트일까](#)). 예컨대 지원금을 받고 일정 기간 진료를 안 하면 환수 조치가 있다는 규정 등이 있다 ([달빛어린이병원 운영비 45억 지원...소아과 대](#)

란 숨통 트일까). 우리 병원은 이를 **성실히 이행할 계획**을 수립해야 하며, 혹여 환자수 급감 등으로 조건을 못 지키는 경우가 없도록 **사전 대책**을 마련한다. 또한 정부 정책 변화에 따라 지원이 축소되더라도 **병원 스스로 운영**을 지속할 수 있는 **자생력**을 갖추는 것이 중요하다.

민간 공공병원 사례 참고:

국내에 민간이면서 공공의료를 수행하는 사례로 **적십자병원**등이 있는데, 이들 병원은 지자체로부터 위탁받아 필수진료를 제공하며 재정지원을 받고 있다. 완전히 동일한 상황은 아니지만, **민간병원의 공공의료 수행모델**로서 운영 경험과 정부와의 협조관계를 참고할 수 있다. 또한 ****달빛어린이병원 증가 추이(2022년 35개 → 2024년 70개 예정)****를 보면 (**달빛어린이병원 운영비 45억 지원...소아과 대란 숨통 트일까**), 정부가 이 모델을 계속 확대 중임을 알 수 있기에, 산부인과 분야도 머지않아 유사한 흐름이 올 것을 예상하고 **선제적으로 준비**한다.

요약하면, **제도권의 지원과 보호막 속으로 들어가는 전략**을 모색함으로써 병원의 야간진료 확대를 더욱 안정적으로 지속할 수 있게 할 것이다. 공공지정이나 달빛병원 지위는 **병원의 사명을 인정받는 동시에 실질적 지원을 획득**하는 길이므로, 관련 요건과 절차를 면밀히 검토해 추진한다.

10. 단계별 실행 로드맵 (단기·중기·장기 추진 전략 포함) 및 우선순위

단기 (0 ~ 1년): 준비 및 파일럿 단계

1. 사업계획 확정 및 투자 확보:

병원 경영진과 핵심의료진이 모여 24시간 운영에 대한 **세부 실행계획**을 확정짓는다. 인력 소요, 예상 비용, 필요 시설 등을 산출하여 **예산 계획**을 수립하고, 이사회 승인 및 투자 확보를 완료한다. 초기 투자 예산은 필수 항목 위주로 편성하고, **정부 및 지자체 지원금 신청**을 동시에 진행한다 (예: 남양주시 보건소에 야간진료 지원사업 신청).

2. 인력 충원 및 조직 개편:

야간전담 의사 1~2인 **채용**또는 내부 전문의 순환근무 스케줄 조정을 실시한다. 간호사 등 **교대인력 채용 공고**를 내고, 원무/검사 등 부서별로 교대제를 도입한다. 기존 직원들에게는 새 근무체계에 대한 설명과 동의를 구하고, 필요 시 인센티브 협의를 진행한다.

3. 시설 및 시스템 정비:

야간진료 공간 조성을 위한 경미한 공사 및 장비 구비를 시행한다. 응급처치실을 보강하고, 보안시스템(출입문 통제 등)을 설치한다. EMR 업그레이드, 야간 약품키트 준비 등 **기술적 준비**를 완료한다.

4. 내부 교육 및 시뮬레이션:

전직원을 대상으로 야간진료 프로토콜 교육을 실시한다. 동시에 **모의 야간환자 시나리오**(예: 심야 산모 출혈 대응, 휴일 야간 경증환자 처리 등)를 통해 **테스트 운영**을 해본다. 이 과정에서 발견되는 문제점(인력 배치 문제, 시스템 오류 등)을 수정한다.

5. 시범 운영 (Pilot):

공식 시행 전 일부 요일에 한해 연장진료 파일럿을 시작한다. 예를 들어 주 2회 (수요일/토요일) 자정까지 연장진료를 1~2달 간 시범실시하여 환자 유입과 운영상의 애로를 파악한다. 시범 기간 동안 환자 피드백을 수렴하고, 직원들의 체감 난이도를 조사한다. 이를 바탕으로 프로세스를 다듬고 필요한 인력을 추가 배치한다.

6. 홍보 개시:

병원 내원 환자와 지역주민 대상으로 곧 24시간 진료 시행 예정임을 **홍보**한다. 대기실 포스터, SMS 안내 등을 통해 *“오는 XX월부터 메디피아산부인과는 밤에도 진료합니다”*를 알리고, 커뮤니티에도 소식을 전파한다.

중기 (1 ~ 3년): 확대 및 안착 단계

1. 24시간 운영 본격 시행:

시범운영 결과를 반영하여 주 7일 24시간 외래진료체계를 공식 출범시킨다. 초기에는 평일/토요일 자정까지, 일요일 21시까지등으로 시작하고, 6개월 내로 완전 24시간으로 확대하는 단계적 시행 일정을 따른다. 이행 과정에서 나타나는 수요 변동에 따라 인력 탄력 배치등을 조정하며, 큰 문제 없이 24시간 체제를 안착시킨다.

2. 모니터링과 개선:

월별로 운영 성과 지표를 확인한다. 야간외래 환자 수, 수익/비용, 환자 만족도, 직원 만족도, 의료사고 발생 여부 등을 지표화하여 경영진 회의에서 검토한다. 예컨대 “야간 평균 외래환자 1일 20명, 분만 건수 월 5건 증가” 등의 데이터를 분석한다. 이 결과를 토대로 병목 요인을 개선한다 (예: 새벽 시간 환자 너무 적으면 해당 시간대 인력 최소화 등). 또한 진료 질 관리를 위해 환자들의 의료결과(컴플레인 여부, 재입원율 등)를 점검하고, 필요시 프로토콜을 수정한다.

3. 서비스/분야 확장:

2년 차부터는 병원의 진료 분야를 확대한다. 예를 들어 소아청소년과 진료 개시여부를 타진하여, 가능할 경우 소아과 의사 1명을 영입하여 평일 야간 소아진료를 시범적으로 시작한다. 혹은 난임클리닉 연장운영 등을 통해 야간에 기존에 없던 서비스(예: 직장인을 위한 저녁 불임상담)를 추가한다. 이러한 서비스 확장은 병원의 지역 의료허브로서의 기능을 더욱 공고히 한다.

4. 네트워크 구축:

인근 산부인과 의원 100%와 협약을 맺고, 지역 산부인과 SNS 네트워크를 가동한다. 이를 통해 환자 의뢰와 회송(되돌려 보내기)이 체계적으로 이뤄지도록 하고, 응급상황 공동관리 체계를 마련한다. 또한 인근 종합병원(예: 남양주OO병원 등)과 고위험 산모 후송 협약을 체결하여, 우리 병원에서 감당 어려운 케이스는 안전하게 이송하고, 반대로 해당 병원에서 경증 산과 환자는 우리에게 의뢰하도록 역할 분담을 확립한다.

5. 브랜드 강화 홍보:

지역 내 분만을 증가 통계나 성공 사례등을 중심으로 홍보활동을 이어간다. “작년 대비 분만 30% 증가, 지역 산모의 80%가 우리 병원 선택” 등의 지표를 언론에 공개하여 지역 대표 산부인과로서 입지를 굳힌다. 또한 환자 인터뷰 영상, 직원 헌신 스토리 등을 홍보하여 신뢰와 감동 스토리를 전달함으로써 브랜드 이미지를 높인다.

6. 재무 성과 평가:

2~3년 시점에서 사업타당성 재평가를 실시한다. 야간진료로 인한 전체적인 손익 변화를 분석하고, 당초 목표 대비 성과를 평가한다. 만약 기대 이하의 성과일 경우 그 원인을 찾아 대책(더 공격적인 마케팅, 특정 시간대 축소 등)을 마련하고, 기대 이상일 경우 추가 투자 여력을 검토한다.

장기 (3년 이후): 최적화 및 발전 단계

1. 지속적 품질관리:

24시간 운영이 일상화되어 안정기에 접어들면, 의료의 질 관리에 초점을 맞춘다. 의료진 피로 누적으로 인한 실수 방지, 환자 개인정보 보호(야간에는 보안이 허술해지기 쉬우므로) 등 세심한 질관리 프로그램을 운영한다. 또한 보건 의료 인증평가등에 대비하여 병원의 모든 운영이 표준화되고 개선되었는지 점검한다.

2. 공식 지정 및 협력 확장:

3~5년 시점에 **공공야간진료센터**로의 **공식 지정**을 달성하도록 노력한다. 정부나 지자체로부터 “달빛산부인과병원”과 같은 **공식 명칭**을 부여받아 대내외적 인정을 획득한다. 이와 함께 **추가 지원**(필요 장비, 운영비 등)을 받아내고, 그 자격을 유지한다. 또한 **주변 지역**(인근 시군)의 산부인과 거점병원들과 연계하여 **광역네트워크**를 형성, 우리 병원이 그 중추를 맡는다. 예를 들어 인접한 타 지역에서 산부인과 응급환자 발생 시 우리 병원으로 오는 루트를 구축하는 등 **권역 의료허브**로 발전한다.

3. 시설 투자 2단계:

병원의 장기 비전 하에 **시설을 확충**한다. 수년간의 운영 데이터에 따라 필요한 경우 별도의 **야간응급센터** 동을 신축하거나, 분만실/수술실을 증설한다. 혹은 **산후조리원 증축**이나 **신생아실 NICU 시설 강화**등을 통해 **모자보건 원스톱센터**로의 발전을 도모한다. 이는 지역 의료수요와 병원 재정 상황에 맞춰 단계적으로 실행한다.

4. 인력 양성 및 연구:

24시간 운영체계 경험을 토대로 **표준 모델**을 만들어낸다. 이를 바탕으로 다른 병원들에게 노하우를 전수하거나, 학회나 보건당국 주최 워크숍에서 우리 사례를 발표하여 **산부인과 야간진료 선구자**로서 자리매김한다. 병원 내부적으로는 **교육병원 지정**을 추진하여 레지던트 수련병원이 되거나, 간호대학 실습협약 등을 통해 **인력 양성에 기여**한다. 또한 **임산부 응급관리 연구**, **지역 모성사망을 개선 연구**등 임상연구를 수행하여 학문적 발전에도 이바지한다. 이처럼 **의료, 교육, 연구가 조화를 이루는 지역 거점병원**으로 성장시키는 것이 장기 목표이다.

5. 지속 가능한 경영:

야간진료 부문도 이제 안정적인 흑자를 내는 **병원 수익 포트폴리오의 일환**이 되어 있을 것이다. 정기적으로 서비스 가격을 재검토(비급여 수가 적정 조정 등)하여 수익성을 유지하고, 비용 절감을 위한 신기술(예: AI 스케줄러로 인건비 최적화 등)을 도입한다. 무엇보다도 **직원 만족도 관리**를 통해 인력이탈을 최소화하고, 축적된 경험이 유실되지 않도록 한다. 야간전담팀에 대한 처우를 꾸준히 개선해 **업계 최고의 근무환경**으로 만들면, 인재들이 몰려들어 병원의 경쟁력이 더욱 강화되는 선순환을 이룬다.

핵심 실행 포인트 및 우선순위:

- 1순위 - 인력 및 안전 기반 구축:

무엇보다 의료진·직원의 확보와 피로관리, 안전체계 강화가 선결과제다. 이는 24시간 운영의 토대이며, 우선순위 1번으로 자원 투입과 관리가 이뤄져야 한다. 전문의 총원과 교대제 도입, 보안/응급체계 확립 등을 가장 먼저 집중 실행한다.

- 2순위 - 환자 유입 전략:

수요 없이 공급을 늘릴 수는 없다. 지역사회 홍보와 네트워크 형성을 조기에 추진하여, 운영 확대와 동시에 환자들이 이용하도록 유도한다. 특히 협력의원 의뢰체계 구축과 커뮤니티 홍보는 단기 단계에서 최우선 실행하여 환자풀(pool)을 확보한다.

- 3순위 - 정부/재정 지원 확보:

초기에는 비용 부담이 크므로 가용한 지원금 및 제도 혜택을 최대화하는 것이 중요하다. 야간진료 시범사업 참여, 지자체 예산 지원, 각종 보조사업 신청을 단기부터 적극 추진하여 재정적 쿠션을 마련한다.

- 4순위 - 단계적 접근:

모든 것을 한꺼번에 시행하지 않고 단계별로 우선과제를 실행한다. 우선순위가 높은 인력/홍보/지원 확보를 마친 후, 안정화 단계에서 추가 서비스 확장과 시설 투자를 진행한다. 이렇게 순차적으로 로드맵을 밟아가는 전략이 위험을 줄이고 성공 가능성을 높일 것이다.

- 5순위 - 품질 및 평판 관리:

운영이 궤도에 오른 후에는 의료의 질과 병원 평판 유지가 핵심이다. 이는 장기적으로 가장 중요한 요소이므로, 서비스 품질지표 모니터링과 지속적인 커뮤니케이션으로 환자 신뢰를 지키는 데 최종 우선순위를 둔다.

이상의 로드맵에 따라 단계별로 착실히 실행한다면, 메디피아산부인과병원은 환자 접근성 향상, 지역 의료허브 도약, 수익성 강화라는 세 가지 전략 목표를 모두 달성할 수 있을 것이다.

즉각 실행해야 할 핵심 포인트는 인력·안전 기반 구축과 지역협력망 형성이며, 이를 바탕으로 서비스를 확장하고 지원을 끌어오면서병원의 위상을 높여나가는 것이 바람직한 순서다.

병원장은 이 계획을 토대로 우선순위에 맞춰 자원을 배분하고 실행상황을 점검함으로써, 장기적으로 지역사회에 공헌하면서도 경제적으로 지속 가능한 24시간 의료체계를 구축해나갈 수 있을 것이다. ([늦은밤 아프면 참아야?...밤에도 문 여는 병원 ‘있다’ - 국민이 말하는 정책 | 뉴스 | 대한민국 정책브리핑](#))

✓ PPT 슬라이드 구성 요약 (10장)

메디피아산부인과병원 365일 야간·휴일진료

1. 제목 슬라이드

- 제목:메디피아산부인과병원 365일 야간·휴일진료 확대 실행방안
- 부제:접근성 강화 · 지역 의료허브 도약 · 수익성 향상 전략
- 병원 로고 + 원장님 성함 및 날짜

2. 현황 및 필요성

- 현재 운영 체계
 - 평일 1821사 / 토 21사 / 월 918시 진료
 - 365일 24시간 당직 전문의 진료, 수술·입원·검사 가능
- 필요성:
 - 야간 진료 수요 증가
 - 타 병원 대비 경쟁력 우위
 - 지역 응급 분만 대응 거점 필요
 - 고령 산모·직장인 산모의 진료 불편 해소

3. 목표 및 비전

- VISION:“24시간 신뢰받는 여성의료 허브 병원”
- 핵심목표:
 1. 환자 접근성 향상
 2. 지역 의료허브 기능 확립
 3. 수익성 강화
- 정량목표 예시:
 - 야간 환자 50% 증가
 - 분만 환자 70% 점유
 - 연매출 20% 상승

4. 벤치마킹 사례

- 국내:
 - 평택 성세병원 → 소아 야간진료 성공, 평균 150명/일
 - 달빛어린이병원: 정부지원 월 1,500만원+
- 해외:
 - 미국 OB 전담 응급실 모델
 - 영국 GP 연장진료 → 응급실 방문 26% 감소

5. 진료 확장 전략

- 시간대별 전략:
 - 저녁(18~24시): 연장외래
 - 심야(00~08시): 응급·대기 진료
- 과별 운영:
 - 산과: 분만·출혈 등 응급 클리닉
 - 부인과: 통증·감염 등 경증 클리닉
 - 중장기: 소아청소년과 병행 검토

6. 인력 및 조직 운영방안

- 야간전담 전문의팀 구축
 - 순환근무제 or 전담 의사 채용
- 교대조직:
 - 간호사 3교대 / 검사·행정 교대
 - 마취·소아과 협진 또는 콜 체계
- 복지:
 - 야간수당, 교통비 지원, 휴게공간 등

7. 시설 및 시스템 인프라 강화

- 진료환경 정비:
 - 야간 응급 클리닉 / 보안출입시스템
- 장비:
 - POCT 장비 / 야간 초음파 / 응급약 키트
- IT 시스템:
 - 원격협진, EMR 원격접속, 자동알림 등

8. 수익성 확보 전략

- 보험 수가:
 - 야간·공휴일 가산, 분만·응급 수술수가
- 비급여 수익:
 - 초음파, 무통분만, 고급 병실, 산후 프로그램
- 정부지원:
 - 달빛병원 제도 참여, 지역보건 시범사업
- 수익 모델:
 - 환자 확대 → 분만·수술 증가 → 매출 상승

9. 지역 연계 및 홍보 전략

- 연계 네트워크:
 - 인근 산부인과 / 응급실 / 119 협력
- 홍보 채널:
 - 맘카페, SNS, 지역언론, 산모교육
- 브랜드 이미지:
 - “밤에도 문 여는 병원”, “산모지킴이 병원”

10. 단계별 실행 로드맵 (1~3년)

- 단기(0~1년):
 - 시범운영, 인력확보, 시설정비, 홍보 개시
- 중기(1~3년):
 - 24시 운영 정착, 서비스 확장, 공공지정 시도
- 장기(3년~):
 - 광역 허브병원 도약, NICU/조리원 확장
- 우선과제:
 1. 인력 및 안전 기반
 2. 환자 유입
 3. 정부 지원 확보

추가 제공 가능:

- 각 슬라이드에 들어갈 시각자료 (도식/아이콘)
- 슬라이드용 텍스트 초안 (PowerPoint 또는 Google Slides)

- 요청 시 직접 ****PPT 파일 형태(.pptx)****로 제작하여 제공 가능

원하신다면 실제 **PPT 디자인 작업**으로도 정리해드릴 수 있습니다. 필요하시면 알려주세요!